Perfil V3 · código por código

Cirugía General y Anestesia

Los 155 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Cirugía General y Anestesia, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 59 códigos

4.01.1.001 Patología glándulas salivales

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.19 Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

QUÉ HAY QUE SABER

- Sialolitiasis (submandibular ~80%): dolor y aumento de volumen de la glándula al comer (cólico salival); cálculo palpable en piso de boca o visible en ecografía.
- Sialoadenitis bacteriana aguda (S. aureus): parótida dolorosa, eritematosa, con pus por el conducto de Stenon; típica en adulto mayor deshidratado o postoperado. Parotiditis viral (urleana): bilateral, sin pus.
- Tumores: la mayoría parotídeos y benignos (adenoma pleomorfo > Warthin). Sospechar malignidad si crecimiento rápido, dolor, fijación, adenopatías o parálisis facial.
- Manejo inicial: hidratación, sialogogos (limón), calor local, masaje y analgesia; en bacteriana, cloxacilina o amoxicilina-ácido clavulánico. Nunca biopsia incisional de masa parotídea.
- Seguimiento: derivar a cirugía de cabeza y cuello/ORL toda masa salival persistente (punción con aguja fina y eventual parotidectomía) y litiasis recurrente.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 45 años consulta por aumento de volumen submandibular derecho, doloroso, que aparece al comer y cede en 1 a 2 horas, de 3 meses de evolución. Al examen se palpa la glándula submandibular aumentada de tamaño y una induración en el piso de la boca. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Parotiditis viral
> **B)** Adenoma pleomorfo
> **C)** Sialolitiasis submandibular
> **D)** Linfadenitis cervical bacteriana
> **E)** Síndrome de Sjögren
>
> Respuesta C. El dolor y aumento de volumen glandular desencadenados por la comida (cólico salival) son típicos de sialolitiasis, que afecta principalmente a la glándula submandibular por su saliva más espesa y su conducto ascendente (Wharton). El adenoma pleomorfo es indoloro y no cambia con la ingesta.

4.01.1.002 Divertículos esofágicos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Divertículo de Zenker (faringoesofágico, por pulsión sobre el triángulo de Killian): adulto mayor con disfagia alta, regurgitación de alimentos no digeridos, halitosis, gorgoteo cervical y aspiración.
- Divertículos medioesofágicos (tracción, por adenopatías TBC/mediastínicas) suelen ser asintomáticos; epifrénicos (pulsión) se asocian a trastornos motores como acalasia.
- Estudio de elección: esofagograma baritado (EED). La endoscopía debe ser cuidadosa por riesgo de perforar el divertículo.
- Banderas rojas: neumonía aspirativa recurrente, baja de peso, hemorragia o sospecha de cáncer en el saco.
- Manejo inicial: dieta blanda, comer erguido, prevenir aspiración. Seguimiento: derivar a cirugía (miotomía cricofaríngea con diverticulectomía o tratamiento endoscópico) si es sintomático.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 78 años, autovalente, con disfagia alta, regurgitación de alimentos no digeridos, halitosis y 2 neumonías aspirativas en el último año. El esofagograma con bario confirma un divertículo de Zenker de 4 cm. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Observación y dieta blanda
B) Omeprazol a permanencia
C) Dilatación endoscópica con balón
D) Miotomía del cricofaríngeo con resección o sección endoscópica del divertículo
E) Gastrostomía definitiva

Respuesta D. El Zenker sintomático, sobre todo con aspiración, se trata con cirugía: la clave es la miotomía del cricofaríngeo, asociada a diverticulectomía o a diverticulotomía endoscópica. Ni los IBP ni la dilatación corrigen el mecanismo. Ojo: la endoscopía o la sonda a ciegas pueden perforar el divertículo.

4.01.1.003 Divertículo de Meckel

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Regla de los 2: 2% de la población, a 2 pies (60 cm) de la válvula ileocecal, 2 pulgadas de largo, síntomas antes de los 2 años; divertículo verdadero (todas las capas) por persistencia del conducto onfalomesentérico.
- Presentación típica: hemorragia digestiva baja indolora en niño (mucosa gástrica ectópica que ulcera el íleon), rojo oscuro o «jalea de grosella».
- Otras formas: obstrucción intestinal (vólvulo, invaginación, banda), diverticulitis que simula apendicitis, hernia de Littré.
- Diagnóstico: cintigrafía con Tc-99m pertecnetato (capta mucosa gástrica ectópica); en sangrado activo, angiografía; muchas veces hallazgo intraoperatorio.
- Manejo inicial: estabilizar (accesos venosos, volumen, transfusión si corresponde), régimen cero. Seguimiento: derivar a cirugía pediátrica para resección del divertículo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 2 años, previamente sano, con rectorragia abundante de sangre rojo oscura, indolora. Está pálido, con FC 140 por minuto, abdomen blando e indoloro. La endoscopía digestiva alta es normal. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico más probable?**

A) Colonoscopía
B) Ecografía abdominal
C) Cintigrafía con pertecnetato de tecnecio 99m
D) Enema baritado
E) Radiografía simple de abdomen

Respuesta C. Hemorragia digestiva baja abundante e indolora en un niño pequeño sugiere divertículo de Meckel con mucosa gástrica ectópica, que ulcera el íleon vecino. La cintigrafía con pertecnetato detecta esa mucosa. El tratamiento es la resección quirúrgica. Regla de los 2: 2 % de la población, a 2 pies de la válvula ileocecal, síntomas antes de los 2 años.

4.01.1.004 Acalasia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

QUÉ HAY QUE SABER

- Acalasia: falta de relajación del esfínter esofágico inferior y aperistalsis por pérdida de plexo mientérico; disfagia a sólidos y líquidos desde el inicio, regurgitación, baja de peso lenta.
- En Chile considerar enfermedad de Chagas (megaesófago) en paciente de zonas endémicas del norte o con familiares afectados.
- Esofagograma: dilatación esofágica con afinamiento distal en «pico de pájaro». Endoscopía obligatoria para descartar pseudoacalasia (cáncer de cardias).
- Confirmación: manometría esofágica (de alta resolución; clasificación de Chicago tipos I-III).

- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía para dilatación neumática, miotomía de Heller laparoscópica con funduplicatura o POEM; toxina botulínica en no candidatos. Mayor riesgo de cáncer escamoso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 46 años con 8 meses de dificultad para tragar, más marcada con líquidos que con sólidos y de carácter fluctuante. Ha tenido 2 neumonías basales derechas en el último año y regurgita de noche alimentos sin sabor ácido. No ha bajado de peso. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A) Endoscopía digestiva alta con biopsia
B) Manometría esofágica
C) pH-metría esofágica de 24 horas
D) TAC de tórax con contraste
E) Prueba terapéutica con omeprazol por 8 semanas

Respuesta B. Disfagia ilógica (líquidos, fluctuante) + neumonías aspirativas + regurgitación no ácida = acalasia. La manometría confirma: aperistalsis y EEI hipertónico que no relaja. La endoscopía se hace igual para descartar pseudoacalasia, pero no confirma el trastorno motor.

4.01.1.005 Cáncer del esofágo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago · Tema 1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante disfagia progresiva (primero sólidos, luego líquidos), baja de peso, odinofagia, hematemesis o disfonía en mayor de 50 años: endoscopía alta con biopsia urgente.
- Escamoso (tercio medio, asociado a tabaco, alcohol, bebidas muy calientes, acalasia, cáusticos) vs adenocarcinoma (tercio distal, asociado a ERGE y esófago de Barrett, obesidad).
- Etapificación: TAC de tórax-abdomen-pelvis, endosonografía y PET-CT. Signos de irresecabilidad: disfonía (nervio laríngeo recurrente), fístula traqueoesofágica, metástasis.
- Manejo inicial: soporte nutricional (puede requerir sonda o gastrostomía), manejo del dolor, IBP. Cáncer esofágico incluido en GES (≥15 años) con confirmación y tratamiento garantizados.
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva/oncología (esofagectomía con quimiorradioterapia neoadyuvante, stent paliativo en irresecables). Barrett requiere vigilancia endoscópica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años, fumador de 40 paquetes-año y bebedor intenso, con 3 meses de disfagia progresiva, primero para sólidos y ahora también para papillas, con baja de 9 kg. Al examen está enflaquecido, sin adenopatías palpables. **¿Cuál es el examen que confirma el diagnóstico más probable?**

A) Endoscopía digestiva alta con biopsias
B) Esofagograma con bario
C) Manometría esofágica
D) TAC de tórax y abdomen
E) PET-CT

Respuesta A. Disfagia lógica y progresiva con baja de peso en un fumador y bebedor sugiere cáncer escamoso de esófago. El diagnóstico se confirma con endoscopía y biopsia; la TAC y el PET-CT sirven después para etapificar, y el esofagograma solo orienta.

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años, obeso, con 15 años de pirosis mal controlada. La endoscopía muestra una lesión ulcerada y estenosante en el tercio distal del esófago, cercana a la unión gastroesofágica. **Si la biopsia confirma un cáncer, ¿cuál es el tipo histológico más probable y su principal factor de riesgo?**

A) Carcinoma escamoso; tabaco y alcohol
B) Adenocarcinoma; esófago de Barrett por reflujo crónico
C) Adenocarcinoma; infección por Helicobacter pylori
D) Carcinoma escamoso; acalasia
E) Linfoma; inmunosupresión

Respuesta B. El adenocarcinoma se ubica en el tercio distal y nace sobre un esófago de Barrett, consecuencia del reflujo crónico; la obesidad también es factor de riesgo. El escamoso predomina en los tercios superior y medio y se asocia a tabaco, alcohol, cáusticos y acalasia. H. pylori no causa cáncer esofágico.

4.01.1.006 Hernia hiatal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia hiatal por deslizamiento (tipo I, >90%): unión gastroesofágica sobre el diafragma; se asocia a ERGE (pirosis, regurgitación). Paraesofágica (tipo II-IV): fondo gástrico herniado con UGE en su lugar.
- Diagnóstico: endoscopía alta (también evalúa esofagitis y Barrett) o esofagograma; frecuentemente hallazgo en radiografía (nivel hidroaéreo retrocardíaco).
- Tratamiento inicial del deslizamiento: medidas generales (bajar de peso, elevar cabecera, evitar comidas copiosas y nocturnas) e IBP (omeprazol 20-40 mg/día).
- Banderas rojas en paraesofágica: dolor torácico intenso, vómitos sin poder vomitar, disfagia aguda o anemia: vólvulo gástrico o estrangulación, urgencia quirúrgica (tríada de Borchardt).
- Seguimiento: derivar a cirugía para funduplicatura de Nissen si ERGE refractaria o complicada y para toda hernia paraesofágica sintomática.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 72 años con plenitud y dolor torácico después de comer, más anemia ferropénica. La endoscopía y el estudio con bario muestran una hernia hiatal paraesofágica (tipo II), con el fondo gástrico en el tórax y la unión gastroesofágica en su posición normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Omeprazol a permanencia y control clínico
B) Observación, ya que es frecuente en adultos mayores
C) Reparación quirúrgica electiva
D) Dilatación endoscópica
E) Proquinéticos y medidas posturales

Respuesta C. La hernia paraesofágica sintomática tiene indicación quirúrgica por el riesgo de vólvulo, estrangulación y sangrado por lesiones de Cameron, que explican la anemia. La hernia por deslizamiento (tipo I), en cambio, se maneja como reflujo con IBP y solo se opera si fracasa el tratamiento médico.

4.01.1.007 Tumores gástricos benignos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipos gástricos: hiperplásicos (asociados a H. pylori y gastritis), de glándulas fúndicas (uso prolongado de IBP), adenomatosos (potencial maligno, extirpar).
- GIST: tumor submucoso más frecuente del tubo digestivo (estómago ~60%), CD117/c-KIT positivo; puede presentarse con hemorragia digestiva alta o masa; riesgo según tamaño e índice mitótico.
- Otros submucosos: leiomioma, lipoma, páncreas ectópico. La mayoría asintomáticos y diagnosticados por endoscopía incidental.
- Estudio: endoscopía con biopsia, endosonografía para lesiones submucosas, TAC para extensión. Erradicar H. pylori si está presente.

- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía para polipectomía endoscópica o resección; GIST se reseca con márgenes y puede requerir imatinib.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 58 años, en estudio por dispepsia, se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra un pólipo sésil de 2 cm en el antro. La biopsia informa adenoma tubular con displasia de bajo grado. Test de ureasa negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Control endoscópico en 5 años
> **B)** Erradicación de Helicobacter pylori y alta
> **C)** Gastrectomía subtotal
> **D)** Inhibidor de bomba de protones y control en 1 año
> **E)** Resección endoscópica completa del pólipo
> Respuesta E. Los pólipos adenomatosos gástricos son lesiones premalignas: deben resecarse completos por vía endoscópica para obtener la histología definitiva, seguidos de vigilancia endoscópica. La gastrectomía es excesiva para un adenoma sin cáncer invasor, y el simple control deja una lesión con riesgo de transformación maligna.

4.01.1.008 Cáncer gástrico

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene una de las tasas más altas de cáncer gástrico; principal causa de muerte por cáncer en hombres. Factores: H. pylori, gastritis atrófica, tabaco, dieta salada, familiar de primer grado.
- Síntomas tardíos: epigastralgia, baja de peso, anemia ferropénica, saciedad precoz, vómitos (obstrucción pilórica), hemorragia digestiva; signos de diseminación: ganglio de Virchow, Sister Mary Joseph, Blumer, Krukenberg.
- GES: endoscopía alta con biopsia en ≥40 años con epigastralgia de más de 15 días; también ante síntomas de alarma a cualquier edad.
- Manejo inicial: confirmar con endoscopía + biopsia, corregir anemia y estado nutricional; erradicar H. pylori en familiares y en lesiones premalignas.
- Seguimiento: derivar a cirugía digestiva (gastrectomía con linfadenectomía D2; resección endoscópica en cáncer incipiente) y oncología; etapificación con TAC.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 55**
> Paciente con antecedente de cáncer gástrico avanzado, con metástasis hepáticas múltiples y adenopatías perigástricas, consulta por vómitos postprandiales intensos, que han ido en aumento y actualmente dificultan mucho la alimentación. Al examen físico está muy enflaquecido, sin panículo adiposo y con edema de extremidades inferiores. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Instalar sonda nasogástrica
> **B)** Indicar nutrición parenteral total
> **C)** Realizar radioterapia de urgencia
> **D)** Realizar gastrectomía paliativa
> **E)** Realizar derivación gastrointestinal
> Respuesta E. Es una obstrucción de la salida gástrica por un cáncer incurable. La paliación busca restablecer el tránsito con la menor morbilidad: una gastroyeyunoanastomosis (o una prótesis endoscópica) es menos agresiva que la gastrectomía paliativa. La sonda nasogástrica y la nutrición parenteral son medidas transitorias que no resuelven la obstrucción.

4.01.1.009 Tumores del intestino delgado

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- Raros (<5% de tumores digestivos). Benignos: adenomas, leiomiomas, lipomas, hamartomas (Peutz-Jeghers). Malignos: adenocarcinoma (duodeno), neuroendocrino (íleon), linfoma, GIST.

- Presentación: dolor abdominal vago, hemorragia digestiva oscura u oculta con anemia, obstrucción intermitente o invaginación en adulto (cabeza de invaginación tumoral).
- Síndrome carcinoide (rubor, diarrea, broncoespasmo, valvulopatía derecha) indica tumor neuroendocrino con metástasis hepáticas; medir 5-HIAA urinario.
- Estudio: TAC/enteroTAC, cápsula endoscópica o enteroscopía; endoscopía alta para lesiones duodenales.
- Manejo inicial: corregir anemia, manejar obstrucción (régimen cero, SNG, hidratación). Seguimiento: derivar a cirugía/gastroenterología para resección segmentaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años presenta anemia ferropénica, test de hemorragia oculta positivo y episodios intermitentes de melena. Una endoscopía digestiva alta y una colonoscopía completa, con buena preparación, son normales. **¿Cuál es el siguiente examen más adecuado?**

A) Repetir la colonoscopía en 3 años
B) Enema baritado
C) Cápsula endoscópica
D) Ecografía abdominal
E) Laparotomía exploradora

Respuesta C. Con endoscopía alta y colonoscopía normales, el sangrado probablemente proviene del intestino delgado (angiodisplasias o tumores como GIST, adenocarcinoma o neuroendocrinos). La cápsula endoscópica es el examen de elección para estudiarlo, y puede seguirse de enteroscopía o enteroTAC. Una laparotomía sin localización previa no corresponde.

4.01.1.011 Fístulas del intestino delgado

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Fístula enterocutánea: salida de contenido intestinal por la piel, la mayoría postoperatoria (filtración anastomótica); otras causas: Crohn, radiación, cáncer, cuerpo extraño.
- Débito alto (>500 ml/día) se asocia a deshidratación, hipokalemia, acidosis metabólica y desnutrición; las proximales (duodeno, yeyuno) son más graves.
- Factores que impiden el cierre espontáneo (FRIENDS): cuerpo extraño, radiación, inflamación/infección, epitelización, neoplasia, obstrucción distal, trayecto corto (<2 cm).
- Manejo inicial SNORA: control de sepsis (drenar colecciones), nutrición (parenteral si alto débito), proteger la piel (ostomía/bolsa), reponer volumen y electrolitos; octreótido puede reducir débito.
- Seguimiento: derivar a cirugía; la mayoría cierra con manejo conservador en 4-6 semanas, si no, cirugía diferida (≥3 meses).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años, al quinto día de una resección intestinal por obstrucción, presenta salida de contenido bilioso por la herida operatoria, de aproximadamente 600 mL al día. Está afebril, hemodinámicamente estable y sin signos de peritonitis difusa. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Reoperación inmediata para cierre de la fístula
B) Régimen liviano y alta con curaciones
C) Reposo digestivo, reposición hidroelectrolítica, nutrición parenteral y protección de la piel
D) Solo antibióticos de amplio espectro
E) Sonda nasogástrica y alta precoz

Respuesta C. Una fístula enterocutánea de alto débito (más de 500 mL al día) sin sepsis se maneja inicialmente en forma conservadora: reposo digestivo, corrección de volumen y electrolitos, nutrición parenteral, control del débito y cuidado de la piel. Muchas cierran espontáneamente; reoperar precozmente un abdomen inflamado tiene alta morbilidad.

4.01.1.012 Megacolon

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad de Hirschsprung: ausencia de células ganglionares en recto-sigmoides; retraso en eliminación de meconio >48 h, distensión, vómitos, constipación severa desde el nacimiento; tacto rectal con salida explosiva de deposiciones.
- Diagnóstico: enema baritado (zona de transición) y confirmación con biopsia rectal por succión (aganglionosis, aumento de acetilcolinesterasa); manometría sin reflejo rectoanal inhibitorio.
- Megacolon adquirido en adulto: chagásico (zonas endémicas del norte de Chile), constipación crónica, fármacos. Megacolon tóxico: complicación de colitis ulcerosa o C. difficile, colon transverso >6 cm con toxicidad sistémica.
- Bandera roja: enterocolitis de Hirschsprung (fiebre, distensión, diarrea fétida) y vólvulo de sigmoides (más frecuente en megacolon chagásico).
- Manejo inicial: régimen cero, SNG, hidratación, descompresión rectal; en megacolon tóxico antibióticos y corticoides IV. Seguimiento: derivar a cirugía (pediátrica o coloproctología).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 112

Recién nacido de término, de 5 días de vida, aún no ha eliminado meconio. Además presenta irritabilidad, vómitos postprandiales frecuentes y distensión abdominal. Al examen tiene ano permeable. Se realiza un enema baritado, que muestra colon proximal dilatado y colon distal estrecho. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) TAC abdominal
B) Colonoscopía
C) Test del sudor
D) Biopsia rectal por succión
E) Cariograma

Respuesta D. Retraso en la eliminación de meconio, distensión y una zona de transición en el enema (colon distal estrecho y proximal dilatado) sugieren enfermedad de Hirschsprung. Se confirma con biopsia rectal por succión que demuestra ausencia de células ganglionares. El test del sudor se plantea ante un íleo meconial por fibrosis quística.

4.01.1.013 Enfermedad diverticular no complicada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulosis: herniación de mucosa a través de la pared del colon, sobre todo sigmoides en Occidente; asociada a dieta pobre en fibra, edad y constipación. Mayoría asintomática (hallazgo en colonoscopía).
- Enfermedad diverticular sintomática no complicada: dolor en fosa ilíaca izquierda recurrente, distensión y cambios del hábito, sin fiebre ni signos peritoneales.
- Tratamiento: dieta rica en fibra (25-35 g/día), aumento de ingesta de agua, actividad física; no es necesario evitar semillas. Analgésicos y antiespasmódicos según síntomas.
- Diverticulitis no complicada leve (dolor FII, fiebre baja, sin peritonitis): manejo ambulatorio con dieta líquida y antibióticos opcionales (amoxicilina-clavulánico o ciprofloxacino + metronidazol) en inmunocompetente.
- Seguimiento completo: control clínico en APS, colonoscopía tras un episodio de diverticulitis (6-8 semanas) para descartar cáncer; derivar si complicaciones o episodios recurrentes con mala calidad de vida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años, asintomático, se realiza una colonoscopía de tamizaje que muestra múltiples divertículos en el colon sigmoides, sin signos inflamatorios ni otras lesiones. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A) Sigmoidectomía electiva
B) Colonoscopía de control anual
C) Ciprofloxacino y metronidazol por 7 días
D) Evitar estrictamente semillas y frutos secos
E) Dieta rica en fibra, sin controles específicos por los divertículos

Respuesta E. La diverticulosis asintomática no requiere tratamiento ni seguimiento específico; se recomienda dieta rica en fibra, actividad física y evitar el sobrepeso. No hay evidencia para restringir semillas o frutos secos, y la cirugía electiva no está indicada en la enfermedad no complicada.

4.01.1.014 Pólipos de colon y recto

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Pólipos adenomatosos (tubular < tubulovelloso < velloso en riesgo) son precursores del cáncer colorrectal; riesgo mayor si >1 cm, componente velloso o displasia de alto grado.
- Hiperplásicos pequeños de recto-sigmoides: bajo riesgo. Serrados sésiles: vía serrada, potencial maligno.
- Generalmente asintomáticos; pueden dar rectorragia o sangre oculta en deposiciones positiva. Síndromes hereditarios: poliposis adenomatosa familiar (cientos de pólipos, colectomía profiláctica), Lynch, Peutz-Jeghers.
- Pesquisa: test de sangre oculta inmunológico (FIT) desde los 50 años o colonoscopía; antecedente familiar de primer grado: colonoscopía desde los 40 años o 10 años antes del caso índice.
- Seguimiento: derivar a colonoscopía con polipectomía y vigilancia según histología (3-5 años en adenomas avanzados o múltiples).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una colonoscopía realizada a un hombre de 28 años con antecedentes familiares de cáncer de colon se describen más de 150 pólipos distribuidos por todo el colon y el recto. Varias biopsias muestran adenomas tubulares con displasia de bajo grado. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Polipectomía endoscópica de los pólipos mayores y control anual
B) Colectomía total (proctocolectomía) profiláctica
C) Quimioprevención con AINE y seguimiento
D) Control con CEA seriado cada 6 meses
E) Colonoscopía de control en 3 años

Respuesta B. Cientos de pólipos adenomatosos en un joven con historia familiar: poliposis adenomatosa familiar, que evoluciona a cáncer en prácticamente el 100 % si no se interviene. La conducta es la colectomía total profiláctica; la polipectomía es inviable por el número de lesiones y no elimina el riesgo.

4.01.1.015 Cáncer colorectal

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante rectorragia, cambio del hábito intestinal, anemia ferropénica (sobre todo en hombre o mujer posmenopáusica), baja de peso o masa abdominal en ≥50 años.
- Colon derecho: anemia y masa; colon izquierdo: obstrucción y cambio de calibre de deposiciones; recto: pujo, tenesmo, rectorragia.
- Confirmación: colonoscopía completa con biopsia; etapificación con TAC tórax-abdomen-pelvis, RM pélvica en recto y CEA basal.
- GES: cáncer colorrectal en ≥15 años (confirmación, tratamiento y seguimiento). Factores: adenomas, EII, Lynch, PAF, antecedente familiar, obesidad, carnes procesadas.
- Manejo inicial: corregir anemia, estudio; obstrucción o perforación son urgencia quirúrgica. Seguimiento: derivar a cirugía coloproctológica y oncología (colectomía, quimioterapia; neoadyuvancia en recto).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años con 4 meses de constipación progresiva que antes no tenía, deposiciones más delgadas y episodios de rectorragia escasa. Hemograma: anemia microcítica hipocroma con ferritina baja. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Test de sangre oculta inmunoquímico
B) Solicitar CEA para confirmar el diagnóstico
C) Colonoscopía total con biopsia
D) Fibra, laxantes y sulfato ferroso, control en 3 meses
E) TAC de abdomen como examen diagnóstico inicial

Respuesta C. Constipación reciente, deposiciones acintadas, rectorragia y anemia ferropénica en una adulta mayor: cáncer colorrectal hasta demostrar lo contrario. Se confirma con colonoscopía total y biopsia; el test de sangre oculta es tamizaje de asintomáticos y el CEA solo sirve para el seguimiento. Luego se etapifica con TAC.

4.01.1.016 Hemorroides - fisura anal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas · Tema 2.6 Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorroides internas (sobre línea pectínea, indoloras): rectorragia roja rutilante que cubre deposiciones y prolapso; grados I-IV según prolapso y reducción. Externas: dolor intenso si se trombosan.
- Fisura anal: dolor intenso al defecar que persiste minutos-horas y rectorragia escasa; en línea media posterior. Aguda <6 semanas; crónica con papila hipertrófica, colgajo centinela y fibras del esfínter visibles.
- Diagnóstico específico: inspección anal, tacto rectal (si tolera) y anoscopía; fisura fuera de línea media obliga a descartar Crohn, TBC, VIH, sífilis o cáncer.
- Tratamiento médico: fibra 25-30 g/día, agua, baños de asiento tibios, evitar pujo; fisura: nifedipino 0,2-0,3% o nitroglicerina tópica 6-8 semanas y lidocaína tópica. Hemorroide externa trombosada <72 h: trombectomía con anestesia local.
- Seguimiento: control en APS; derivar a coloproctología hemorroides grado III-IV o refractarias (ligadura elástica, hemorroidectomía) y fisura crónica refractaria (toxina botulínica, esfinterotomía lateral interna). En >50 años con rectorragia, colonoscopía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 27

Paciente de 52 años con hemorroides externas trombosadas desde hace 6 horas, violáceas, protruidas, irreducibles y muy dolorosas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Hemorroidectomía de urgencia
B) Trombectomía hemorroidal bajo anestesia local
C) Ligadura con banda elástica
D) Manejo médico conservador con analgesia y baños de asiento
E) Escleroterapia

Respuesta B. Hemorroides externas trombosadas dentro de las primeras 72 horas: la trombectomía bajo anestesia local alivia el dolor de inmediato. Pasado ese plazo, el trombo se reabsorbe solo y el manejo pasa a ser conservador.

4.01.1.017 Abscesos y fístulas ano rectales

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas · Tema 2.6 Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso anorrectal: dolor perianal continuo, pulsátil, que impide sentarse, con aumento de volumen eritematoso y fluctuante y fiebre; origen criptoglandular. Tipos: perianal, isquiorrectal, interesfintérico, supraelevador.
- Abscesos profundos (supraelevador, interesfintérico) dan dolor rectal y fiebre sin signos externos: tacto rectal doloroso y TAC/RM para confirmar.
- Tratamiento inicial: drenaje quirúrgico precoz (no esperar fluctuación); antibióticos solo si celulitis extensa, inmunosupresión, diabetes, valvulopatía o sepsis.

- Fístula perianal: secuela del absceso en ~30-50%; orificio externo con secreción crónica. Regla de Goodsall orienta al orificio interno. Descartar Crohn si múltiples o recurrentes.
- Seguimiento: derivar a coloproctología (fistulotomía, sedal, colgajo); gangrena de Fournier es urgencia quirúrgica con desbridamiento amplio y antibióticos de amplio espectro.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años consulta por 2 días de dolor perianal continuo, pulsátil, que le impide sentarse, con sensación febril. Al examen, en el cuadrante posterolateral izquierdo se aprecia una masa de 3 cm, eritematosa, indurada, caliente y muy dolorosa a la palpación, sin fluctuación evidente. Temperatura 37,9 grados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar ciprofloxacino más metronidazol oral y control en 5 días
B) Realizar drenaje quirúrgico bajo anestesia, sin esperar más
C) Indicar antiinflamatorios y baños de asiento
D) Solicitar ecografía transrectal antes de decidir
E) Puncionar con aguja fina en el policlínico

Respuesta B. Dolor perianal pulsátil, continuo y progresivo con masa indurada y eritematosa es un absceso perianal, incluso sin fluctuación clara todavía. La conducta es el drenaje quirúrgico inmediato; esperar antibióticos o una imagen retrasa el control del foco y favorece la extensión de la infección.

Pregunta de práctica

Hombre de 38 años con dolor anal que ha ido aumentando durante 4 días, ahora intenso e invalidante, con fiebre de 38 °C. Al examen: tumoración perianal eritematosa, caliente y fluctuante a las 5 del reloj, sin nódulo violáceo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Baños de asiento y laxantes osmóticos
B) Antibióticos orales y control en 48 horas
C) Trombectomía ambulatoria
D) Drenaje quirúrgico en pabellón
E) Esfinterotomía lateral interna

Respuesta D. Dolor anal progresivo, masa eritematosa fluctuante y fiebre: absceso perianal. Se trata con drenaje quirúrgico en pabellón; los antibióticos solos no resuelven la colección. La fluctuación y la ausencia de nódulo violáceo lo separan del hemorroide externo trombosado.

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años consulta porque desde hace 3 meses tiene un pequeño orificio en la piel de la región glútea, cercano al ano, que supura material purulento de forma intermitente. Tuvo un absceso perianal drenado hace 4 meses. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Fisura anal crónica; baños de asiento
B) Fístula anal; tratamiento quirúrgico
C) Hidradenitis supurativa; antibióticos prolongados
D) Hemorroide interno grado IV; ligadura elástica
E) Quiste pilonidal; observación

Respuesta B. Orificio cutáneo perianal que supura de forma crónica tras un absceso drenado: fístula anal, trayecto entre el canal anal y la piel. Tratamiento quirúrgico (fistulotomía o sedal). Error clásico: confundirla con la fisura, herida dolorosa de manejo médico.

4.01.1.018 Enfermedades del seno pilonidal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad pilonidal: inflamación crónica por pelos incrustados en el surco interglúteo sacrococcígeo; típico en hombre joven, hirsuto, sedentario u obeso.
- Formas: asintomática (fositas en línea media), absceso pilonidal agudo (dolor, aumento de volumen fluctuante, fiebre) y sinus crónico con secreción intermitente.
- Absceso agudo: drenaje con incisión lateral a la línea media con anestesia local, aseo y curaciones; antibióticos solo si celulitis o inmunosupresión.
- Enfermedad crónica o recurrente: resección quirúrgica electiva (cierre primario fuera de la línea media tipo Karydakis/Limberg o cierre por segunda intención).

- Seguimiento: curaciones en APS, depilación de la zona (láser o rasurado) e higiene para prevenir recidiva; derivar a cirugía para resección definitiva.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 43

Paciente de 20 años presenta aumento de volumen eritematoso y doloroso en la zona interglútea, a dos centímetros de la línea media, sobre el cóccix. Al examen se observa aumento de volumen de 5 centímetros, doloroso, con dos orificios negros en la piel cerca de la lesión. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma
B) Sarcoma
C) Quiste pilonidal
D) Absceso anorrectal
E) Lipoma

Respuesta C. La ubicación sacrococcígea, sobre la línea media, con orificios puntiformes con pelos, es el cuadro característico del quiste o seno pilonidal, aquí ya en fase inflamatoria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 77

Paciente con absceso interglúteo de 2 centímetros, en buenas condiciones generales. **¿Cuál es la conducta?**

A) Antibióticos exclusivos
B) Drenar
C) Marsupialización
D) Solicitar cultivo antes de cualquier procedimiento
E) Observación

Respuesta B. Todo absceso pilonidal se drena. Los antibióticos se pueden sumar, pero no reemplazan el drenaje; si el cuadro recurre, ahí sí se plantea la extirpación completa del quiste.

Pregunta de práctica

Hombre de 24 años, con vello abundante y sobrepeso, consulta por 2 días de dolor y aumento de volumen en la región sacrococcígea, que empeora al sentarse. Al examen, en la línea interglútea se aprecia una masa de 3 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con un mechón de pelos saliendo por un orificio central. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Resección amplia en bloque del trayecto pilonidal
B) Antibióticos orales por 10 días y control
C) Drenaje quirúrgico simple con incisión lateralizada
D) Solicitar resonancia magnética de pelvis antes de decidir
E) Observación, ya que suele resolver solo

Respuesta C. Masa fluctuante, eritematosa y dolorosa en la región interglútea, con pelos visibles: absceso pilonidal agudo. La conducta es el drenaje quirúrgico simple, con incisión lateralizada y curetaje de pelos; la resección amplia se difiere para cuando ceda la infección.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 19 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 47 años, obeso, consulta por dolor y aumento de volumen en la zona interglútea. Al examen físico se aprecia aumento de volumen en la zona sacra, de con- sistencia balnda, eritematoso y doloroso a la palpación. La conducta más adecuada es:

A) Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local
B) Antibióticos orales
C) Solicitar una ecografía de partes blandas
D) Solicitar resonancia nuclear magnética de pelvis
E) Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar drenaje quirúrgico con anestesia local (opción A). Es un quiste pilonidal infectado. Se debe drenar. Si no se infecta, solo se observa.. La resolución quirúrgica urgente constituye la única medida definitiva capaz de controlar el foco séptico, revertir la isquemia o evitar la muerte materna/fetal frente a este compromiso clínico severo.

4.01.1.019 Cáncer anal

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

QUÉ HAY QUE SABER

- Carcinoma escamoso del canal anal asociado a VPH (16/18), VIH, HSH, inmunosupresión, tabaco y antecedente de neoplasia cervical o condilomas.
- Síntomas: sangrado, dolor anal, masa o úlcera indurada que no cicatriza, prurito, tenesmo; adenopatías inguinales. Se confunde con hemorroides o fisura.
- Toda lesión anal atípica, indurada o que no responde a tratamiento debe biopsiarse; tacto rectal y anoscopía obligatorios.
- Etapificación: RM pélvica, TAC de tórax-abdomen y examen de ganglios inguinales.
- Seguimiento: derivar a coloproctología/oncología; tratamiento de elección es quimiorradioterapia (esquema de Nigro: 5-FU + mitomicina), cirugía de rescate si persiste.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 89

Paciente de 45 años, con diagnóstico de VIH, presenta sangrado rectal ocasional. Al examen físico se observa una lesión solevantada en el margen anal, de 4 cm, que se introduce en el recto sobrepasando la línea pectínea, con ulceración central y escaso sangrado. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorroide externo trombosado
B) Condiloma acuminado
C) Sífilis
D) Cáncer epidermoide
E) Enfermedad de Crohn

Respuesta D. Una lesión indurada, solevantada y ulcerada que cruza la línea pectínea en un paciente con VIH (mayor persistencia del VPH) sugiere carcinoma epidermoide del ano, que debe confirmarse con biopsia. El condiloma es verrucoso y no ulcerado; el chancro sifilítico es más pequeño y de evolución breve.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años, con antecedente de infección de VIH, consulta por una le- sión perianal, de larga data, sin tendencia a la cicatrización. Al examen físico se aprecia una lesión ulcerada, de consistencia aumentada, de 4 cm de diámetro, bordes cartográ- ficos y que se introduce por el ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Sífilis
B) Enfermedad de Cröhn
C) Carcinoma epidermoide
D) Melanoma
E) Tuberculosis

Respuesta C. Diagnóstico: Carcinoma epidermoide (opción C). Es un cáncer de recto clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

4.01.1.020 Fisura anorectal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas · Tema 2.6 Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

QUÉ HAY QUE SABER

- Fisura anal: desgarro del anodermo distal a la línea pectínea, 90% en línea media posterior; causada por paso de deposiciones duras y aumento de tono del esfínter interno.
- Clínica: dolor intenso y lacerante durante y después de defecar, sangre roja escasa en el papel; diagnóstico por inspección separando glúteos (tacto suele ser imposible por dolor).
- Crónica (>6 semanas): úlcera con bordes indurados, fibras del esfínter interno, colgajo centinela y papila hipertrófica. Fisuras laterales o múltiples: pensar en Crohn, TBC, VIH, sífilis o cáncer.
- Tratamiento: fibra y agua abundante, ablandadores, baños de asiento tibios, lidocaína tópica; relajantes del esfínter: nifedipino 0,2% o diltiazem 2% tópico (preferidos) o nitroglicerina 0,2-0,4% (cefalea) por 6-8 semanas; cura ~90% de agudas.
- Seguimiento: control en APS; derivar a coloproctología fisura crónica refractaria para toxina botulínica o esfinterotomía lateral interna (riesgo de incontinencia leve).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 54

Paciente de 54 años consulta por dolor anal que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones ha presentado sangre en las deposiciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorroide externo trombosado
B) Cáncer de recto
C) Fisura anal
D) Fístula anal
E) Absceso perianal

Respuesta C. Dolor que aparece al defecar y persiste después, con algo de sangrado: cuadro clásico de fisura anal. Ni la trombosis ni el absceso duelen así de específicamente ligados a la defecación, y no hay signos de cáncer.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 54

Hombre de 54 años consulta por dolor anal que se presenta al defecar, persistiendo por algunos minutos luego de la defecación. En algunas ocasiones ha presentado sangre en las deposiciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorroide externo trombosado
B) Cáncer de recto
C) Fisura anal
D) Fístula anal
E) Absceso perianal

Respuesta C. Dolor que aparece con la defecación y persiste minutos después, con sangrado escaso: es una fisura anal, por el espasmo del esfínter interno que sigue a cada episodio.

4.01.1.021 Hernias, eventraciones y evisceraciones

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.6 Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones · Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia inguinal indirecta (por anillo inguinal profundo, lateral a vasos epigástricos; la más frecuente en ambos sexos) vs directa (triángulo de Hesselbach, adulto mayor). Femoral: bajo ligamento inguinal, más en mujeres, alto riesgo de estrangulación.
- Diagnóstico clínico: aumento de volumen reductible que protruye con Valsalva; ecografía si duda. Eventración: hernia a través de cicatriz quirúrgica (factores: infección de herida, obesidad, tos, desnutrición).
- Hernia atascada (irreductible) o estrangulada (dolor intenso, eritema, signos de obstrucción o toxicidad): urgencia quirúrgica; no intentar reducir si hay signos de estrangulación.
- Evisceración: salida de vísceras por dehiscencia de laparotomía (día 5-8, precedida por salida de líquido serohemático): cubrir con compresas estériles húmedas con suero, no reducir, pabellón urgente.
- Tratamiento definitivo es quirúrgico (hernioplastía con malla, Lichtenstein o laparoscópica); GES hernia de pared abdominal en 15 años y más. Seguimiento: control de herida, evitar esfuerzos 2-4 semanas.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 144

Una paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, en ocasiones doloroso, asociado a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma
B) Hernia inguinal
C) Adenopatía metastásica
D) Hernia femoral
E) Sarcoma de partes blandas

Respuesta D. El aumento de volumen ubicado por debajo del ligamento inguinal, asociado a síntomas de obstrucción intestinal (náuseas y dolor abdominal), corresponde a una hernia femoral o crural, mucho más frecuente en mujeres y con el mayor riesgo de estrangulación de todas las hernias de la pared abdominal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 144

Paciente de 60 años consulta por aumento de volumen en la cara anterior del muslo, que en ocasiones es doloroso y se asocia a náuseas y dolor abdominal. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Linfoma
B) Hernia inguinal
C) Adenopatía metastásica
D) Hernia femoral
E) Sarcoma de partes blandas

Respuesta D. Aumento de volumen por debajo del ligamento inguinal, con dolor y síntomas digestivos: hernia femoral, más frecuente en mujeres y con mayor riesgo de complicarse que la inguinal.

Pregunta de práctica

Mujer de 68 años, multípara de 5 hijos, consulta por dolor intenso de 10 horas de evolución en una masa de 2 cm en la ingle derecha, por debajo del ligamento inguinal y medial al pulso femoral, irreductible, con la piel algo enrojecida. Tiene náuseas y el abdomen está distendido con ruidos aumentados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Intentar reducción manual suave (taxis) en urgencia
B) Cirugía de urgencia sin intentar reducirla
C) Indicar analgesia y control ecográfico en 48 horas
D) Colocar braguero compresivo y observar
E) Programar hernioplastia electiva en 6 semanas

Respuesta B. Ubicación bajo el ligamento inguinal y medial a la vena femoral: hernia crural, con signos ya de estrangulación (enrojecimiento, dolor intenso, obstrucción). El taxis está formalmente prohibido; la conducta es cirugía de urgencia.

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, obeso y con tos crónica por EPOC, operado hace 6 días de una laparotomía de urgencia por peritonitis apendicular. Mientras tose con fuerza, siente un dolor agudo en el abdomen. Al revisar la herida, el apósito está empapado de líquido serosanguinolento abundante, y se observan asas de intestino delgado protruyendo a través de la herida, con serosa enrojecida pero viable. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Reintroducir las asas manualmente y cerrar la piel con puntos gruesos
B) Cubrir las asas con compresas estériles empapadas en suero tibio y trasladar a pabellón
C) Aplicar un vendaje compresivo seco y mantener observación ambulatoria
D) Instalar un sistema de aspiración negativa directo sobre las asas expuestas
E) Indicar heparina de bajo peso molecular y solicitar un escáner de abdomen

Respuesta B. Es una evisceración aguda, favorecida por la tos crónica y la peritonitis previa. Se cubren las asas con compresas estériles húmedas tibias para evitar su desecación y necrosis, sin intentar reintroducirlas, y se traslada de inmediato a pabellón para el cierre definitivo.

4.01.1.022 Hidatidosis hepática

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Echinococcus granulosus; ciclo perro-oveja, endémico en zonas rurales del sur (Araucanía, Aysén, Magallanes). El hígado es el órgano más afectado (~70%).
- Mayoría asintomáticos por años; síntomas por masa (dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia) o complicaciones: rotura a vía biliar (ictericia, colangitis), a peritoneo o tórax, infección del quiste, anafilaxia.
- Diagnóstico: ecografía (clasificación de Gharbi/OMS: quiste con membrana, vesículas hijas, «arena hidatídica») y TAC; serología (ELISA, Western blot) apoya. No puncionar sin protección por riesgo de anafilaxia y siembra.
- Manejo inicial: albendazol 10-15 mg/kg/día (habitual 400 mg c/12 h) perioperatorio; notificar (enfermedad de notificación obligatoria).
- Seguimiento: derivar a cirugía (quistectomía/periquistectomía o PAIR en casos seleccionados). Prevención: no alimentar perros con vísceras crudas y desparasitarlos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años, criador de ovejas en la Región de Aysén, asintomático. En una ecografía solicitada por otro motivo se detecta un quiste hepático de 8 cm con membranas internas desprendidas y vesículas hijas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Punción diagnóstica percutánea del quiste
B) Biopsia hepática
C) Observación, por estar asintomático
D) Metronidazol y drenaje percutáneo
E) Albendazol perioperatorio y cirugía

Respuesta E. Un quiste con vesículas hijas en zona ganadera es un quiste hidatídico activo; se apoya con serología. Los quistes grandes o complicados se tratan con cirugía y albendazol antes y después, para reducir el riesgo de siembra. La punción sin protección puede causar anafilaxia y diseminación; la técnica PAIR solo en casos seleccionados.

4.01.1.023 Quistes y abscesos hepáticos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Quistes simples hepáticos: frecuentes, benignos, anecoicos en ecografía; no requieren seguimiento salvo síntomas por tamaño. Poliquistosis hepática asociada a poliquistosis renal.
- Absceso hepático piógeno: fiebre, dolor en hipocondrio derecho, leucocitosis y elevación de FA; origen biliar (más frecuente), portal (diverticulitis, apendicitis) o hematógeno. Klebsiella, E. coli, anaerobios.
- Absceso amebiano (E. histolytica): hombre joven, viaje a zona endémica, lesión única en lóbulo derecho; serología positiva y responde a metronidazol sin drenaje en la mayoría.
- Diagnóstico: ecografía o TAC con contraste; hemocultivos. Diferencial con quiste hidatídico (no puncionar sin sospecharlo).
- Manejo inicial: antibióticos IV (ceftriaxona + metronidazol) y derivar para drenaje percutáneo guiado por imagen si >5 cm o sin respuesta; buscar y tratar la fuente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, diabético, con 10 días de fiebre de 39 °C, calofríos y dolor en hipocondrio derecho. Leucocitos 19.000/mm³ y PCR 220 mg/L. La ecografía muestra una lesión hepática hipoecogénica de 7 cm, de contenido líquido con detritus. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Hepatectomía de urgencia
B) Albendazol y cirugía
C) Antibióticos orales y control ecográfico en 3 meses
D) Antibióticos endovenosos y drenaje percutáneo guiado por imagen
E) Observación, ya que es un quiste simple

Respuesta D. Fiebre, dolor en hipocondrio derecho y una colección hepática en un diabético es un absceso hepático piógeno. Se trata con antibióticos endovenosos que cubran gramnegativos y anaerobios, por ejemplo ceftriaxona y metronidazol, más drenaje percutáneo si mide más de 5 cm. Hay que buscar el origen, a menudo biliar.

4.01.1.024 Tumores hepáticos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Benignos: hemangioma (el más frecuente, hiperecogénico, captación periférica nodular centrípeta en TAC; no se biopsia), hiperplasia nodular focal (cicatriz central) y adenoma (mujer con anticonceptivos, riesgo de rotura y malignización).
- Hepatocarcinoma: sobre hígado cirrótico (VHB, VHC, alcohol, NASH); sospechar con nódulo nuevo en eco de vigilancia o alfafetoproteína elevada. Diagnóstico por imagen (TAC o RM trifásica: captación arterial y lavado portal), sin biopsia.
- Vigilancia del cirrótico: ecografía abdominal ± alfafetoproteína cada 6 meses.

- Metástasis hepáticas son los tumores malignos más frecuentes del hígado (colon, mama, pulmón, páncreas); buscar primario.
- Manejo inicial: estudio con TAC/RM y marcadores; suspender anticonceptivos en adenoma. Seguimiento: derivar a cirugía hepatobiliar/gastroenterología (resección, ablación, quimioembolización, trasplante según criterios de Milán).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 63 años con cirrosis hepática por alcohol, en seguimiento con ecografía semestral, presenta un nódulo hepático nuevo de 3 cm. La TAC trifásica muestra captación intensa de contraste en fase arterial y lavado en las fases portal y tardía. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
> **A)** Hemangioma hepático
> **B)** Hiperplasia nodular focal
> **C)** Metástasis de cáncer colorrectal
> **D)** Hepatocarcinoma
> **E)** Absceso hepático
> Respuesta D. En un paciente cirrótico, un nódulo mayor de 1 cm con hiperrealce arterial y lavado en fase portal o tardía es diagnóstico de hepatocarcinoma por imagen, sin necesidad de biopsia. El hemangioma muestra relleno periférico globular centrípeto, y la hiperplasia nodular focal aparece en mujeres jóvenes con hígado sano.

4.01.1.025 Colecistitis crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.2 Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

QUÉ HAY QUE SABER

- Colelitiasis sintomática: cólico biliar (dolor en epigastrio o hipocondrio derecho tras comidas grasas, 30 min a <6 h, irradiado a dorso o escápula derecha) sin fiebre ni leucocitosis, con episodios recurrentes.
- Colecistitis crónica es un diagnóstico histológico (inflamación crónica por litiasis); clínicamente equivale a colelitiasis sintomática. Dispepsia por grasas no es específica.
- Diagnóstico específico: ecografía abdominal (cálculos móviles con sombra acústica posterior, pared engrosada); pruebas hepáticas para descartar coledocolitiasis.
- Manejo inicial del cólico: analgesia con AINE (ketorolaco 30 mg IV/IM o diclofenaco) y antiespasmódico, régimen sin grasas.
- Seguimiento: derivar a cirugía para colecistectomía laparoscópica electiva. GES: colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años con colelitiasis.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 42 años refiere, desde hace 1 año, episodios recurrentes de dolor en el hipocondrio derecho después de comidas copiosas, de 2 a 3 horas de duración, que ceden espontáneamente. Actualmente está asintomática. La ecografía muestra múltiples cálculos vesiculares y pared de 4 mm, sin dilatación de la vía biliar. Pruebas hepáticas normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Colecistectomía laparoscópica electiva
> **B)** Ácido ursodesoxicólico por 6 meses
> **C)** Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
> **D)** Control ecográfico anual
> **E)** Hospitalizar e iniciar antibióticos
> Respuesta A. Los cólicos biliares recurrentes con colelitiasis corresponden a una colecistitis crónica litiásica sintomática; el tratamiento es la colecistectomía laparoscópica electiva, que previene complicaciones como colecistitis aguda, coledocolitiasis y pancreatitis. El ácido ursodesoxicólico tiene baja eficacia y alta recurrencia, y la CPRE solo se indica si hay coledocolitiasis.

4.01.1.026 Ictericia obstructiva

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ictericia obstructiva (colestasia extrahepática): ictericia con coluria, acolia y prurito; predominio de bilirrubina directa con FA y GGT elevadas.
- Causas: coledocolitiasis (ictericia fluctuante con dolor), cáncer de cabeza de páncreas/periampular (ictericia indolora progresiva, signo de Courvoisier-Terrier: vesícula palpable no dolorosa), colangiocarcinoma, cáncer de vesícula, estenosis benigna.
- Diagnóstico específico: ecografía primero (vía biliar dilatada: colédoco >6-8 mm); luego colangio-RM, endosonografía o TAC según sospecha; CPRE diagnóstica y terapéutica.
- Bandera roja: fiebre, ictericia y dolor (tríada de Charcot) = colangitis, urgencia; prolongación del TP por déficit de vitamina K.
- Manejo inicial: hidratación, vitamina K parenteral si TP alterado, antibióticos si colangitis. Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía para CPRE o cirugía según la causa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · Caso representativo · banco EUNACOM

Mujer de 55 años con dolor cólico en hipocondrio derecho e ictericia de 2 días, sin fiebre. Bilirrubina 4 mg/dL de predominio directo, FA y GGT elevadas, transaminasas levemente altas. Ecografía: colelitiasis y vía biliar de 9 mm, sin cálculos visibles en el colédoco. **¿Cuál es el siguiente examen?**

A) CPRE directa
B) Colangiorresonancia
C) TAC de abdomen con contraste
D) Biopsia hepática percutánea
E) Repetir la ecografía en 48 horas

Respuesta B. Colestasia con dolor y sin fiebre: coledocolitiasis. La ecografía ve la vía dilatada pero no el cálculo, así que se confirma con colangiorresonancia antes de la CPRE (invasiva, con riesgo de pancreatitis). Directo a CPRE solo si hay colangitis o si la eco ya vio el cálculo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 161 · texto original del banco, sin revisar

Paciente que empieza con ictericia 7 días post colecistectomía:

A) Litiasis en vía biliar común
B) Lesión vía biliar iatrogénica
C) Ninguna de las anteriores es correcta
D) Todas las anteriores son correctas
E) No se dispone de información suficiente

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Lesión vía biliar iatrogénica). La evaluación preanestésica tiene como objetivo evaluar y minimizar los riesgos, evaluar la vía aérea y elegir el tipo de anestesia y fármacos. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

4.01.1.027 Litiasis biliar

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.2 Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

QUÉ HAY QUE SABER

- Colelitiasis: muy prevalente en Chile (mujeres, población mapuche, obesidad, multiparidad, baja rápida de peso); la mayoría asintomática. Cálculos de colesterol los más frecuentes.
- Cuadros: cólico biliar, colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis biliar e íleo biliar (obstrucción por cálculo en íleon, neumobilia en Rx).
- Diagnóstico específico: ecografía abdominal (imagen hiperecogénica móvil con sombra acústica). Sospecha de coledocolitiasis: pruebas hepáticas alteradas, colédoco dilatado → colangio-RM o CPRE.
- Manejo inicial: analgesia del cólico (AINE), régimen hipograso; antibióticos y hospitalización si colecistitis o colangitis.
- Seguimiento: derivar a cirugía; colecistectomía en sintomáticos y GES colecistectomía preventiva en 35-49 años (prevención de cáncer de vesícula). Asintomáticos fuera de ese grupo: individualizar (cálculos >3 cm, vesícula en porcelana, pólipo >1 cm).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 125

Paciente de 40 años, IMC 30, presenta episodios de dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho desde hace 3 meses, que ceden espontáneamente luego de algunos minutos. Se realiza una ecografía, que muestra imágenes hiperecogénicas dentro de la vesícula con sombra acústica posterior, pared delgada y sin líquido perivesicular. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Colelitiasis
B) Coledocolitiasis
C) Colecistitis crónica
D) Cáncer de vesícula
E) Colecistitis aguda

Respuesta A. Cólicos biliares que ceden solos en minutos a horas, sin fiebre ni signos inflamatorios, con cálculos y sombra acústica en la ecografía: colelitiasis sintomática. Corresponde programar colecistectomía electiva. Sin pared engrosada ni líquido perivesicular no es colecistitis aguda.

4.01.1.028 Cáncer de vesícula y vías biliares

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

QUÉ HAY QUE SABER

- Chile tiene de las tasas más altas del mundo de cáncer de vesícula, sobre todo mujeres mapuche del sur; principal factor de riesgo: colelitiasis de larga data (cálculos grandes), vesícula en porcelana, pólipos >1 cm.
- Frecuentemente hallazgo en biopsia de colecistectomía; en etapa avanzada: dolor en hipocondrio derecho, baja de peso, ictericia, masa palpable.
- Colangiocarcinoma: ictericia obstructiva indolora progresiva; tumor de Klatskin en la confluencia hiliar (vesícula no palpable). CA 19-9 apoya.
- Estudio: ecografía, TAC trifásica, colangio-RM. Prevención: GES colecistectomía preventiva en colelitiasis entre 35 y 49 años.
- Manejo inicial: drenaje biliar si colangitis, soporte nutricional y vitamina K. Seguimiento: derivar a cirugía hepatobiliar/oncología (colecistectomía extendida, resección; paliación con stent).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 95

Paciente de 60 años se realiza una colecistectomía laparoscópica electiva por colelitiasis. La biopsia informa adenocarcinoma invasor en el fondo vesicular, que compromete hasta la subserosa. Una TAC de abdomen y pelvis con contraste no muestra metástasis. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Quimioterapia
B) Radioterapia
C) Cuidados paliativos
D) Control con TAC cada 3 meses
E) Colecistectomía radical

Respuesta E. En un cáncer de vesícula incidental T1b o mayor (aquí T2, subseroso) sin enfermedad a distancia, está indicada la reintervención con colecistectomía radical o extendida: resección del lecho hepático y linfadenectomía, que mejora la sobrevida. Solo el T1a, limitado a la lámina propia, se considera tratado con la colecistectomía simple.

4.01.1.029 Pancreatitis crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Daño pancreático irreversible con fibrosis; causa principal alcohol (también tabaco, genética, obstrucción, hipertrigliceridemia, autoinmune).
- Clínica: dolor epigástrico recurrente o crónico irradiado al dorso, que empeora con comidas; insuficiencia exocrina (esteatorrea, baja de peso) y endocrina (diabetes pancreatogénica, tipo 3c) en etapas tardías.
- Diagnóstico: TAC (calcificaciones pancreáticas, dilatación del Wirsung, atrofia); Rx de abdomen puede mostrar calcificaciones. Elastasa fecal baja confirma insuficiencia exocrina. Lipasa puede ser normal.

- Manejo inicial: suspender alcohol y tabaco, analgesia escalonada, enzimas pancreáticas con las comidas, dieta fraccionada, suplementar vitaminas liposolubles, tratar diabetes.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología/cirugía; complicaciones: pseudoquiste, estenosis biliar o duodenal, trombosis esplénica y mayor riesgo de cáncer de páncreas.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 50 años, con consumo excesivo de alcohol desde hace 15 años, consulta por dolor epigástrico crónico irradiado al dorso, baja de peso de 8 kg y deposiciones abundantes, aceitosas y fétidas. Glicemia en ayunas de 160 mg/dL. La TAC muestra calcificaciones pancreáticas difusas y un conducto pancreático irregular. **Además de suspender el alcohol y el tabaco, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la esteatorrea?**
>
> **A)** Dieta sin gluten
> **B)** Enzimas pancreáticas junto con las comidas
> **C)** Metronidazol
> **D)** Octreotide
> **E)** Pancreatectomía total
>
> Respuesta B. Dolor, esteatorrea y diabetes con calcificaciones pancreáticas definen una pancreatitis crónica con insuficiencia exocrina y endocrina. La esteatorrea se trata con enzimas pancreáticas administradas junto con las comidas. La dieta sin gluten trata la enfermedad celíaca, que no explica las calcificaciones.

4.01.1.030 Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumores periampulares: cáncer de cabeza de páncreas (el más frecuente), ampolla de Vater, colédoco distal y duodeno; los ampulares tienen mejor pronóstico (síntomas precoces).
- Clínica: ictericia indolora progresiva, prurito, coluria, acolia, baja de peso; signo de Courvoisier-Terrier (vesícula palpable no dolorosa). Ampuloma: ictericia fluctuante, anemia y melena.
- Estudio: ecografía (vía biliar dilatada sin cálculos), TAC de abdomen con protocolo de páncreas, endosonografía con biopsia, CA 19-9 (seguimiento, no diagnóstico).
- Manejo inicial: vitamina K si TP prolongado, manejo de prurito, nutrición; drenaje biliar (CPRE con stent) si colangitis o retraso quirúrgico.
- Seguimiento: derivar a cirugía hepatobiliopancreática para pancreatoduodenectomía (Whipple) en resecables; paliación endoscópica y quimioterapia en el resto.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 66 años presenta ictericia progresiva e indolora de 1 mes, coluria, acolia, prurito y baja de peso de 7 kg. Al examen se palpa una vesícula distendida e indolora. La TAC con contraste muestra un tumor de 2 cm en la región periampular, sin compromiso vascular ni metástasis. **¿Cuál es la cirugía con intención curativa?**
>
> **A)** Colecistectomía
> **B)** Pancreatoduodenectomía (operación de Whipple)
> **C)** Derivación biliodigestiva
> **D)** Pancreatectomía distal con esplenectomía
> **E)** Prótesis biliar por CPRE
>
> Respuesta B. Los tumores periampulares (cabeza de páncreas, ampolla de Vater, colédoco distal y duodeno) se presentan con ictericia indolora y vesícula palpable (Courvoisier-Terrier). Si son resecables, el tratamiento curativo es la pancreatoduodenectomía. La derivación biliodigestiva y la prótesis son paliativas; la pancreatectomía distal es para tumores de cuerpo y cola.

4.01.1.031 Cáncer de páncreas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenocarcinoma ductal de páncreas: mal pronóstico (sobrevida a 5 años <10%); factores: tabaco (principal modificable), edad, pancreatitis crónica, obesidad, diabetes de reciente inicio, antecedentes familiares.
- Cabeza (70%): ictericia indolora, Courvoisier-Terrier, baja de peso. Cuerpo y cola: dolor epigástrico irradiado al dorso, baja de peso, diagnóstico tardío. Signo de Trousseau (tromboflebitis migratoria).
- Diabetes de reciente inicio en adulto mayor delgado con baja de peso debe hacer sospechar cáncer de páncreas.
- Estudio: TAC trifásico de páncreas (lesión hipodensa) y CA 19-9; endosonografía con punción para histología.
- Manejo inicial: drenaje biliar y analgesia (incluyendo opioides, bloqueo del plexo celíaco). Seguimiento: derivar a cirugía/oncología; solo ~20% es resecable (Whipple, pancreatectomía distal).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años, fumador, consulta por ictericia indolora de 3 semanas, prurito, baja de peso de 6 kg y diabetes diagnosticada hace 4 meses. La ecografía muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y del conducto de Wirsung, sin cálculos. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A) Biopsia hepática percutánea
B) CPRE diagnóstica
C) Cintigrafía hepatobiliar
D) TAC de abdomen trifásica con protocolo de páncreas
E) Repetir la ecografía en 1 mes

Respuesta D. Ictericia indolora con dilatación de colédoco y Wirsung (signo del doble conducto), baja de peso y diabetes de reciente inicio en un fumador mayor sugieren cáncer de cabeza de páncreas. La TAC trifásica es el examen de elección para diagnosticar, etapificar y evaluar resecabilidad. La CPRE es terapéutica y no se usa para el diagnóstico inicial.

4.01.1.032 Masa cervical y tumores del cuello

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

QUÉ HAY QUE SABER

- Por edad: <40 años predominan inflamatorias/congénitas (adenitis reactiva, quiste tirogloso en línea media que asciende con la protrusión lingual, quiste branquial lateral); >40 años, una masa cervical persistente es maligna hasta demostrar lo contrario.
- Banderas rojas: >2 semanas sin regresión, >1,5-2 cm, dura, fija, indolora, supraclavicular, con disfonía, disfagia, otalgia refleja, baja de peso o fumador/bebedor.
- Adenopatía metastásica de carcinoma escamoso de cabeza y cuello: buscar primario con examen ORL completo (nasofibroscopía). Supraclavicular izquierda (Virchow): primario abdominal.
- Estudio: ecografía cervical, punción con aguja fina, TAC de cuello; evitar biopsia excisional antes del estudio ORL en sospecha de metástasis escamosa (salvo sospecha de linfoma).
- Adenitis reactiva: observar 2-3 semanas o antibiótico si signos bacterianos. Seguimiento: derivar a cirugía de cabeza y cuello/ORL toda masa persistente o sospechosa.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 80

Adulto joven con una masa blanda palpable en la línea media del cuello, entre el mentón y el cartílago tiroides. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Adenoma tiroideo
B) Quiste tirogloso
C) Quiste branquial
D) Linfadenitis cervical
E) Lipoma cervical

Respuesta B. El quiste tirogloso es la masa congénita más frecuente de la línea media del cuello; se ubica habitualmente a nivel o bajo el hueso hioides, por encima del tiroides, y asciende al protruir la lengua o deglutir. El quiste branquial, en cambio, es lateral, anterior al borde del esternocleidomastoideo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 25 años de edad, sin patologías previas, presenta desde hace 4 años aumento de volumen cervical lateral, que ha ido creciendo. Al examen se constata una masa palpable, de 3 cm, en la zona lateral del cuello, de ubicación submandibular. Se solicita una ecografía cervical, que muestra un nódulo hipoecogénico, de bordes bien delimitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Nódulo tiroideo
B) Quiste branquial
C) Quiste tirogloso
D) Linfadenopatía tuberculosa
E) Tumor de glándula salival secundaria

Respuesta B. Es un quiste branquial clásico (zona lateral del cuello y crecimiento muy lento). No puede ser nódulo tiroideo, por la ubicación (la tiroides está en la zona media inferior del cuello). Tampoco un quiste del conducto tirogloso, porque este es de la línea media. La adenopatía tuberculosa o escrófula crece más rápido y suele fistulizarse, dando salida a material caseoso.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 4 años con masa cervical anterior en la línea media, móvil con la deglución y la protrusión de la lengua, sin dolor ni fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

A) Quiste tirogloso; derivar a cirugía para extirpación electiva
B) Adenopatía cervical reactiva; observar
C) Linfoma cervical; biopsia
D) Bocio difuso; solicitar TSH
E) Quiste braquial; observar

Respuesta A. Masa cervical anterior en línea media que sube con deglución y protrusión lingual = quiste tirogloso. Tratamiento: cirugía de Sistrunk (extirpación del quiste + cuerpo del hioides) para evitar recidivas.

4.01.1.033 Cáncer del tiroides

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.10 Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante nódulo tiroideo con crecimiento rápido, consistencia dura, fijo, adenopatías cervicales, disfonía, antecedente de irradiación cervical o familiar con cáncer tiroideo/MEN2.
- Papilar (80-85%, buen pronóstico, diseminación linfática), folicular (hematógena), medular (células C, calcitonina, MEN2, RET) y anaplásico (adulto mayor, muy agresivo).
- Estudio: TSH y ecografía tiroidea (TI-RADS: hipoecogénico, microcalcificaciones, bordes irregulares, más alto que ancho); punción con aguja fina (citología Bethesda) según tamaño y TI-RADS.
- Bethesda V-VI: cirugía; Bethesda III-IV: repetir PAAF, estudio molecular o lobectomía diagnóstica.
- Seguimiento: derivar a cirugía de cabeza y cuello/endocrinología (tiroidectomía total o lobectomía, radioyodo según riesgo, supresión de TSH y tiroglobulina como marcador). GES: cáncer diferenciado y medular de tiroides en adultos.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Una paciente de 45 años, previamente operada de tiroidectomía total y dosis ablativa de I-131 hace 2 años por un carcinoma papilar de tiroides, asiste a control anual de seguimiento oncológico. **¿Cuál es el examen de laboratorio principal que se debe solicitar en sangre para pesquisar precozmente una recidiva tumoral?**

A) Calcitonina sérica basal
B) Tiroglobulina sérica en conjunto con anticuerpos anti-tiroglobulina
C) Antígeno carcinoembrionario (CEA)
D) TSH y T3 total
E) Fosfatasas alcalinas óseas

Respuesta B. En el carcinoma diferenciado tratado con tiroidectomía total y ablación, la tiroglobulina debe quedar indetectable (menor de 0,2 ng/mL); si reaparece o sube, indica recidiva. Se pide siempre con anticuerpos anti-tiroglobulina, porque estos pueden dejarla falsamente baja.

Pregunta de práctica

Un hombre de 38 años presenta un nódulo tiroideo de 2.5 cm cuya biopsia por punción confirma un Carcinoma Medular de Tiroides. El paciente refiere que su padre falleció a los 45 años por una causa no precisada asociada a crisis de cefalea e hipertensión severa. **Previo a programar la cirugía de resección cervical, ¿cuál es la conducta diagnóstica de máxima prioridad que debe llevarse a cabo?**

A) Indicar una dosis terapéutica inmediata de radioyodo I-131

B) Descartar la coexistencia de un feocromocitoma mediante metanefrinas plasmáticas o urinarias y realizar estudio genético de la mutación del protooncogén RET

C) Administrar quimioterapia con cisplatino para reducir la masa antes de la tiroidectomía

D) Indicar levotiroxina a dosis altas para suprimir la TSH a valores menores a 0.01 mIU/L

E) Solicitar una cintigrafía con yodo radiactivo de cuerpo entero

Respuesta B. El 25 % de los carcinomas medulares es hereditario (NEM 2A o 2B, mutación RET). Antes de operar el cuello hay que descartar un feocromocitoma con metanefrinas: si no se detecta, la anestesia puede gatillar una crisis adrenérgica fatal. Si existe, se reseca antes que la tiroides.

4.01.1.034 Patología benigna del tiroides

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 7.7 Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulo tiroideo: muy frecuente (ecografía en ~50% de adultos), 90-95% benigno. Primer paso: TSH; si está suprimida, cintigrafía (nódulo caliente hiperfuncionante casi nunca maligno).
- Ecografía tiroidea con clasificación TI-RADS y PAAF según tamaño y patrón (en general ≥1 cm si sospechoso, ≥1,5-2,5 cm si bajo riesgo). Citología Bethesda II: benigno, control ecográfico.
- Bocio multinodular: frecuentemente eutiroideo; indicaciones quirúrgicas: compresión (disfagia, disnea, estridor), extensión endotorácica, sospecha de malignidad o hipertiroidismo (bocio tóxico).
- Tiroiditis subaguda (De Quervain): dolor tiroideo post viral, VHS elevada, captación baja; AINE o prednisona y betabloqueo. Hipertiroidismo: propranolol + metimazol; Graves puede requerir radioyodo o cirugía.
- Seguimiento completo: nódulo benigno con ecografía a los 12-24 meses; repetir PAAF si crece >50% en volumen o aparecen rasgos sospechosos. Derivar a cirugía si compresión o sospecha.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Paciente de 42 años con bocio multinodular tóxico de 45 g, sin síntomas compresivos, con paridad completa y sin deseo de embarazo. Se le propone tratamiento ablativo con radioyodo. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a esta terapia es correcta?**

A) La probabilidad de remisión completa sin requerir levotiroxina es superior al 95 %

B) El resultado esperado más frecuente a largo plazo es el hipotiroidismo permanente, que requiere suplementación de por vida

C) Puede amamantar sin restricciones a su hijo lactante el día posterior al radioyodo

D) El radioyodo está contraindicado porque el bocio multinodular responde solo a tiamazol de por vida

E) Debe asociarse a dosis altas de aspirina para potenciar la fijación del isótopo

Respuesta B. Más del 80 % de los pacientes tratados con radioyodo desarrolla hipotiroidismo permanente: no es un fracaso, sino la consecuencia esperada de la ablación. Requiere controles de TSH y levotiroxina de por vida. La lactancia es contraindicación absoluta, y el BMNT no remite con fármacos.

4.01.1.035 Cáncer de mama

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer más frecuente y primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile. Factores: edad, mutación BRCA1/2, antecedente familiar, menarquia precoz/menopausia tardía, nuliparidad, TRH, obesidad, alcohol, radiación torácica.
- Sospecha: nódulo duro, indoloro, irregular, fijo; retracción de piel o pezón, piel de naranja, secreción sanguinolenta unilateral uniorificial, adenopatía axilar. Cáncer inflamatorio: mama eritematosa y edematosa sin

fiebre.

- Estudio: mamografía bilateral (BI-RADS) + ecografía; en <35 años, ecografía primero. Confirmación con biopsia core (trucut). BI-RADS 4-5 requiere biopsia.
- GES cáncer de mama (≥15 años): confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento con plazos garantizados ante sospecha. Pesquisa con mamografía en el examen de medicina preventiva de mujeres de 50 a 59 años cada 3 años.
- Seguimiento: derivar a unidad de patología mamaria; tratamiento según etapa y receptores (RE/RP, HER2): cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, trastuzumab.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 178

Una paciente de 41 años presenta un nódulo mamario derecho, de 2 cm de diámetro, que se autopalpó hace 2 meses. Al examen físico tiene consistencia dura e irregular. Cuenta con una mamografía, que es informada como BI-RADS 4. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Controlar con nueva mamografía en 1 año
B) Solicitar ecotomografía mamaria
C) Solicitar resonancia magnética de mama
D) Realizar biopsia con aguja gruesa
E) Realizar biopsia estereotáxica

Respuesta E. BI-RADS 4 se biopsia siempre. Con aguja gruesa si el nódulo es palpable, o estereotáxica si no lo es; ambas son aceptables, pero la estereotáxica suele ser más fidedigna cuando el caso lo permite.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 153

Una mujer de 45 años se realiza una mamografía, que muestra microcalcificaciones agrupadas y espiculadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, de 2 cm de diámetro. Su examen mamario no tiene alteraciones y cuenta con una mamografía previa, de hace 2 años, informada como BI-RADS 2. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir ecotomografía mamaria
B) Realizar biopsia con aguja gruesa
C) Programar biopsia estereotáxica
D) Solicitar resonancia magnética mamaria
E) Realizar control mamográfico en un año

Respuesta C. Las microcalcificaciones agrupadas y espiculadas corresponden a un BI-RADS 4 a 5 actual, sin importar que hace 2 años fuera BI-RADS 2. Como el examen mamario es normal, la lesión no es palpable, así que la biopsia se hace guiada por estereotaxia, no con aguja gruesa a mano alzada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 27

Mujer de 60 años presenta aumento de volumen en la axila derecha, de 4 cm de diámetro, indoloro, de consistencia dura y adherido a planos profundos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hidrosadenitis
B) Cáncer de mama
C) Cáncer de pulmón
D) Lipoma
E) Tuberculosis ganglionar

Respuesta B. Una adenopatía axilar dura, indolora y fija en una mujer de 60 años corresponde, hasta demostrar lo contrario, a metástasis de un cáncer de mama, aunque no se palpe el tumor primario. Debe estudiarse con mamografía, ecografía y biopsia. La hidrosadenitis es dolorosa y supurativa, y el lipoma es blando y móvil.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 173 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 52 consulta por molestias en la mama izquierda de 4 meses de evolución, caracterizados por eritema y prurito en el pezón y la aréola. Al examen físico se ve lo siguiente (Nota: aréola y pezón están eritematosos): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Paget de la mama
B) Mastitis candidiásica
C) Cáncer inflamatorio de la mama
D) Papiloma del pezón
E) Eccema del pezón

Respuesta A. Diagnóstico: Enfermedad de Paget de la mama (opción A). El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile, seguido del cáncer gástrico y de pulmón. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

4.01.1.036 Patología mamaria benigna

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibroadenoma: mujer joven (15-35 años), nódulo móvil, elástico, bien delimitado, indoloro; ecografía con nódulo sólido ovalado de bordes nítidos. Biopsia si >2-3 cm, crecimiento o edad >35 años.
- Cambios fibroquísticos: mastalgia cíclica premenstrual y nodularidad bilateral; quiste simple anecoico en eco se puede puncionar si es sintomático (líquido no hemático no requiere citología).
- Mastitis puerperal (S. aureus): dolor, eritema y fiebre en lactancia; continuar lactancia, vaciamiento y cloxacilina o cefadroxilo 10-14 días. Absceso: drenaje (punción guiada o incisión).
- Telorrea: bilateral y multiorificial suele ser fisiológica/hormonal (descartar hiperprolactinemia); unilateral, uniorificial, espontánea o sanguinolenta → papiloma intraductal vs carcinoma, estudiar.
- Seguimiento completo en APS: fibroadenoma estable con ecografía en 6 meses; derivar a patología mamaria lesiones BI-RADS 4-5, nódulos con cambios o masa en mujer mayor.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 45

Puérpera de 10 días con dolor y aumento de volumen en la mama derecha. La mama tiene eritema, una masa fluctuante y dolorosa de 6 centímetros, con afectación de la piel y secreción purulenta que sale por una lesión cutánea al comprimir. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Antibióticos de amplio espectro por vía oral
B) Realizar drenaje quirúrgico de la lesión
C) Realizar drenaje por punción
D) Realizar extracción láctea
E) Aplicar calor local y antiinflamatorios orales

Respuesta B. Absceso mamario con compromiso y necrosis de la piel, y secreción purulenta ya exteriorizada: aquí el drenaje quirúrgico con incisión es de elección por sobre la punción, que se reserva para cuando la piel está sana.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 50

Mujer de 35 años presenta un nódulo mamario desde hace 8 meses. La ecografía mamaria muestra un tumor de aspecto sólido, de bordes bien delimitados, sin refuerzo posterior, clasificado como BI-RADS 3. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Mastopatía fibroquística
B) Papiloma ductal
C) Fibroadenoma
D) Tumor phyllodes
E) Carcinoma ductal

Respuesta C. Un nódulo sólido, bien delimitado y probablemente benigno (BI-RADS 3) en una mujer joven corresponde con mayor probabilidad a un fibroadenoma, el tumor benigno de mama más frecuente entre los 15 y 35 años. El tumor phyllodes es mucho menos frecuente, de crecimiento rápido y mayor tamaño.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 22 años consulta por un nódulo mamario, que se autopalpó. Al examen físico se constata un nódulo en la mama derecha, de 2 cm de diámetro, móvil. No se palpan adenopatías axilares. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio de esta paciente?

A) Mamografías
B) Ecografía mamaria
C) Resonancia magnética nuclear de mamas
D) TAC de tórax
E) Biopsia

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Ecografía mamaria). Es un fibroadenoma clásico, que se estudia con ecografía mamaria.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 7 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, con antecedente de un quiste mamario izquierdo, consulta por dolor en la mama izquierda, asociada a fiebre y eritema. Al examen físico se constata eritema, aumento de volumen y dolor en la mama izquierda, con un nódulo doloroso a la palpación. Se solicita una ecografía que muestra una imagen quística de 5 cm de diámetro, con signos inflamatorios en las partes blandas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar seguimiento ecográfico
B) Iniciar tratamiento con AINES
C) Realizar punción y drenaje
D) Drenar mediante cirugía
E) Solicitar resonancia magnética nuclear de mamas

Respuesta D. Es un absceso mamario, que se debe drenar en pabellón. Además, se deben dar antibióticos (cloxacilina o cefazolina). En cambio, el flegmón mamario y las mastitis no abscedadas, solo se tratan con antibióticos.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Mujer joven con nódulo mamario de 5 cm, móvil, blando, sensible. Ecografía BIRADS-US 2. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Biopsia core guiada por ecografía
B) Ecotomografía de control en 6 meses
C) Mamografía bilateral
D) Resonancia magnética mamaria
E) Exéresis quirúrgica

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Ecotomografía de control en 6 meses (opción B). Ecotomografía de control en 6 meses. Es el método diagnóstico de elección debido a su alta sensibilidad (>95%) y capacidad para evaluar complicaciones y extensión anatómica con precisión milimétrica antes de decidir la terapéutica invasiva.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años, con antecedente de un quiste mamario de dos centímetros, en la mama derecha, diagnosticado hace 2 años. Consulta ahora por dolor y aumento de volumen, en relación a la mama derecha. Al examen físico tiene fiebre de 38,6°C, más una zona aumentada de volumen, con eritema y aumento de la temperatura, en la mama derecha, mayor en la zona superoexterna. Se solicita una ecografía mamaria, que visualiza signos inflamatorios de las partes blandas, más la lesión quística de 5 cm de diámetro, con contenido irregular. La conducta más adecuada es:

A) Punción del quiste
B) Solicitar resonancia magnética de mama
C) Drenaje quirúrgico
D) Realizar biopsia con aguja gruesa
E) Control mamográfico

Respuesta C. Tiene un absceso mamario, como complicación de un quiste infectado. Se debe drenar y manejar con antibióticos. El drenaje es quirúrgico, con incisión y drenaje.

4.01.1.037 Hidatidosis pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Zoonosis Chilenas Endémicas: Hidatidosis y Triquinosis

QUÉ HAY QUE SABER

- Hidatidosis pulmonar: segunda localización de E. granulosus (~20-30%), más frecuente en niños; zonas rurales del sur de Chile.
- Quiste íntegro suele ser asintomático (hallazgo en Rx: imagen redonda, homogénea, bien delimitada). Complicado: tos, hemoptisis, vómica de líquido salado con membranas (hidatidoptisis), fiebre, anafilaxia.
- Signos radiológicos de rotura: «camalote» o membrana flotante, signo del menisco/doble arco. Ecografía abdominal para buscar quistes hepáticos concomitantes.
- Diagnóstico: Rx y TAC de tórax + serología; no puncionar.
- Manejo inicial: albendazol perioperatorio; tratamiento de soporte en complicación. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax (quistectomía con capitonaje conservando parénquima). Notificación obligatoria.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 35 años, de zona rural de la Región de La Araucanía, consulta por tos y dolor torácico. La radiografía de tórax muestra una imagen redondeada de 7 cm, de bordes nítidos, en el lóbulo inferior derecho. La serología para hidatidosis es positiva. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
> **A)** Albendazol como tratamiento exclusivo
> **B)** Punción y aspiración percutánea del quiste
> **C)** Neumonectomía derecha
> **D)** Observación con radiografía semestral
> **E)** Cirugía conservadora (quistectomía con capitonaje) asociada a albendazol
> Respuesta E. El quiste hidatídico pulmonar se trata con cirugía conservadora del parénquima (quistectomía o periquistectomía, cierre de bronquios y capitonaje), con albendazol perioperatorio para reducir siembra y recurrencia. La punción percutánea del quiste pulmonar está contraindicada por riesgo de anafilaxia y siembra, y las resecciones extensas son innecesarias.

4.01.1.038 Nódulo pulmonar solitario

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulo pulmonar solitario: opacidad redondeada ≤3 cm rodeada de parénquima normal, sin atelectasia ni adenopatías; >3 cm se llama masa (alta probabilidad de malignidad).
- Sugieren malignidad: edad >50, tabaquismo, tamaño >8 mm, bordes espiculados, crecimiento, lóbulo superior, antecedente de cáncer. Benignidad: calcificación central, laminar o en «palomita de maíz» (hamartoma), estabilidad ≥2 años (sólidos).
- Primer paso: comparar con radiografías previas y realizar TAC de tórax.
- Conducta según tamaño y riesgo (guías Fleischner): <6 mm bajo riesgo sin control; 6-8 mm TAC de control; >8 mm PET-CT, biopsia o resección.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cirugía de tórax todo nódulo sospechoso o >8 mm; en Chile considerar TBC, hidatidosis y micosis como diferenciales.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 55 años, fumador de 25 paquetes-año, asintomático. Una TAC de tórax pedida por otro motivo muestra un nódulo sólido de 7 mm en el lóbulo superior derecho, de bordes lisos, sin calcificaciones. No tiene imágenes previas en ningún centro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** No requiere seguimiento
> **B)** TAC de control a los 6 a 12 meses y luego a los 18 a 24 meses
> **C)** PET-CT con 18-FDG
> **D)** Biopsia percutánea guiada por TAC
> **E)** Lobectomía superior derecha
> Respuesta B. Sin imágenes previas para comparar, el tamaño manda: un nódulo de 6 a 8 mm se controla con TAC a los 6–12 meses y luego a los 18–24 meses, buscando crecimiento. El PET-CT y la biopsia se reservan para nódulos mayores de 8 mm.

4.01.1.039 Cáncer pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

QUÉ HAY QUE SABER

- Principal causa de muerte por cáncer en Chile; factor de riesgo dominante: tabaquismo (también arsénico en agua del norte, asbesto, radón). Tipos: adenocarcinoma (el más frecuente), escamoso, células grandes y células pequeñas (neuroendocrino, muy agresivo).
- Sospecha: tos persistente o cambio de la tos en fumador, hemoptisis, baja de peso, disnea, neumonía que no resuelve, dolor torácico, disfonía (recurrente) o hipocratismo digital.
- Síndromes asociados: Pancoast (Horner, dolor de hombro/brazo), vena cava superior, paraneoplásicos (SIADH e hipercortisolismo en células pequeñas; hipercalcemia por PTHrp en escamoso).
- Estudio: Rx tórax y TAC de tórax con contraste; confirmación histológica por fibrobroncoscopía, punción transtorácica o EBUS; etapificación con PET-CT y RM cerebral.
- Manejo inicial: cesación tabáquica, manejo sintomático. Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología; cirugía en etapas I-II de no células pequeñas; terapias blanco según mutaciones (EGFR, ALK).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 67 años, fumador de 45 paquetes-año, consulta por astenia, náuseas, constipación y confusión fluctuante, sin fiebre. Radiografía: masa central perihiliar derecha de 5 cm con ensanchamiento mediastínico. Calcio 13,8 mg/dL, fósforo 2,1 mg/dL, PTH suprimida y PTHrP marcadamente elevada. **¿Cuál es el tipo histológico más probable?**

A) Adenocarcinoma periférico
B) Carcinoma epidermoide (escamoso)
C) Carcinoma microcítico
D) Carcinoma de células grandes
E) Metástasis óseas de un adenocarcinoma

Respuesta B. Masa central en fumador con hipercalcemia grave, PTH suprimida y PTHrP elevada: hipercalcemia humoral por PTHrP, firma del carcinoma epidermoide. Manejo inmediato: hidratación con suero fisiológico, bifosfonato EV (ácido zoledrónico) y fibrobroncoscopía con biopsia.

Pregunta de práctica

Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho, asociado a caída del párpado superior derecho y ausencia de sudoración en la mitad derecha del rostro. La radiografía de tórax muestra una opacidad apical en el vértice pulmonar derecho. **¿Cómo se denomina esta constelación clínica y cuál es su sustrato anatómico?**

A) Síndrome de Kartagener por alteración de la motilidad ciliar
B) Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado
C) Síndrome de Vena Cava Superior por compresión de la aurícula derecha
D) Miopatía tiroidea con infiltración de la base de la lengua
E) Neuralgia postherpética de ramas torácicas altas

Respuesta B. Tumor del surco superior que invade el plexo braquial inferior (dolor en el borde cubital del brazo) y la cadena simpática cervical/ganglio estrellado (Horner ipsilateral: ptosis, miosis, anhidrosis).

4.01.1.040 Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

QUÉ HAY QUE SABER

- Hernia diafragmática congénita (Bochdalek: posterolateral izquierda, la más frecuente): RN con distrés respiratorio, abdomen excavado, ruidos hidroaéreos en tórax y desplazamiento de ruidos cardíacos; asocia hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. Morgagni: anterior, a menudo asintomática.
- Diagnóstico prenatal por ecografía (planificar parto en centro terciario); postnatal con Rx tórax (asas intestinales y SNG en el tórax).
- Manejo inicial en RN: intubación inmediata, evitar ventilación con mascarilla-bolsa (distiende el estómago), SNG para descompresión, cirugía diferida tras estabilización.
- Hernia diafragmática traumática: más frecuente izquierda tras trauma cerrado de alta energía o penetrante toracoabdominal; puede pasar inadvertida y manifestarse tardíamente como obstrucción o estrangulación.

- Sospechar en Rx con elevación del hemidiafragma, nivel hidroaéreo o SNG en tórax; confirmar con TAC. Seguimiento: derivar a cirugía (reparación quirúrgica).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 34 años con antecedente de accidente de tránsito con trauma toracoabdominal hace 3 años. Una radiografía de tórax por un cuadro respiratorio banal muestra asas intestinales en el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Está asintomático desde el punto de vista digestivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Observación y radiografía de control en 6 meses
> **B)** Cirugía de reparación electiva
> **C)** Cirugía de urgencia
> **D)** Inhibidor de la bomba de protones y control
> **E)** Endoscopía digestiva alta
> Respuesta B. Hernia diafragmática traumática crónica descubierta como hallazgo. Aunque esté asintomático, no se observa: se repara de forma electiva para evitar obstrucción, incarceración o estrangulación. La cirugía de urgencia se reserva para la fase aguda o la hernia complicada.

4.01.1.041 Síndromes mediastínicos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

QUÉ HAY QUE SABER

- Masas mediastínicas por compartimento: anterior (las 4 T: timoma, teratoma/tumor germinal, tiroides endotorácico, «terrible» linfoma), medio (adenopatías, quistes broncogénicos y pericárdicos), posterior (tumores neurogénicos).
- Síndrome de vena cava superior: edema en esclavina de cara, cuello y brazos, circulación colateral torácica, cefalea y disnea; causa principal cáncer pulmonar y linfoma.
- Otros síndromes por compresión: disfagia (esófago), estridor/tos (tráquea), disfonía (nervio recurrente), Horner (simpático). Timoma asociado a miastenia gravis.
- Estudio: Rx tórax (ensanchamiento mediastínico) y TAC de tórax con contraste; marcadores (β-hCG, alfafetoproteína) en masa anterior de hombre joven; biopsia antes de iniciar tratamiento.
- Manejo inicial del SVCS: cabecera elevada, oxígeno, evitar vías venosas en brazos; corticoides solo si linfoma confirmado o compromiso de vía aérea. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax/oncología.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> En una radiografía de tórax de control se observa un ensanchamiento del mediastino anterior en un paciente de 40 años con diplopía y fatigabilidad muscular que mejora con el reposo. **¿Cuál es el examen a solicitar y la sospecha?**
> **A)** Ecografía torácica; quiste pericárdico
> **B)** TAC de tórax con contraste; timoma asociado a miastenia gravis
> **C)** Resonancia de columna; tumor neurogénico
> **D)** PET-CT; linfoma de Hodgkin
> **E)** Cintigrafía tiroidea; bocio endotorácico
> Respuesta B. Masa en el mediastino anterior + miastenia gravis (diplopía y debilidad fluctuante que mejora con el reposo) orientan a timoma. El examen de elección para cualquier masa mediastínica es el TAC de tórax con contraste. Timoma con miastenia: timectomía, que puede mejorar la miastenia.

4.01.1.042 Mesotelioma pleural

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

QUÉ HAY QUE SABER

- Tumor maligno de la pleura fuertemente asociado a exposición a asbesto (latencia de 20-40 años): trabajadores de construcción, astilleros, frenos, fibrocemento.
- Clínica: disnea progresiva, dolor torácico sordo no pleurítico, baja de peso; derrame pleural unilateral recurrente, frecuentemente hemorrágico.

- Imagen: engrosamiento pleural nodular o circunferencial, placas pleurales calcificadas (marcador de exposición), retracción del hemitórax en TAC.
- Diagnóstico: citología del líquido suele ser insuficiente; requiere biopsia pleural por toracoscopía (VATS) con inmunohistoquímica.
- Manejo inicial: toracocentesis evacuadora para alivio sintomático, analgesia. Seguimiento: derivar a broncopulmonar/oncología (quimioterapia, inmunoterapia, pleurodesis). Es enfermedad profesional (Ley 16.744).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, que trabajó 25 años instalando aislantes de asbesto, consulta por disnea progresiva, dolor torácico sordo persistente y baja de peso de 3 meses. La radiografía muestra derrame pleural derecho y la TAC revela engrosamiento pleural nodular y circunferencial. El líquido pleural es un exudado hemático con citología negativa. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) Biopsia pleural por toracoscopía
B) Repetir la citología del líquido pleural
C) Fibrobroncoscopía
D) Marcadores tumorales en sangre
E) Adenosina deaminasa en líquido pleural

Respuesta A. Exposición a asbesto con derrame unilateral y engrosamiento pleural nodular y circunferencial sugiere mesotelioma pleural maligno. La citología tiene baja sensibilidad para este tumor; el diagnóstico requiere histología con inmunohistoquímica, idealmente por biopsia pleural toracoscópica. La ADA orienta a tuberculosis pleural, que no explica el engrosamiento nodular.

4.01.1.043 Síndrome de ocupación pleural

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

QUÉ HAY QUE SABER

- Derrame pleural: disnea, dolor pleurítico, matidez, abolición del murmullo vesicular y de vibraciones vocales. Rx: borramiento del ángulo costofrénico (≥200 ml en PA), curva de Damoiseau; ecografía detecta volúmenes pequeños.
- Toracocentesis diagnóstica en todo derrame nuevo sin causa evidente (salvo insuficiencia cardíaca bilateral típica): criterios de Light para exudado (proteína pleura/plasma >0,5, LDH pleura/plasma >0,6 o LDH >2/3 del límite normal).
- Trasudado: insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico. Exudado: paraneumónico, TBC (ADA >40-45, linfocitos), cáncer (citología), TEP.
- Derrame paraneumónico complicado/empiema: pH <7,2, glucosa <60 mg/dl, LDH >1000, Gram/cultivo positivo o pus → drenaje pleural con tubo además de antibióticos.
- Neumotórax es la otra ocupación pleural: a tensión es emergencia (descompresión con aguja en 2° espacio intercostal línea medioclavicular o 4°-5° línea axilar media). Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cirugía de tórax.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 143

Un paciente de 19 años consulta por dolor torácico derecho, de 24 horas de evolución, que aumenta con la inspiración. Al examen físico, se aprecia disminución del murmullo pulmonar en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: [radiografía: neumotórax derecho extenso]. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control radiológico en 24 horas
B) Solicitar TAC de tórax
C) Realizar cirugía abierta
D) Drenaje con tubo pleural
E) Videotoracoscopía

Respuesta D. La radiografía mostraba un neumotórax derecho grande. Neumotórax primario grande: se evacúa el aire con aspiración o tubo pleural. La videotoracoscopía no se indica en un primer episodio salvo fuga persistente u otra indicación.

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, fumador, con baja de peso, disnea progresiva y dolor sordo en el hemitórax izquierdo. Rx: derrame pleural izquierdo moderado. Toracocentesis: líquido amarillo cetrino, proteínas 4,2 g/dL (plasma 6,8 g/dL), LDH 380 U/L (plasma 240 U/L; límite superior normal 250 U/L). **¿Cuál es la clasificación del líquido y la conducta más adecuada?**

A) Trasudado; iniciar furosemida
B) Exudado; citología y biopsia pleural
C) Trasudado; ecocardiograma
D) Exudado; instalar tubo pleural de inmediato
E) No clasificable; repetir la punción en 1 semana

Respuesta B. Proteínas LP/S = 4,2/6,8 = 0,62 (> 0,5); LDH LP/S = 380/240 = 1,58 (> 0,6); LDH LP 380 > 2/3 de 250. Es un exudado. En un fumador con síndrome consuntivo, se estudia con citología y biopsia pleural para descartar neoplasia.

4.01.1.044 Aneurisma de aorta torácica, femoral y poplítea

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: cirugia-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Aneurisma de aorta torácica: asociado a aterosclerosis, HTA, Marfan, Ehlers-Danlos, válvula aórtica bicúspide, sífilis; la mayoría asintomático (hallazgo de mediastino ensanchado en Rx).
- Síntomas por compresión (disfonía, disfagia, tos, SVCS) o dolor torácico/dorsal; dolor súbito intenso sugiere disección o rotura (emergencia). Indicación quirúrgica en general ≥5,5 cm (menor en Marfan).
- Aneurisma poplíteo: el periférico más frecuente, masa pulsátil en hueco poplíteo; frecuentemente bilateral (50%) y asociado a aneurisma aórtico (buscarlo). Complicación típica: trombosis/embolia con isquemia aguda, no rotura.
- Aneurisma femoral: masa pulsátil inguinal; diferenciar de pseudoaneurisma post punción (cateterismo).
- Estudio: ecografía Doppler (periféricos), angioTAC (torácico). Manejo inicial: control de PA, cese de tabaco, estatinas. Seguimiento: derivar a cirugía vascular.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años, hipertenso y exfumador, consulta por una masa pulsátil asintomática en el hueco poplíteo derecho. La ecografía Doppler confirma un aneurisma de la arteria poplítea de 3 cm, con trombo mural. **¿Cuál es la complicación más frecuente de esta patología?**

A) Trombosis o embolia distal con isquemia aguda de la pierna
B) Rotura con hemorragia masiva
C) Compresión del nervio ciático
D) Fístula arteriovenosa
E) Insuficiencia cardíaca de alto débito

Respuesta A. A diferencia del aneurisma de aorta abdominal, cuya complicación temida es la rotura, el aneurisma poplíteo se complica principalmente con trombosis o embolización distal, con isquemia aguda y riesgo de amputación. Por eso se reparan los sintomáticos o mayores de 2 cm, y se busca un aneurisma contralateral y aórtico asociado.

4.01.1.045 Enfermedad renovascular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hipertensión Secundaria y Estenosis de la Arteria Renal

QUÉ HAY QUE SABER

- Estenosis de arteria renal: aterosclerótica (>90%, adulto mayor con aterosclerosis difusa, fumador) o displasia fibromuscular (mujer joven, aspecto en «cuentas de rosario»).
- Sospechar ante: HTA de inicio <30 o >55 años, HTA resistente o maligna, empeoramiento brusco de HTA controlada, edema pulmonar flash, soplo abdominal, asimetría renal >1,5 cm.
- Caída de la VFG >30% al iniciar IECA o ARA II es clave para sospechar estenosis bilateral o de riñón único.
- Estudio: ecografía Doppler renal (screening), angioTAC o angio-RM; arteriografía es el gold standard.
- Manejo inicial: control de PA (IECA/ARA II con monitoreo de creatinina y potasio), estatinas, antiagregación, cese tabaco. Seguimiento: derivar a nefrología/cirugía vascular (angioplastía en displasia fibromuscular).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 22 años, sin antecedentes, consulta por cefalea pulsátil recurrente de 2 meses. Delgada, PA 175/105 mmHg en ambos brazos, FC 72 lpm. Soplo sistólico rudo en flanco derecho que se prolonga hacia la fosa lumbar. Creatinina 0,8 mg/dL, K 3,3 mEq/L, HCO_3 28 mEq/L. No usa anticonceptivos orales. **¿Cuál es el primer examen a solicitar?**
>
> **A)** Arteriografía renal selectiva
> **B)** Ecografía Doppler de arterias renales
> **C)** Monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas
> **D)** AngioTAC de arterias renales
> **E)** Metanefrinas urinarias
>
> Respuesta B. HTA severa en mujer joven sin factores metabólicos, soplo en flanco y potasio limítrofe por hiperaldosteronismo secundario: HTA renovascular por displasia fibromuscular. El primer examen es el Doppler de arterias renales; la arteriografía es el estándar de oro y se usa para tratar (angioplastía con balón sin stent).

4.01.1.046 Insuficiencia cerebro vascular

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad carotídea aterosclerótica: causa importante de ACV isquémico; se manifiesta como AIT (déficit focal transitorio, amaurosis fugax ipsilateral) o infarto. Soplo carotídeo es poco sensible.
- AIT es urgencia: riesgo alto de ACV en los primeros días (escala ABCD2 orienta). Estudiar con imagen cerebral y Doppler carotídeo precoz.
- Insuficiencia vertebrobasilar: vértigo, diplopía, disartria, ataxia, drop attacks; síndrome del robo de la subclavia (síntomas al ejercitar el brazo, diferencia de PA entre brazos >20 mmHg).
- Manejo inicial: antiagregación (AAS 100 mg; doble antiagregación corta en AIT de alto riesgo), estatina de alta intensidad, control de HTA, DM y tabaco. ACV isquémico es GES.
- Seguimiento: derivar a neurología/cirugía vascular para endarterectomía carotídea en estenosis sintomática ≥70% (beneficio también en 50-69%), idealmente en las 2 primeras semanas.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 66 años, hipertenso, presenta un episodio de 30 minutos de debilidad de la mano derecha y dificultad para hablar, con recuperación completa. La TAC de cerebro es normal. La ecografía Doppler carotídea muestra una estenosis de 80% de la carótida interna izquierda. **Además del tratamiento médico óptimo, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Anticoagulación con heparina y luego warfarina
> **B)** Control con Doppler carotídeo en 6 meses
> **C)** Endarterectomía carotídea izquierda precoz, idealmente dentro de 2 semanas
> **D)** Endarterectomía carotídea derecha
> **E)** Trombólisis endovenosa
>
> Respuesta C. Un AIT del territorio carotídeo izquierdo con estenosis sintomática ipsilateral de 70 a 99% tiene indicación de endarterectomía carotídea (o angioplastia con stent en casos seleccionados), idealmente dentro de 2 semanas, cuando el riesgo de recurrencia es mayor. La trombólisis no corresponde porque el déficit ya se resolvió.

4.01.1.047 Insuficiencia arterial crónica

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Enfermedad arterial periférica aterosclerótica: factores principales tabaco y diabetes; claudicación intermitente (dolor en pantorrilla al caminar que cede con reposo).
- Clasificación de Fontaine: I asintomático, II claudicación (IIa >200 m, IIb <200 m), III dolor de reposo, IV úlcera/gangrena. III-IV = isquemia crítica.

- Examen: pulsos disminuidos o ausentes, piel fría, atrofia, pérdida de vello, palidez a la elevación y rubor en declive. Diagnóstico específico: índice tobillo-brazo <0,9 (>1,3 sugiere calcificación arterial en diabéticos).
- Tratamiento inicial: dejar de fumar (lo más importante), ejercicio supervisado, AAS 100 mg o clopidogrel, estatina, control de DM y HTA; cilostazol 100 mg c/12 h para claudicación (contraindicado en insuficiencia cardíaca).
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular claudicación invalidante, dolor de reposo, úlcera o gangrena (revascularización endovascular o bypass).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 146

Diabético fumador con dolor en pantorrillas al caminar 120 metros, ausencia de reflejos patelares, hipoestesia y pulsos pedios débiles. ¿Cuál es el examen de elección? **¿Cuál es el examen de elección?**

A) Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa
B) AngioTAC de extremidades inferiores
C) Arteriografía de extremidades inferiores
D) Doppler venoso de extremidades inferiores
E) Índice tobillo-brazo (ITB)

Respuesta E. Dolor de pantorrillas al caminar una distancia fija (claudicación intermitente) con pulsos débiles: enfermedad arterial periférica. El examen inicial es el índice tobillo-brazo; bajo 0,9 la confirma. Los signos de neuropatía son el distractor.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 146

Paciente diabético y fumador presenta dolor en las pantorrillas al caminar 120 metros. Al examen tiene reflejos patelares ausentes, hipoestesia y pulsos pedios débiles. **¿Cuál es el examen de elección?**

A) Electromiografía y velocidad de conducción nerviosa
B) AngioTAC de extremidades inferiores
C) Arteriografía de extremidades inferiores
D) Doppler venoso de extremidades inferiores
E) Índice tobillo-brazo (ITB)

Respuesta E. La claudicación intermitente con pulsos pedios débiles sugiere enfermedad arterial periférica. El examen inicial de elección es el índice tobillo-brazo: un valor menor de 0,9 confirma el diagnóstico (en diabéticos puede estar falsamente elevado por calcificación arterial). La angioTAC o la arteriografía se reservan para planificar una revascularización.

4.01.1.048 Várices. Insuficiencia venosa crónica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: cirugia-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia venosa crónica: incompetencia valvular superficial (safena) o secuela de TVP; factores: edad, sexo femenino, embarazo, bipedestación prolongada, obesidad, herencia.
- Clínica: pesadez, dolor y edema vespertino que mejora con elevación, várices, prurito; clasificación CEAP C0-C6 (telangiectasias, várices, edema, cambios de piel como hiperpigmentación/dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis, úlcera cicatrizada y activa).
- Diagnóstico específico: clínico, confirmado con ecografía Doppler venoso (reflujo, permeabilidad del sistema profundo), especialmente antes de cirugía.
- Tratamiento inicial: elevación de extremidades, ejercicio, bajar de peso, evitar bipedestación prolongada y compresión elástica graduada (20-30 o 30-40 mmHg) si no hay isquemia arterial (ITB >0,8); flebotónicos de apoyo.
- Seguimiento completo en APS: control de síntomas y piel; derivar a cirugía vascular si várices sintomáticas refractarias, varicorragia, tromboflebitis recurrente o úlcera (escleroterapia, ablación endovenosa, safenectomía).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 26

Mujer de 45 años con várices bilaterales en extremidades inferiores, sin úlceras ni tromboflebitis. Sin otros antecedentes mórbidos. **¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?**

A) Anticoagulación oral
B) Flebectomía inmediata
C) Escleroterapia de urgencia
D) Medidas conservadoras: dieta, ejercicio y medias compresivas
E) Derivación vascular urgente

Respuesta D. En la insuficiencia venosa crónica no complicada, el manejo inicial es conservador: control de peso, ejercicio, elevación de piernas y medias de compresión graduada. La cirugía o los procedimientos ablativos se plantean en forma electiva si persisten síntomas o aparecen complicaciones; ninguno es urgente, y la anticoagulación no tiene indicación.

4.01.1.049 Trombosis venosa profunda y tromboflebitis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.5 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) & Trombosis Venosa Profunda (TVP) · Tema 12.3 Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- TVP: edema unilateral de extremidad, dolor, aumento de temperatura y diámetro (>3 cm de diferencia), dilatación venosa superficial; signo de Homans poco sensible. Factores de Virchow: estasia, daño endotelial, hipercoagulabilidad (cirugía, inmovilización, cáncer, ACO, embarazo).
- Diagnóstico específico: escala de Wells; probabilidad baja → dímero D (si negativo descarta); probabilidad alta o dímero positivo → ecografía Doppler venosa (no compresibilidad).
- Tratamiento inicial: anticoagulación inmediata con heparina de bajo peso molecular (enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC) o anticoagulante oral directo, con traslape a warfarina (INR 2-3) si se elige ésta; duración mínima 3 meses.
- Tromboflebitis superficial: cordón eritematoso doloroso en vena superficial; AINE, calor local y compresión; anticoagular si >5 cm de longitud o cercana (<3 cm) al cayado safeno-femoral.
- Banderas rojas: disnea o dolor torácico (TEP), flegmasia cerulea dolens. Seguimiento: derivar para estudio de trombofilia/cáncer en TVP no provocada; prevención con tromboprofilaxis en hospitalizados y postoperados.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, operado hace 12 días de una fractura de cadera, sin profilaxis antitrombótica desde el alta. Consulta por aumento de volumen y dolor de la pantorrilla izquierda de 2 días. Al examen, la pierna izquierda tiene 4 cm más de circunferencia que la derecha, edema con fóvea y dolor a la palpación del trayecto venoso. Sin disnea, saturación 97%. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar dímero D y, si es positivo, repetirlo en 1 semana
B) Instalar un filtro de vena cava inferior como primera medida
C) Indicar AINE y reposo con la pierna elevada
D) Solicitar flebografía antes de cualquier tratamiento
E) Ecografía doppler venosa de la extremidad e iniciar anticoagulación, por ejemplo con heparina de bajo peso molecular

Respuesta E. Con alta probabilidad clínica (cirugía traumatológica reciente, edema asimétrico, dolor en el trayecto venoso), el dímero D no aporta: se confirma con ecografía doppler y se anticoagula, iniciando sin esperar si hay demora y no hay contraindicación. El filtro de cava se reserva para quienes no pueden anticoagularse.

Pregunta de práctica

Mujer de 48 años con várices en ambas piernas consulta por un cordón indurado, rojo, caliente y doloroso en la cara medial de la pierna derecha, bajo la rodilla, de 3 días de evolución, tras un golpe con el pedal de la bicicleta. Sin fiebre ni edema de la extremidad. La ecografía doppler muestra trombosis de un segmento de la vena safena mayor a 15 cm de la unión safenofemoral, con venas profundas permeables. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Antibióticos endovenosos por celulitis
B) Anticoagulación oral con warfarina por 6 meses
C) Calor local, AINE, compresión elástica y deambulación, con control clínico
D) Reposo absoluto en cama con la pierna en alto por 2 semanas
E) Instalar un filtro de vena cava inferior

Respuesta C. Una tromboflebitis superficial corta, alejada más de 3 cm de la unión safenofemoral y sin trombosis profunda, se trata con calor local, AINE, compresión y deambulación. Se anticoagula si el segmento mide 5 cm o más, está cerca del cayado o se asocia a TVP. El reposo absoluto favorece la progresión.

4.01.1.050 Ulceras de las piernas (venosas, varicosas, hipert. y específicas)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: cirugia-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlcera venosa (~70%): región maleolar medial, bordes irregulares, poco dolorosa, fondo granulante, con edema, dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis.
- Úlcera arterial: distal (dedos, talón, prominencias), bordes netos en «sacabocado», fondo pálido, muy dolorosa, pulsos ausentes. Úlcera hipertensiva de Martorell: cara lateral de pierna, muy dolorosa, en hipertenso con pulsos presentes.
- Úlcera neuropática (diabética): zonas de apoyo plantar, indolora, con callosidad. Específicas: pioderma gangrenoso (EII, AR), vasculitis, neoplásicas (Marjolin: úlcera crónica que se malignizа → biopsiar si no cicatriza o tiene bordes evertidos).
- Diagnóstico específico: palpación de pulsos e ITB en toda úlcera (≥0,9 normal; <0,8 contraindica compresión fuerte), Doppler venoso/arterial y biopsia si atípica.
- Tratamiento inicial: curación avanzada (aseo, desbridamiento, apósitos húmedos), tratar infección, compresión en venosa con ITB adecuado, elevación. Seguimiento: derivar a cirugía vascular/dermatología según causa.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 61

Hombre de 58 años, con várices de gran tamaño en ambas piernas, consulta porque hace 2 semanas sufrió un pequeño trauma en la extremidad inferior izquierda y evolucionó con una lesión ulcerada que ha aumentado de tamaño hasta 1,5 cm, ubicada a 2 cm del maléolo interno. Al examen se aprecia oscurecimiento de la piel circundante, además de las várices. **¿Cuál es la etiología más probable de la lesión?**

A) Infecciosa
B) Isquémica
C) Venosa
D) Neuropática
E) Por presión

Respuesta C. Una úlcera en la zona perimaleolar interna, en un paciente con várices e hiperpigmentación (dermatitis ocre), es típicamente venosa. Las úlceras isquémicas son distales (ortejos, talón), muy dolorosas y con pulsos ausentes; las neuropáticas aparecen en zonas de apoyo plantar.

4.01.1.051 Pie diabético

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Pie Diabético: Úlceras, Neuropatía, Clasificación de Wagner y Manejo Quirúrgico

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie diabético: úlcera, infección o destrucción de tejidos del pie en diabético asociada a neuropatía y/o enfermedad arterial periférica; principal causa de amputación no traumática.
- Evaluación específica: sensibilidad con monofilamento 10 g y diapasón, pulsos pedios y tibiales posteriores, ITB, deformidades (Charcot), clasificación de Wagner (0 a 5) o Texas; Rx para osteomielitis (sonda que toca hueso =

probe-to-bone).

- Infección leve: celulitis <2 cm sin compromiso sistémico → antibiótico oral (amoxicilina-ácido clavulánico o cefadroxilo, clindamicina si alergia). Moderada-grave (absceso, celulitis extensa, gangrena, sepsis) → hospitalizar, antibióticos IV y aseo quirúrgico.
- Tratamiento inicial de úlcera: descarga (no apoyar), curación avanzada, control glicémico, desbridamiento, evaluar perfusión.
- Prevención GES/PSCV: evaluación anual del pie con puntaje de riesgo, educación, calzado adecuado, revisión diaria. Seguimiento: derivar a cirugía vascular/equipo de pie diabético si isquemia, infección profunda o Wagner ≥3.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años, DM2 de 16 años mal controlada, tabáquico. Úlcera plantar de 3 semanas, de 2,5 cm, sobre la cabeza del 1.er metatarsiano, con hiperqueratosis alrededor e indolora. Al explorar el fondo con un estilete estéril, choca con una superficie dura y rugosa. Pie tibio, pulsos pedio y tibial posterior presentes. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Curación avanzada ambulatoria y descarga; control en 1 semana
B) Cefadroxilo oral por 10 días y curación en APS
C) Hospitalizar: imagen, desbridamiento con biopsia ósea, descarga y antibióticos EV
D) Amputación supracondílea de urgencia
E) Derivar a cirugía vascular para bypass ambulatorio

Respuesta C. Mal perforante plantar neuropático (indoloro, hiperqueratosis, pulsos presentes) con estilete óseo positivo: osteomielitis, Wagner 3. Se hospitaliza para radiografía o resonancia, desbridamiento quirúrgico con biopsia ósea para cultivo, descarga absoluta y antibióticos parenterales prolongados.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 65 años, diabético en tratamiento con esquema intensificado de insulina, presenta desde hace unas semanas úlcera en zona plantar derecha, asociado a secreción purulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones y afebril, se aprecia úlcera bajo la articulación metatarsofalángica del primer ortejo derecho, con compromiso de piel, tejido subcutáneo y tendones, sin signos de compromiso óseo ni articular. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Antibióticos vía oral y curaciones ambulatorias
B) Angiografía
C) Amputación abierta
D) Amputación cerrada
E) Antibióticos endovenosos y debridación quirúrgica

Respuesta E. Es una úlcera plantar infectada, purulenta y profunda, con compromiso de tendones pero sin signos de osteomielitis ni de sepsis. Corresponde hospitalizar para antibióticos endovenosos de amplio espectro y debridación quirúrgica del tejido desvitalizado. Los antibióticos orales y las curaciones ambulatorias no bastan en una infección profunda, y la amputación se reserva para la osteomielitis extens

4.01.1.052 Escaras

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlcera por presión: lesión por presión mantenida sobre prominencias óseas (sacro, trocánteres, talones, isquion) en pacientes inmovilizados, desnutridos, incontinentes o con alteración de conciencia.
- Clasificación: grado I eritema que no blanquea con piel intacta; II pérdida parcial de dermis (flictena); III pérdida total de piel hasta tejido subcutáneo; IV exposición de músculo, tendón o hueso.
- Prevención (lo más importante): cambios de posición cada 2 horas, colchón antiescaras, piel limpia y seca, manejo de incontinencia, nutrición e hidratación adecuadas; escala de Braden para riesgo.
- Tratamiento: alivio de presión, aseo con suero fisiológico, desbridamiento del tejido necrótico, apósitos según exudado, tratar infección y optimizar nutrición (proteínas).
- Seguimiento completo: curaciones y control por médico general y enfermería; derivar a cirugía si grado IV, osteomielitis o necesidad de colgajo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 84 años, postrada tras un accidente cerebrovascular, con incontinencia urinaria y desnutrición, vive con su hija. En la visita domiciliaria se observa eritema que no blanquea a la presión en la zona sacra, con piel indemne. **¿Cuál es la medida más importante para evitar la progresión de la lesión?**

A) Masaje enérgico de la zona enrojecida
B) Curación con apósito y decúbito supino permanente
C) Antibiótico tópico en la zona
D) Flotador o rosca bajo el sacro
E) Cambios de posición programados cada 2 horas y superficie que redistribuya la presión

Respuesta E. Eritema no blanqueable con piel intacta corresponde a una úlcera por presión categoría 1. La medida clave es aliviar la presión: cambios posturales programados, colchón antiescaras, manejo de la humedad y apoyo nutricional. El masaje de la zona y los flotadores o roscas están contraindicados porque aumentan el daño tisular.

4.01.1.053 Tumores benignos de partes blandas

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Lipoma: tumor más frecuente de partes blandas; masa subcutánea blanda, móvil, indolora, de crecimiento lento. Resección si sintomático, estético o >5 cm (descartar liposarcoma).
- Quiste epidérmico (sebáceo): nódulo dérmico con punto central (poro), contenido queratínico maloliente; se puede infectar (drenaje en agudo, extirpación completa con cápsula en frío).
- Otros: quiste triquilemal (cuero cabelludo), ganglión (dorso de muñeca, sobre vaina tendínea), neurofibroma, dermatofibroma, hemangioma.
- Diagnóstico específico clínico; ecografía si duda sobre naturaleza, profundidad o tamaño.
- Signos de alarma para derivar: >5 cm, profundo (bajo la fascia), crecimiento rápido, dolor o fijación → sospecha de sarcoma. Seguimiento: derivar a cirugía para extirpación según indicación.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años consulta por un aumento de volumen en la espalda que ha crecido muy lentamente en 3 años. Al examen se palpa una masa de 4 cm, blanda, móvil, indolora, no adherida a la piel ni a planos profundos, sin punto central ni signos inflamatorios. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Quiste epidérmico
B) Liposarcoma
C) Lipoma
D) Absceso subcutáneo
E) Linfadenopatía

Respuesta C. Masa subcutánea blanda, móvil, indolora, de crecimiento lento y no adherida a la piel es un lipoma, el tumor benigno de partes blandas más frecuente. El quiste epidérmico está adherido a la piel y suele tener un poro central. Masas mayores de 5 cm, profundas, duras o de crecimiento rápido obligan a descartar sarcoma.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 79 · texto original del banco, sin revisar

Joven con aumento de volumen blando no adherido en muslo derecho (?era en la espalda), estudio inicial:

A) Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)
B) Psoriasis
C) Dermatitis atópica
D) Dermatitis de contacto
E) Liquen plano

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ecografía de piel y partes blandas (REPETIDA DEL 2023)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

4.01.1.054 Tumores malignos de partes blandas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Sarcomas de partes blandas: raros, origen mesenquimal; más frecuentes en extremidades (muslo) y retroperitoneo. Tipos: liposarcoma, leiomiosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado; rabdomiosarcoma en niños.
- Sospechar ante masa >5 cm, profunda a la fascia, de crecimiento progresivo o recurrente tras extirpación. Muchas veces indolora.
- Estudio: RM de la zona (de elección en extremidades), TAC de tórax (metástasis pulmonares, diseminación hematógena).
- No hacer biopsia excisional ni «enucleación» en el APS: la biopsia (core) la planifica el equipo que hará la cirugía definitiva para no contaminar planos.
- Seguimiento: derivar a centro especializado (cirugía oncológica/traumatología oncológica): resección amplia con márgenes y radioterapia según grado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 101**
>
> Paciente de 18 años consulta porque desde hace un año presenta aumento de volumen progresivo en la cara anterior del muslo derecho, que recientemente se ha vuelto doloroso. Al examen se palpa una masa de 10 centímetros de diámetro, de consistencia dura, no pétrea, sin afectación de la piel. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Realizar resección y biopsia
> **B)** Observar evolución
> **C)** Solicitar ecografía de partes blandas
> **D)** Solicitar radiografía de fémur
> **E)** Realizar punción y drenaje
>
> Respuesta C. Masa de más de 5 centímetros, de un año de evolución y crecimiento reciente: bandera roja de sarcoma de partes blandas. Antes de resecar, se estudia con imagen; si no hay resonancia disponible de entrada, la ecografía distingue lo benigno de lo sospechoso y guía el paso siguiente.

4.01.1.055 Abscesos, forúnculos, panadizos, flegmones

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas · Tema 5.1 Infecciones de Piel Comunitarias: Celulitis, Erisipela y Foliculitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Forúnculo: infección del folículo piloso (S. aureus) con nódulo doloroso y pus; ántrax: varios forúnculos confluentes. Absceso: colección de pus con fluctuación. Flegmón: infección difusa del tejido celular subcutáneo sin colección.
- Panadizo: infección del pulpejo (felón) o periungueal (paroniquia). Paroniquia aguda: S. aureus; crónica: Candida en manos húmedas.
- Diagnóstico clínico; ecografía si duda de colección. Banderas rojas: crepitación, dolor desproporcionado, necrosis o toxicidad (fascitis necrotizante → pabellón urgente), compromiso de vaina tendínea (signos de Kanavel).
- Tratamiento completo: drenaje quirúrgico de toda colección (incisión, aseo, mecha); antibiótico si celulitis asociada, compromiso sistémico, inmunosupresión o zona facial: cefadroxilo 500 mg-1 g c/12 h o flucloxacilina 500 mg c/6-8 h por 7 días; clindamicina si alergia o SAMR comunitario.
- Seguimiento completo: curaciones cada 24-48 h; forunculosis recurrente: descolonización (mupirocina nasal, clorhexidina), estudiar diabetes.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 28

Un paciente alcohólico, de 50 años, en situación de calle, consulta por dolor en el antebrazo derecho, muy intenso. Al examen físico se aprecia una lesión grande en el antebrazo derecho, con áreas violáceas, que crepita a la palpación. Su frecuencia cardiaca es de 108x`, con PA: 90/60 mmHg y su hemograma muestra leucocitosis de 17.000. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Loxocelismo cutáneo
B) Celulitis
C) Úlcera por presión
D) Fascitis necrosante
E) Miositis necrosante

Respuesta D. Dolor muy intenso, áreas violáceas y crepitación (gas tisular), con taquicardia, hipotensión y leucocitosis: fascitis necrotizante.

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años, sin enfermedades crónicas, consulta por 4 días de dolor y aumento de volumen en el glúteo derecho. Al examen hay una masa de 4 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con mínimo eritema perilesional. Está afebril y en buen estado general. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Antibiótico oral por 10 días y control
B) Hospitalizar para antibióticos endovenosos
C) Calor local y observar si drena espontáneamente
D) Solicitar ecografía de partes blandas antes de cualquier tratamiento
E) Drenaje quirúrgico con anestesia local, aseo de la cavidad y curaciones

Respuesta E. Un absceso fluctuante se trata drenándolo: incisión con anestesia local, vaciamiento y aseo de la cavidad, y curaciones. Los antibióticos por sí solos no penetran la colección y se reservan para celulitis extensa, compromiso sistémico o inmunosupresión.

Pregunta de práctica

Hombre de 32 años, sin comorbilidades, con 5 días de un nódulo doloroso en la axila derecha. Al examen hay una lesión de 3 cm, eritematosa, caliente y fluctuante, con mínima celulitis alrededor. Está afebril. **¿Cuál es el tratamiento principal?**

A) Compresas tibias y control en 1 semana
B) Cefadroxilo oral como única medida
C) Incisión y drenaje del absceso
D) Hospitalizar para vancomicina endovenosa
E) Punción con aguja fina para cultivo y observar

Respuesta C. Una colección fluctuante es un absceso y su tratamiento fundamental es la incisión y el drenaje. En un paciente sano, afebril y sin celulitis extensa, el antibiótico no es necesario; se agrega si hay compromiso sistémico, celulitis importante, inmunosupresión o una ubicación de riesgo. El antibiótico solo no resuelve una colección.

4.01.1.056 Secuelas de quemaduras

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Secuelas de quemaduras: cicatrices hipertróficas (limitadas a la herida, mejoran con el tiempo), queloides (exceden el borde), contracturas y bridas que limitan movilidad, alteraciones pigmentarias.
- Mayor riesgo en quemaduras profundas (AB y B o 2° profunda/3° grado), cicatrización >21 días, zonas de flexión (cuello, axila, codo, manos) y niños.
- Úlcera de Marjolin: carcinoma escamoso sobre cicatriz de quemadura crónica; biopsiar toda úlcera persistente en cicatriz antigua.
- Prevención y manejo inicial: prendas compresivas por 6-12 meses, láminas de silicona, hidratación, protección solar, kinesioterapia y férulas para evitar contracturas.
- Seguimiento: derivar a cirugía plástica/unidad de quemados para manejo de bridas (Z-plastias, injertos, colgajos), rehabilitación y apoyo psicológico. Gran quemado es GES.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 161

Hombre de 52 años, con una gran cicatriz de una quemadura antigua en el muslo derecho, que cicatrizó por segunda intención, refiere que desde hace 2 años presenta una úlcera en relación con la cicatriz. Al examen se observa una úlcera de 2 cm en medio de la cicatriz. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tratamiento con nitrógeno líquido
B) Aseo quirúrgico
C) Resección amplia
D) Biopsia incisional
E) Curaciones con povidona y suero fisiológico

Respuesta D. Una úlcera crónica que no cicatriza sobre una cicatriz de quemadura antigua hace sospechar una úlcera de Marjolin, habitualmente un carcinoma espinocelular. Primero debe confirmarse con biopsia incisional de bordes y lecho; con el diagnóstico se planifica la resección amplia. Resecar sin histología o solo hacer curaciones retrasa el tratamiento oncológico.

4.01.1.057 Cicatrices viciosas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Cicatriz hipertrófica: elevada, eritematosa, confinada al borde de la herida, aparece en semanas y tiende a mejorar en 6-12 meses; frecuente en zonas de tensión y flexión.
- Queloide: sobrepasa los márgenes de la herida original, persiste o crece, no regresa espontáneamente; predisposición genética, piel oscura, zonas como lóbulo auricular, esternón, hombros.
- Cicatrices viciosas también incluyen retráctiles (bridas que limitan movimiento), deprimidas y ensanchadas; factores: infección, tensión, mala técnica de sutura, cierre por segunda intención.
- Manejo inicial: compresión, silicona en gel o lámina, masaje, fotoprotección; infiltración con corticoide (triamcinolona) en queloides y cicatrices hipertróficas refractarias.
- Seguimiento: derivar a cirugía plástica/dermatología queloides, bridas funcionales o cicatrices estéticamente relevantes (resección + terapia adyuvante; los queloides recidivan frecuentemente si solo se extirpan).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 20 años consulta por una lesión firme, brillante y pruriginosa en el lóbulo de la oreja izquierda, que apareció 4 meses después de una perforación para aros y ha seguido creciendo, sobrepasando los límites de la herida original. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Resección quirúrgica simple aislada
B) Infiltración intralesional de corticoides
C) Crema antibiótica
D) Observación, porque regresa espontáneamente
E) Radioterapia exclusiva

Respuesta B. Una cicatriz que crece más allá de los bordes de la herida original y no regresa es un queloide; la cicatriz hipertrófica se limita a la herida y tiende a mejorar. El tratamiento inicial es la infiltración intralesional de corticoides, asociada a presoterapia o láminas de silicona. La resección aislada tiene una recurrencia muy alta.

4.01.1.058 Condilomas

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 3.5 Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) II: Uretritis, Úlceras Genitales y VPH

QUÉ HAY QUE SABER

- Condilomas acuminados: infección por VPH de bajo riesgo (6 y 11); pápulas exofíticas, en coliflor, del color de la piel, en genitales, periné y región perianal; transmisión sexual.
- Diagnóstico clínico; biopsia si lesión atípica, pigmentada, ulcerada, indurada, refractaria o en inmunosuprimido. Perianales: realizar anoscopía para lesiones intraanales.
- Asociados a otras ITS: ofrecer VIH, sífilis (diferenciar de condiloma plano sifilítico), hepatitis B; examinar y tratar pareja. En mujeres, PAP según programa.

- Tratamiento inicial: crioterapia, podofilotoxina 0,5% (autoaplicada; contraindicada en embarazo), imiquimod 5% o ácido tricloroacético 80-90% (seguro en embarazo).
- Seguimiento: derivar a dermatología/coloproctología/ginecología si extensos, intraanales, refractarios o en inmunosuprimidos. Prevención: vacuna VPH en el PNI escolar y preservativo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 24 años, cursando un embarazo de 20 semanas, consulta por múltiples verrugas exofíticas pequeñas e indoloras en la vulva. El resto del examen es normal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
>
> **A)** Podofilina tópica
> **B)** Crioterapia o ácido tricloroacético
> **C)** Imiquimod tópico
> **D)** Cesárea programada por los condilomas
> **E)** Aciclovir oral
>
> Respuesta B. Los condilomas acuminados, por VPH 6 y 11, se tratan en la embarazada con métodos locales físicos o químicos: crioterapia, ácido tricloroacético o resección. La podofilina y la podofilotoxina están contraindicadas por toxicidad fetal, y el imiquimod no se recomienda. La cesárea solo se indica si las lesiones obstruyen el canal o hay riesgo de sangrado.

4.01.1.059 Onicocriptosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: cirugia-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Onicocriptosis (uña encarnada): borde lateral de la uña, casi siempre del ortejo mayor, incrustado en el rodete periungueal; factores: corte curvo o muy corto, calzado estrecho, hiperhidrosis.
- Estadios: I inflamación (eritema, edema, dolor), II infección con supuración, III tejido de granulación hipertrófico y cronicidad.
- Tratamiento conservador en estadio I: baños de agua tibia, corte recto de la uña, levantar el borde con algodón o mecha, calzado amplio; antibiótico (cefadroxilo) solo si celulitis.
- Tratamiento completo en estadio II-III o recurrente: onicectomía parcial del borde afectado con matricectomía (química con fenol o quirúrgica) bajo anestesia troncular del ortejo.
- Seguimiento completo: curaciones diarias por 1-2 semanas, educación de corte recto; precaución en diabéticos y enfermedad arterial (riesgo de mala cicatrización): evaluar pulsos antes de operar.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Adolescente de 16 años consulta por dolor en el borde lateral del ortejo mayor derecho de 1 semana, con eritema leve y edema del pliegue ungueal, sin secreción purulenta ni tejido de granulación. Refiere que se corta las uñas en forma curva y usa zapatillas estrechas. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**
>
> **A)** Onicectomía total
> **B)** Onicectomía parcial con matricectomía
> **C)** Antibiótico oral por 14 días
> **D)** Manejo conservador: baños tibios, levantar el borde ungueal con algodón, calzado holgado y corte recto de la uña
> **E)** Antifúngico tópico
>
> Respuesta D. La onicocriptosis leve (dolor, eritema y edema, sin pus ni granuloma) se maneja en forma conservadora: higiene, baños tibios, elevar el borde con algodón, calzado amplio y cortar la uña recta. La onicectomía parcial con matricectomía se reserva para casos moderados a severos o recurrentes.

4.01.1.060 Obesidad mórbida

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: cirugia-20

QUÉ HAY QUE SABER

- Obesidad mórbida: IMC ≥40 kg/m² o ≥35 con comorbilidades (DM2, HTA, apnea del sueño, dislipidemia, artrosis, hígado graso). Chile tiene alta prevalencia de obesidad.

- Evaluar causas secundarias (hipotiroidismo, Cushing, fármacos) y comorbilidades: glicemia/HbA1c, perfil lipídico, pruebas hepáticas, TSH, PA, tamizaje de apnea (STOP-BANG).
- Manejo inicial: cambios de estilo de vida (dieta hipocalórica, actividad física), terapia conductual y fármacos (liraglutida/semaglutida, orlistat) como coadyuvantes.
- Cirugía bariátrica indicada en IMC ≥40 o ≥35 con comorbilidad tras fracaso de tratamiento médico, con evaluación multidisciplinaria (manga gástrica, bypass gástrico en Y de Roux).
- Seguimiento: derivar a equipo de cirugía bariátrica/nutrición; postoperatorio requiere suplementación de por vida (hierro, B12, calcio, vitamina D) y control de déficit nutricional.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 75**
> Mujer de 35 años, con antecedente de bypass gástrico hace 1 año, presenta crisis de mareos, palpitaciones, malestar general y diarrea, que aparecen después de comer. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Hipoglicemias reactivas
> **B)** Síndrome de dumping
> **C)** Hernia del espacio de Petersen
> **D)** Estenosis de la anastomosis
> **E)** Déficit de vitamina B12
>
> Respuesta B. Síntomas vasomotores (mareo, palpitaciones) y digestivos (diarrea) poco después de comer, tras un bypass gástrico, son típicos del síndrome de dumping precoz, por llegada rápida de contenido hiperosmolar al intestino. Se maneja con comidas pequeñas y frecuentes, evitando azúcares simples. La hipoglicemia reactiva es más tardía y no explica la diarrea.

Situaciones clínicas de urgencia 31 códigos

4.01.2.001 Esofagitis cáustica

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Ingesta de cáusticos: álcalis (soda cáustica, destapadores; necrosis por licuefacción, más daño esofágico) y ácidos (necrosis por coagulación, más daño gástrico). En niños accidental; en adultos frecuentemente intento suicida.
- Clínica: odinofagia, disfagia, sialorrea, dolor retroesternal, lesiones orales (su ausencia no descarta daño esofágico); estridor o disfonía indican compromiso de vía aérea; dolor intenso, enfisema o peritonismo sugieren perforación.
- Diagnóstico específico: endoscopía alta precoz (idealmente 12-24 h, evitar entre día 5 y 15) para clasificar el daño (Zargar); Rx/TAC de tórax y abdomen si sospecha de perforación.
- Tratamiento inicial: ABC, régimen cero, hidratación IV, IBP, analgesia. NO inducir vómito, NO neutralizar, NO lavado gástrico ni carbón activado, NO SNG a ciegas.
- Seguimiento: derivar a centro con endoscopía y cirugía; complicaciones: estenosis esofágica (semanas), perforación y mayor riesgo de cáncer escamoso a largo plazo. Evaluación por psiquiatría si fue intencional.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años llega a urgencias 2 horas después de ingerir, con intención suicida, un vaso de destapador de cañerías a base de soda cáustica. Presenta sialorrea, odinofagia y dolor retroesternal. PA 120/75 mmHg, FC 104 por minuto, sin enfisema subcutáneo ni signos peritoneales. Radiografía de tórax y abdomen sin aire libre. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Inducir el vómito y administrar carbón activado
B) Neutralizar con vinagre diluido por sonda nasogástrica
C) Esofagectomía de urgencia
D) Endoscopía digestiva alta diferida a las 3 semanas
E) Régimen cero, hidratación endovenosa, analgesia y endoscopía digestiva alta en las primeras 12 a 24 horas

Respuesta E. Sin signos de perforación, se estabiliza con régimen cero y se hace endoscopía precoz (12–24 h, evitando el período de mayor fragilidad entre el día 3 y la semana 3) para graduar la lesión y definir el manejo. No se induce vómito, no se neutraliza ni se usa carbón. Requiere además evaluación psiquiátrica.

4.01.2.002 Abdomen agudo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

QUÉ HAY QUE SABER

- Abdomen agudo: dolor abdominal de inicio reciente (<7 días) que requiere diagnóstico y eventual tratamiento quirúrgico urgente. Causas: inflamatorias (apendicitis, colecistitis, diverticulitis), obstructivas, perforativas, vasculares, hemorrágicas.
- Anamnesis: inicio, localización y migración, irradiación, vómitos, fiebre, tránsito; en mujer en edad fértil siempre β-hCG (embarazo ectópico). Examen: signos peritoneales (Blumberg, rigidez), Murphy, Rovsing, hernias, tacto rectal.
- Exámenes: hemograma, PCR, lipasa, pruebas hepáticas, orina completa, β-hCG; imágenes: ecografía (biliar, ginecológica, niños) o TAC de abdomen y pelvis; Rx de tórax de pie para neumoperitoneo.
- Tratamiento inicial: régimen cero, hidratación IV, analgesia (no enmascara el diagnóstico; opioide si es intenso), SNG si vómitos u obstrucción, antibióticos si sospecha de infección intraabdominal.
- Banderas rojas: shock, peritonitis difusa, dolor desproporcionado al examen (isquemia mesentérica), adulto mayor o inmunosuprimido con poca semiología. Seguimiento: derivar a cirugía.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años consulta por 8 horas de dolor en el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. Afebril, presión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 92. Tiene dolor a la palpación profunda de la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales. Su última menstruación fue hace 7 semanas y no usa anticoncepción. **¿Cuál es el primer examen que se debe solicitar?**

A) TAC de abdomen y pelvis con contraste
B) Amilasa y lipasa
C) Radiografía simple de abdomen
D) Subunidad beta de gonadotrofina coriónica
E) Colonoscopía

Respuesta D. En toda mujer en edad fértil con abdomen agudo, lo primero es descartar embarazo con subunidad beta. Con atraso menstrual, un embarazo ectópico debe descartarse antes que cualquier otra causa, y el resultado además condiciona el uso de radiación como la TAC.

4.01.2.003 Peritonitis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) · Tema 1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Peritonitis secundaria (la más frecuente): por perforación de víscera hueca o filtración (úlcera perforada, apendicitis, diverticulitis); polimicrobiana. Primaria (PBE): cirrótico con ascitis, monomicrobiana.
- Clínica: dolor abdominal difuso intenso, abdomen en tabla, Blumberg positivo, inmovilidad, fiebre, taquicardia, íleo; puede evolucionar a shock séptico.

- Diagnóstico específico: Rx de tórax de pie (neumoperitoneo) o TAC de abdomen; laboratorio con leucocitosis y PCR elevada, lactato. PBE: paracentesis con PMN ≥250/mm³.
- Tratamiento inicial: reanimación con cristaloides, antibióticos IV de amplio espectro precoces (ceftriaxona + metronidazol; piperacilina-tazobactam si grave), régimen cero, SNG, analgesia, Foley para diuresis.
- Seguimiento: derivar a cirugía urgente para control del foco (laparotomía/laparoscopía, aseo peritoneal). PBE no es quirúrgica: cefotaxima/ceftriaxona + albúmina.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 169

Paciente de 43 años, multípara, con dolor abdominal difuso, intenso y vómitos, con marcado meteorismo. Frecuencia cardíaca de 110 y presión arterial de 100/60. Al examen abdominal se observa cicatriz de cesárea, con abdomen muy doloroso a la palpación, distensión de la pared, pérdida de la matidez hepática a la percusión y abolición de los ruidos hidroaéreos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación intestinal
D) Megacolon
E) Embolia mesentérica

Respuesta C. La pérdida de la matidez hepática indica neumoperitoneo, propio de una perforación. Sumado a la abolición de los ruidos hidroaéreos y el dolor intenso y difuso, el cuadro es de una peritonitis secundaria a perforación intestinal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 162

Paciente de 43 años con dolor epigástrico urente de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve difuso y persistente, con distensión abdominal. Frecuencia cardíaca de 110 y presión arterial de 110/70. El abdomen está doloroso y distendido, con pérdida de la matidez hepática y ruidos hidroaéreos abolidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación de úlcera péptica
D) Plastrón vesicular
E) Cáncer de vesícula

Respuesta C. El mes de epigastralgia urente que mejoraba con la comida marca una úlcera activa de fondo. El cambio brusco a dolor difuso, íleo y pérdida de la matidez hepática es la perforación de esa misma úlcera hacia el peritoneo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 162

Un paciente de 43 años presenta dolor epigástrico urente, de un mes de evolución. Hace 24 horas deja de eliminar gases y el dolor se vuelve difuso y persistente, agregándose distensión abdominal. Al examen tiene frecuencia cardíaca de 110 por minuto, presión arterial de 110/70, abdomen doloroso y distendido, con pérdida de la matidez hepática y ruidos hidroaéreos abolidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Obstrucción intestinal
B) Pancreatitis aguda
C) Perforación de úlcera péptica
D) Plastrón vesicular
E) Cáncer de vesícula

Respuesta C. Toda la clínica es de úlcera perforada: epigastralgia urente previa (síndrome ulceroso), y luego dolor intenso y difuso con íleo paralítico por la peritonitis (distensión, ruidos hidroaéreos abolidos) más el signo de neumoperitoneo, la pérdida de la matidez hepática, porque el aire libre se interpone entre el hígado y la pared.

4.01.2.004 Hemorragia digestiva alta

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

QUÉ HAY QUE SABER

- HDA: sangrado proximal al ángulo de Treitz; hematemesis (sangre roja o en «concho de café») y/o melena. Causas: úlcera péptica (más frecuente), várices esofágicas (cirrótico), Mallory-Weiss, esofagitis, cáncer.
- Evaluar gravedad: PA, FC, índice de shock, perfusión; hemoglobina inicial puede ser normal. Escala de Glasgow-Blatchford para decidir manejo ambulatorio vs hospitalización.

- Tratamiento inicial: 2 vías venosas gruesas, cristaloides, transfusión con Hb <7 g/dl (<8-9 en coronarios), corregir coagulación, régimen cero; IBP en bolo IV (omeprazol 80 mg) y luego infusión o 40 mg c/12 h.
- Sospecha de várices: octreótido (o terlipresina), ceftriaxona profiláctica 1 g/día, transfusión restrictiva. Balón de Sengstaken como puente si sangrado masivo incontrolable.
- Seguimiento: derivar para endoscopía alta en <24 h (antes si inestable): diagnóstico y terapia hemostática; erradicar H. pylori y suspender AINE en úlcera.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 58 años, usuario de ibuprofeno por lumbago, consulta por hematemesis y melena. Ingresa con FC 110 lpm y PA 95/60 mmHg; se reanima con cristaloides y se inicia omeprazol endovenoso. La endoscopía a las 12 horas muestra una úlcera duodenal de 1,5 cm con un vaso visible no sangrante. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Mantener solo omeprazol oral y dar de alta
> **B)** Cirugía de urgencia con vagotomía y piloroplastía
> **C)** Terapia endoscópica combinada (adrenalina más método térmico o clips) y omeprazol endovenoso
> **D)** Embolización arterial como primera opción
> **E)** Repetir la endoscopía en 1 semana sin tratamiento endoscópico
>
> Respuesta C. Un vaso visible no sangrante (Forrest IIa) tiene alto riesgo de resangrado, por lo que requiere terapia endoscópica, idealmente combinada (adrenalina asociada a método térmico o mecánico), seguida de inhibidor de bomba de protones endovenoso en altas dosis. La cirugía y la embolización se reservan para el fracaso del tratamiento endoscópico.

4.01.2.005 Obstrucción Intestinal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- Obstrucción intestinal: dolor cólico, vómitos, distensión y detención del tránsito de gases y deposiciones. Delgado: causas bridas (la principal) y hernias; colon: cáncer, vólvulo de sigmoides, diverticulitis.
- Examen: distensión, ruidos de lucha (metálicos) o silencio tardío; buscar cicatrices y hernias, tacto rectal (masa, ampolla vacía).
- Diagnóstico específico: Rx de abdomen de pie y acostado (asas dilatadas, niveles hidroaéreos, imagen en «grano de café» en vólvulo de sigmoides) y TAC de abdomen (sitio, causa y signos de sufrimiento).
- Estrangulación (dolor continuo, fiebre, taquicardia, peritonismo, leucocitosis, lactato elevado) es urgencia quirúrgica.
- Tratamiento inicial: régimen cero, SNG a caída libre, hidratación IV y corrección electrolítica (hipokalemia), Foley, analgesia. Seguimiento: derivar a cirugía; bridas sin estrangulación pueden manejarse conservadoramente 48-72 h; vólvulo de sigmoides: devolvulación endoscópica.

PREGUNTAS (12)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 59**
>
> Un paciente de 60 años, que hace tres años se habría realizado una colecistectomía con coledocostomía, consulta por cuadro de dolor abdominal tipo cólico intenso, asociado a vómitos alimentarios. No ha podido eliminar gases. Al examen físico presenta dolor difuso a la palpación abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y tonalidad, con Blumberg presente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Obstrucción intestinal
> **B)** Trombosis venosa mesentérica
> **C)** Embolia mesentérica
> **D)** Pancreatitis
> **E)** Diverticulitis
>
> Respuesta A. El antecedente de cirugía abdominal previa (colecistectomía con coledocostomía) sumado a dolor cólico, vómitos, detención de gases y ruidos hidroaéreos metálicos aumentados es la presentación clásica de obstrucción intestinal por bridas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 130

Recién nacido de 4 semanas de vida presenta vómitos posprandiales abundantes, desde hace una semana, asociados a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y toma leche ávidamente. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar radiografía de abdomen simple
B) Realizar tratamiento endoscópico
C) Observar evolución
D) Realizar pilorotomía de Ramstedt
E) Realizar funduplicatura gástrica

Respuesta D. El cuadro es una estenosis hipertrófica del píloro clásica: vómitos posprandiales abundantes desde la cuarta semana, con detención del incremento de peso y un lactante ávido por comer. De las conductas ofrecidas, la que resuelve el cuadro es la pilorotomía de Ramstedt (siempre después de corregir la hidratación y los electrolitos, aunque acá el enunciado no los mencione).

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 175

Niño de 48 horas de vida, con antecedente de síndrome de Down, presenta vómitos alimentarios explosivos, asociados a irritabilidad y decaimiento. Al examen abdominal se palpa abdomen blando, doloroso, con distensión epigástrica, que desaparece después de vomitar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Atresia esofágica
B) Hiperplasia suprarrenal congénita
C) Enterocolitis necrotizante
D) Atresia duodenal
E) Estenosis hipertrófica del píloro

Respuesta D. Vómitos explosivos desde las primeras horas de vida, con distensión epigástrica que cede al vomitar, en un recién nacido con síndrome de Down: atresia duodenal. La radiografía mostraría la doble burbuja. La estenosis del píloro aparece más tarde, entre la segunda y la sexta semana, no a las cuarenta y ocho horas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 130

Recién nacido de 4 semanas con vómitos postprandiales abundantes desde hace una semana, asociados a detención del incremento ponderal. La madre refiere que lo nota hambriento y que toma leche con avidez. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar radiografía de abdomen simple
B) Realizar tratamiento endoscópico
C) Observar la evolución
D) Realizar piloromiotomía de Ramstedt
E) Realizar funduplicatura gástrica

Respuesta D. Cuadro clásico de estenosis hipertrófica del píloro. Lo ideal sería confirmar primero con ecografía, pero de las opciones disponibles, la piloromiotomía de Ramstedt es el tratamiento de elección (siempre corrigiendo antes la deshidratación y la alcalosis).

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años, con antecedente de cirugía abdominal hace 15 años, consulta por dolor cólico, distensión y vómitos biliosos de 20 horas de evolución, sin eliminar gases ni deposiciones. Afebril, hemodinámicamente estable, abdomen distendido con ruidos hidroaéreos metálicos aumentados, sin signos de irritación peritoneal. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Laparotomía exploradora de urgencia
B) Sonda nasogástrica a caída libre, hidratación endovenosa y observación
C) Colonoscopía descompresiva de urgencia
D) Enemas evacuantes repetidos y laxantes orales
E) Antibióticos de amplio espectro y alta con control ambulatorio

Respuesta B. Obstrucción intestinal por bridas, sin signos de estrangulación (afebril, estable, sin peritonismo). El tratamiento inicial es médico conservador: sonda nasogástrica, hidratación endovenosa y vigilancia clínica durante 24 a 48 horas, ya que 70 a 80% resuelve sin cirugía.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 173 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con apendicectomía previa, ahora con dolor abdominal cólico, distensión progresiva y sin eliminación de gases ni heces. ¿Diagnóstico más probable?

A) Obstrucción intestinal por bridas
B) Vólvulo de colon sigmoide
C) Ileo paralítico postoperatorio
D) Hernia inguinal incarcerada
E) Cáncer de colon obstructivo

Respuesta A. Diagnóstico: Obstrucción intestinal por bridas (opción A). Obstrucción intestinal por bridas. Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 53 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 38 años, con antecedente de cirugía bariátrica, consulta por dolor abdominal tipo cólico y vómitos de 10 horas de evolución, que inició al día siguiente de una gran ingesta de alcohol y alimentos. Refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico está adolorido, con FC: 106x', PA: 120/80 mmHg, T°: 37,6°C. El abdomen se aprecia distendido y es doloroso a la palpación, sin Blumberg. Se auscultan los ruidos hidroaéreos aumentados de intensidad y bazuqueo. El diagnóstico más probable es:

A) Pancreatitis aguda
B) Embolia mesentérica
C) Úlcera gastroduodenal complicada
D) Colecistitis aguda
E) Obstrucción intestinal por bridas

Respuesta E. Es una obstrucción intestinal clásica, cuya causa más frecuente son las bridas (en especial en pacientes con antecedente de cirugía abdominal previa).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 68 años, sin antecedentes conocidos, consulta por cuadro de dolor abdominal desde hace 6 horas, asociado a distensión progresiva, vómitos y sensación febril, además refiere que no ha eliminado gases. Al examen físico destaca ausencia de ruidos hidroaéreos y blumberg (+). Se solicita radiografía de abdomen que se muestra a continuación:

A) Gastroenteritis aguda
B) Vólvulo sigmoides
C) Obstrucción intestinal
D) Diverticulitis aguda
E) Apendicitis aguda

Respuesta C. Se ven las asas dilatadas y tiene el cuadro clínico. No se ve la imagen de grano de café, como para haber pensado en vólvulo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 58 años presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a náuseas y distensión abdominal. Sus últimas deposiciones fueron hace dos días y no ha eliminado gases por ano desde ayer. Sus signos vitales muestran T°: 36,8°C, FC: 96x', PA: 144/92 mmHg, abdomen distendido, doloroso a la palpación, con signo Blumberg esbozado. En la auscultación abdominal, tiene bazuqueo intestinal y disminución de los ruidos hidroaéreos. Como antecedentes médico-quirúrgicos, es diabético, usa metformina y aspirina y se realizó apendicectomía hace 10 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Vólvulo de sigmoides
B) Isquemia mesentérica
C) Gastroenteritis aguda
D) Obstrucción intestinal
E) Cáncer de colon perforado

Respuesta D. Diagnóstico: Obstrucción intestinal (opción D). Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 117 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años con antecedente de cirugía bariátrica presenta un cuadro de 24 horas de dolor abdominal muy intenso, tipo cólico, asociado a múltiples episodios de vómitos alimentarios. Al examen físico presenta T°: 38,5°C, frecuencia cardiaca regular a 108 lpm, presión arterial de 100/60 mmHg. Al examen abdominal, se observa abdomen distendido, doloroso a la palpación, con resistencia muscular difusa, se ausculta bazuqueo intestinal y ruidos hidroaéreos intensos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Íleo mecánico por bridas
B) Perforación intestinal
C) Isquemia mesentérica
D) Colitis isquémica
E) Gastroenteritis aguda

Respuesta A. Obstrucción Intestinal por Bridas: El paciente presenta un cuadro clínico de obstrucción intestinal, caracterizado por la tríada de dolor cólico, vómitos y distensión abdominal. En este caso, la causa más probable de la obstrucción son las bridas, debido al antecedente de cirugía abdominal previa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 36 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 56 años, con antecedente de enfermedad de Cröhn, desde los 26 años, sin tratamiento, desde hace 4 meses, presenta un cuadro de dolor abdominal y vómitos, que han ido en aumento. Sus vómitos son de tipo alimentario y al examen físico tiene PA: 110/70 mmHg, FC: 90 x', T°: 37°C, al examen abdominal se observa abdomen distendido, con auscultación de gorgoritmos y ruidos hidroaéreos intensos. Se solicita radiografía, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Cröhn activa
B) Apendicitis aguda
C) Perforación intestinal
D) Vólvulo de sigmoides
E) Obstrucción intestinal

Respuesta E. Es una obstrucción intestinal clásica tanto por la imagen como por la clínica. En este caso, el antecedente de E. Cröhn sugiere que se complicó con una estenosis intestinal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 46 · texto original del banco, sin revisar

Pre unta 46 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 80 años, consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, tipo cólico, intenso, al que se han agregado vómitos alimentarios importantes. El dolor es más intenso en el hemiabdomen superior. Al examen físico se aprecia paciente adolorido, con PA: 110/68 mmHg, FC: 110x', T°: 37,4. Abdomen doloroso a la palpación, con distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados y sin signos de irritación peritoneal. Se solicitan exámenes entre los que destaca PCR: 10 mg/dl, hematocrito: 37%, blancos: 11.000 por mm3, plaquetas: 340.000, GOT: 66 UI/L. El diagnóstico más probable es:

A) Colitis isquémica
B) Trombosis de la vena mesentérica
C) Perforación gástrica
D) Pancreatitis aguda
E) Obstrucción intestinal

Respuesta E. Diagnóstico: Obstrucción intestinal (opción E). Tiene una obstrucción intestinal clásica.. Las hernias se clasifican según su localización. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

4.01.2.006 Apendicitis aguda

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.1 Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía · Tema 5.1 Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Apendicitis aguda: urgencia quirúrgica más frecuente; dolor periumbilical o epigástrico que migra a fosa ilíaca derecha, anorexia, náuseas/vómitos y fiebre baja.
- Signos: dolor en punto de McBurney, Blumberg, Rovsing, psoas y obturador. Escala de Alvarado orienta (≥7 alta probabilidad).
- Diagnóstico específico: clínico + hemograma (leucocitosis con desviación izquierda) y PCR; imagen si duda: ecografía en niños, embarazadas y mujeres jóvenes; TAC en adultos (apéndice >6 mm, no compresible, con alteración de la grasa).

- Poblaciones atípicas: niños pequeños, adultos mayores y embarazadas (dolor más alto) tienen presentación atípica y más perforación; siempre β-hCG en mujer en edad fértil.
- Tratamiento inicial: régimen cero, hidratación IV, analgesia, antibiótico profiláctico (cefazolina o ceftriaxona + metronidazol). Seguimiento: derivar a cirugía para apendicectomía (laparoscópica).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 68

Niña de 7 años con 12 horas de fiebre y dolor hipogástrico. Temperatura 38,7 grados, frecuencia cardíaca 100, presión arterial 100/60. Dolor a la palpación de hipogastrio, Blumberg positivo y resistencia de la pared abdominal. Leucocitos 18.000. Sedimento urinario con 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva 15. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pielonefritis aguda
B) Apendicitis aguda
C) ITU baja
D) Torsión ovárica
E) Plastrón apendicular

Respuesta B. Fiebre, Blumberg positivo, resistencia muscular y leucocitosis marcan una irritación peritoneal focal, propia de apendicitis aguda. Los leucocitos en la orina pueden verse por vecindad de un apéndice inflamado pegado a la vejiga, y no bastan para diagnosticar una infección urinaria por sí solos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 62

Mujer de 25 años con dolor abdominal intenso, mayor en la fosa ilíaca derecha y el hipogastrio, EVA 8/10. Frecuencia cardíaca 90, presión arterial 110/70, abdomen doloroso a la palpación de ambas fosas ilíacas. Dos horas después, presenta deterioro marcado, con frecuencia cardíaca de 120 y presión arterial de 80/40. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda
B) Perforación intestinal
C) Torsión ovárica
D) Absceso tubo-ovárico roto
E) Embarazo ectópico roto

Respuesta A. El dolor bilateral en ambas fosas ilíacas con deterioro hemodinámico brusco en pocas horas corresponde a una apendicitis que perforó y generó una peritonitis con shock séptico incipiente. Los diferenciales ginecológicos no explican igual de bien la instalación tan rápida del shock sobre un dolor que ya venía siendo bilateral.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 68

Niña de 7 años de edad, quien consulta por cuadro de 12 horas de evolución, caracterizada por fiebre y dolor hipogástrico. Al examen físico tiene temperatura 38,7 grados, FC 100x', PA 100/60, dolor a la palpación de hipogastrio, con signo de Blumberg positivo y resistencia en la pared abdominal. Exámenes de laboratorio: 18.000 glóbulos blancos. Sedimento urinario muestra 20 leucocitos por campo. Proteína C reactiva 15. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Pielonefritis aguda
B) Apendicitis aguda
C) ITU baja
D) Torsión ovárica
E) Plastrón apendicular

Respuesta B. Blumberg positivo, resistencia de la pared abdominal, fiebre y leucocitosis: es una apendicitis aguda clásica. Los leucocitos en el sedimento urinario confunden con una infección urinaria, pero son un hallazgo acompañante frecuente cuando el apéndice inflamado está cerca de la vejiga, no el diagnóstico principal.

Pregunta de práctica

Hombre de 22 años consulta por dolor que comenzó hace 14 horas en el epigastrio y hace 4 horas se trasladó a la fosa ilíaca derecha. Tiene anorexia y una náusea. Temperatura 37,6 grados, dolor exquisito en McBurney con Blumberg positivo. Leucocitos 12.500 con 78% de neutrófilos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar TAC de abdomen y pelvis antes de decidir
B) Indicar profilaxis antibiótica y apendicectomía directa
C) Solicitar ecografía abdominal de urgencia
D) Iniciar antibióticos orales y observar 24 horas
E) Solicitar radiografía simple de abdomen de pie

Respuesta B. El caso suma 8 puntos en el score de Alvarado: migración (1), anorexia (1), náuseas (1), dolor en FID (2), Blumberg (1), neutrofilia (1) y leucocitosis (2). En un hombre joven con esta clínica y score alto, la conducta es apendicectomía directa, sin necesidad de imágenes.

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años con 6 días de dolor en la fosa ilíaca derecha, que comenzó en la región periumbilical. Temperatura 38 °C. Al examen se palpa una masa dolorosa en la fosa ilíaca derecha, sin signos peritoneales en el resto del abdomen. La ecografía muestra un conglomerado inflamatorio que envuelve el apéndice. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Apendicectomía de urgencia
B) Antibióticos endovenosos y apendicectomía diferida a las 6–8 semanas
C) Alta con analgésicos y control en 48 horas
D) Colonoscopía para descartar cáncer de ciego
E) Laparotomía exploradora con lavado peritoneal

Respuesta B. Masa en la FID con varios días de evolución y sin peritonitis difusa: plastrón apendicular. El epiplón contuvo el proceso; se trata con antibióticos (ceftriaxona + metronidazol) y apendicectomía diferida a las 6–8 semanas. La cirugía inmediata es para la apendicitis perforada con peritonitis difusa.

4.01.2.007 Isquemia mesentérica aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

QUÉ HAY QUE SABER

- Isquemia mesentérica aguda: causa embólica (fibrilación auricular, IAM reciente; arteria mesentérica superior) la más frecuente, también trombosis arterial, trombosis venosa mesentérica e isquemia no oclusiva (shock, vasoconstrictores).
- Clave: dolor abdominal intenso, desproporcionado al examen físico (abdomen blando al inicio), en adulto mayor con FA o enfermedad cardiovascular; luego vómitos, diarrea sanguinolenta y peritonitis.
- Laboratorio: leucocitosis, acidosis metabólica con lactato elevado (tardío). Diagnóstico: angioTAC de abdomen de urgencia.
- Tratamiento inicial: reanimación con fluidos, oxígeno, anticoagulación con heparina no fraccionada IV, antibióticos de amplio espectro, régimen cero, corregir causa de bajo gasto.
- Seguimiento: derivar de inmediato a cirugía/cirugía vascular (embolectomía, revascularización, resección de intestino necrótico); mortalidad alta (>50%) y crece con el retraso.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 100

Una paciente de 65 años, con antecedente de accidente vascular encefálico con compromiso faciobraquiocrural derecho hace dos años en tratamiento con aspirina, consulta por dolor abdominal difuso e intenso de inicio agudo. Al examen físico se encuentra en regulares condiciones, ritmo irregular, abdomen levemente doloroso a la palpación profunda, Blumberg negativo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Isquemia mesentérica
B) Disección aórtica
C) Úlcera perforada
D) Diverticulitis aguda
E) Trombosis mesentérica

Respuesta A. El ritmo irregular delata la fibrilación auricular, la fuente del émbolo. El dolor es agudo y difuso, pero el abdomen está apenas doloroso y Blumberg es negativo: esa disociación clínica es la firma de la embolia de la arteria mesentérica superior. La trombosis mesentérica (E) da un cuadro más subagudo, de días, con peritoneo más precoz.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 15

Una mujer de 62 años acude al servicio de urgencia por dolor abdominal intenso, de dos horas de evolución, difuso, pero mayor en hemiabdomen superior. Además, presentó vómitos alimentarios, en varias oportunidades. El dolor inició tipo cólico, pero luego se hizo permanente. Al examen físico tiene IMC 32, temperatura 36,7 °C, frecuencia cardíaca 108x', presión arterial 102/96 mmHg. Examen cardiopulmonar normal. El examen abdominal muestra cicatriz de cesárea Pfannenstiel, timpanismo y disminución de la matidez hepática a la percusión, con ruidos hidroaéreos muy disminuidos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Obstrucción intestinal
B) Perforación intestinal
C) Vólvulo de sigmoides
D) Trombosis de la vena mesentérica
E) Embolia mesentérica

Respuesta D. La cesárea reciente es un estado protrombótico y quirúrgico, el terreno típico de la trombosis venosa mesentérica, no de la embolia (que necesita una fuente cardíaca, ausente aquí). El dolor que empieza cólico y se hace permanente, en horas, encaja con la evolución subaguda que distingue a la trombosis de la embolia súbita.

Pregunta de práctica

Mujer de 76 años con fibrilación auricular no anticoagulada. Dolor abdominal brusco hace 4 horas, 10/10, difuso, con 2 vómitos y una deposición diarreica. Abdomen blando, depresible, levemente sensible, sin defensa ni Blumberg. Taquicárdica, lactato elevado. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Analgesia y reevaluación seriada del abdomen hasta que aparezcan signos peritoneales
B) Heparina endovenosa y angio-TAC mesentérico urgente
C) Colonoscopía urgente
D) Hidratación y manejo como gastroenteritis aguda
E) TAC de abdomen sin contraste

Respuesta B. FA no anticoagulada + dolor súbito intensísimo + abdomen blando (disociación clínica) + lactato alto: embolia de la arteria mesentérica superior. Se anticoagula con heparina ante la sospecha y se confirma con angio-TAC para revascularizar. Esperar el peritonismo es llegar con el intestino necrosado.

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con ateroesclerosis, tras un episodio de hipotensión por una hemorragia digestiva, presenta dolor cólico en el flanco izquierdo y elimina deposiciones con sangre roja. Abdomen sensible en el flanco izquierdo, sin peritonismo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Embolia de la arteria mesentérica superior
B) Trombosis venosa mesentérica
C) Colitis isquémica
D) Diverticulitis aguda
E) Enfermedad de Crohn

Respuesta C. Dolor en el hemiabdomen izquierdo + hematoquecia en un adulto mayor ateroesclerótico, precipitado por hipotensión (bajo flujo): colitis isquémica de las zonas frontera. Suele ser transitoria y responde a manejo médico. La embolia da dolor más intenso y difuso, con disociación clínica, en contexto de FA.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 96 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 66 años, hipertenso, cardiópata, en tratamiento anticoagulante por una fibrilación auricular crónica, consulta por dolor abdominal brusco, muy intenso, de 6 horas de evolución. Al examen físico presenta ritmo irregular en 2 tiempos y abdo- men doloroso a la palpación, con signos peritoneales difusos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis de la vena mesentérica
B) Hemoperitoneo
C) Úlcera péptica perforada
D) Embolia mesentérica
E) Aneurisma aórtico abdominal roto

Respuesta D. Es una embolia mesentérica clásica, por la FA. Sin embargo, suele cursar sin signos peritoneales al inicio, pero había pasado ya mucho tiempo, por lo que sí aparecen di- chos signos.

4.01.2.008 Enfermedad diverticular complicada

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Diverticulitis complicada: con absceso, perforación (peritonitis purulenta o fecaloidea), fístula (colovesical: neumaturia y fecaluria) u obstrucción. Clasificación de Hinchey (I absceso pericólico, II pélvico/distante, III peritonitis purulenta, IV fecaloidea).
- Sospechar en dolor en fosa ilíaca izquierda con fiebre, masa palpable, signos peritoneales o compromiso sistémico; mayor riesgo en inmunosuprimidos, adultos mayores, uso de corticoides.
- Confirmación con TAC de abdomen y pelvis con contraste (engrosamiento, absceso, aire libre).
- Tratamiento inicial: hospitalizar, régimen cero, hidratación, antibióticos IV (ceftriaxona + metronidazol o piperacilina-tazobactam); absceso >3-4 cm: drenaje percutáneo.
- Seguimiento: derivar a cirugía; peritonitis (Hinchey III-IV) requiere cirugía urgente (Hartmann o resección con anastomosis); colonoscopía diferida para descartar cáncer.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 33

Un paciente de 73 años presenta un cuadro de 2 días de dolor abdominal, mayor en la fosa ilíaca izquierda. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la fosa ilíaca izquierda, con signos de irritación peritoneal en la zona. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Apendicitis aguda
B) Cáncer de colon
C) Obstrucción intestinal
D) Diverticulitis aguda
E) Hernia inguinal complicada

Respuesta D. Dolor de 2 días en la fosa ilíaca izquierda con irritación peritoneal localizada en un adulto mayor es la presentación clásica de la diverticulitis aguda, la llamada apendicitis izquierda. Se confirma y se clasifica con TAC de abdomen y pelvis con contraste.

4.01.2.009 Prolapso rectal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

QUÉ HAY QUE SABER

- Prolapso rectal: protrusión de todas las capas del recto a través del ano con pliegues concéntricos (vs prolapso hemorroidal o mucoso: pliegues radiales).
- Factores: mujer adulta mayor, multiparidad, constipación crónica y pujo, debilidad del piso pélvico; en niños asociado a diarrea, desnutrición y fibrosis quística (descartar con test de sudor).
- Diagnóstico específico: examen en cuclillas con pujo; evaluar incontinencia fecal asociada. Colonoscopía en adultos para descartar lesión cabeza de prolapso.
- Urgencia: prolapso irreductible, encarcelado o estrangulado (mucosa violácea/necrótica). Reducción manual suave con analgesia; el azúcar granulada sobre la mucosa reduce el edema.
- Manejo inicial: fibra, evitar pujo, tratar constipación. Seguimiento: derivar a coloproctología para cirugía (rectopexia abdominal o perineal tipo Altemeier/Delorme).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 78 años, multípara, consulta por una masa que protruye por el ano al pujar, de varios meses de evolución, con secreción mucosa e incontinencia fecal leve. Al pedirle que puje, se observa una protrusión de 6 cm, de mucosa rojiza con pliegues circulares concéntricos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemorroides internas grado IV
B) Cáncer de recto
C) Pólipo rectal pediculado prolapsado
D) Prolapso mucoso parcial
E) Prolapso rectal completo

Respuesta E. Una protrusión de todo el espesor de la pared rectal muestra pliegues circulares concéntricos, mientras que el prolapso hemorroidal o mucoso presenta pliegues radiales. Es típico de mujeres mayores multíparas, con piso pélvico débil, y se asocia a incontinencia. El tratamiento es quirúrgico (rectopexia abdominal o técnicas perineales en pacientes de alto riesgo).

4.01.2.010 Trauma abdominal abierto y cerrado

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.11 Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia · Tema 6.4 Trauma Abdominal y Torácico

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma cerrado (accidentes de tránsito, caídas; bazo e hígado más afectados) vs penetrante (arma blanca o de fuego; hígado e intestino delgado). Manejo según ATLS: ABCDE.
- Sospecha: dolor, distensión, signo del cinturón de seguridad, equimosis en flancos (retroperitoneo), fracturas costales bajas, shock sin otra causa. Signo de Kehr (dolor hombro izquierdo): lesión esplénica.
- Paciente inestable: FAST (líquido libre en Morison, esplenorrenal, pelvis, pericardio) positivo → laparotomía. Estable: TAC de abdomen con contraste.
- Tratamiento inicial: 2 vías venosas gruesas, reanimación con cristaloides limitada (1 L) y transfusión precoz con relación 1:1:1 si hemorragia, ácido tranexámico 1 g IV en primeras 3 h, Foley y SNG (si no hay fractura de base de cráneo/uretra).
- Seguimiento: derivar a cirugía; indicaciones de laparotomía: inestabilidad con FAST+, peritonitis, evisceración, herida por arma de fuego. No retirar objetos empalados.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 31

Paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
B) Realizar ecografía FAST
C) Suturar la herida
D) Solicitar TAC abdominal
E) Realizar laparoscopía exploradora

Respuesta E. La exploración local confirma que la herida penetró el peritoneo. En un paciente estable, la conducta recomendada es la laparoscopía exploradora, que confirma o descarta lesión visceral con una agresión mínima; suturar la herida sin explorar la cavidad deja pasar lesiones internas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 31

Un paciente sufre una herida por arma blanca en el abdomen, hace 8 horas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y examen abdominal sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes. Se realiza exploración digital de la herida, con anestesia local, objetivándose laceración del peritoneo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar lavado peritoneal diagnóstico
B) Realizar ecografía FAST
C) Suturar la herida
D) Solicitar TAC abdominal
E) Realizar laparoscopía exploradora

Respuesta E. La herida por arma blanca laceró el peritoneo: penetró la cavidad. Aunque el paciente esté estable y sin signos peritoneales, eso es indicación de exploración quirúrgica, hoy preferentemente por laparoscopía. Suturar la piel sin explorar la cavidad deja pasar una eventual lesión de intestino o mesenterio.

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años sufre un vuelco en automóvil, con uso de cinturón de seguridad. Ingresa pálida, con presión arterial de 84/50 y frecuencia cardíaca de 124. Se le administra 1 litro de suero Ringer Lactato, y la presión sube apenas a 88/52. El Eco-FAST muestra líquido libre en el espacio de Morrison y en la pelvis. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste
B) Trasladar de inmediato a pabellón para laparotomía exploradora
C) Repetir el Eco-FAST en 30 minutos y reevaluar
D) Indicar 2 litros adicionales de suero fisiológico frío
E) Solicitar angiografía para embolización

Respuesta B. La paciente sigue inestable pese a la reanimación inicial, con Eco-FAST positivo para hemoperitoneo. La conducta obligatoria es la laparotomía exploradora de urgencia; enviarla al TAC en ese estado es la trampa clásica y de alto riesgo vital.

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años sufre un choque automovilístico de alta energía. Llega hemodinámicamente estable, con dolor leve en el hipocondrio izquierdo y sin signos peritoneales. La eco-FAST no muestra líquido libre. Las radiografías de tórax y pelvis son normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Laparotomía exploradora de urgencia
B) Lavado peritoneal diagnóstico
C) Observación con reevaluaciones seriadas y TAC de abdomen
D) Exploración digital de la pared abdominal
E) Alta con analgesia y control ambulatorio

Respuesta C. Trauma abdominal cerrado, estable, sin signos peritoneales y con eco-FAST negativa: observación con monitorización y reevaluaciones seriadas; por el mecanismo de alta energía se complementa con TAC. El lavado peritoneal está obsoleto y la exploración de la herida corresponde al arma blanca. Se operaría si apareciera inestabilidad, peritonismo o líquido libre.

4.01.2.011 Colecistitis aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.2 Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

QUÉ HAY QUE SABER

- Colecistitis aguda: inflamación de la vesícula por obstrucción del cístico (litiásica >90%); dolor en hipocondrio derecho >6 h, fiebre, náuseas/vómitos, signo de Murphy positivo.
- Criterios de Tokio: signos locales (Murphy, masa/dolor en HCD) + signos sistémicos (fiebre, leucocitosis, PCR) + imagen compatible = diagnóstico definitivo.
- Ecografía: cálculos, pared vesicular >4 mm con doble halo, líquido perivesicular, Murphy ecográfico, vesícula distendida. Si duda: cintigrafía HIDA.
- Tratamiento inicial: hospitalización, régimen cero, hidratación IV, analgesia (AINE/opioide), antibióticos (ceftriaxona ± metronidazol; cefazolina en leves).
- Seguimiento: derivar a cirugía para colecistectomía laparoscópica precoz (idealmente <72 h, hasta 7 días); colecistostomía percutánea en alto riesgo quirúrgico. Complicaciones: gangrena, perforación, enfisematosa (diabéticos).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 151

Mujer de 55 años con colecistitis aguda de 48 horas de evolución. Está estable hemodinámicamente, con fiebre de 38 grados y 14.000 leucocitos. **¿Cuál es el manejo quirúrgico más adecuado?**

A) Colecistectomía laparoscópica precoz, dentro de 72 horas
B) Cirugía electiva en 6 semanas
C) Drenaje percutáneo y cirugía diferida
D) Solo antibióticos endovenosos y observación
E) Colecistostomía abierta de urgencia

Respuesta A. Colecistitis aguda no complicada, paciente estable: la colecistectomía laparoscópica precoz, antes de 72 horas, es superior al manejo diferido, con menos complicaciones, menor estadía hospitalaria y menor conversión a cirugía abierta.

Pregunta de práctica

Mujer de 50 años con 18 horas de dolor continuo en el hipocondrio derecho, fiebre de 38,2 grados y Murphy positivo. Leucocitos 13.200. La ecografía muestra un cálculo enclavado en el bacinete, pared vesicular de 5 milímetros y líquido perivesicular. No tiene falla de ningún órgano. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar, iniciar antibióticos y colecistectomía laparoscópica antes de 72 horas
B) Indicar analgesia oral y programar cirugía electiva en 3 meses
C) Realizar colecistostomía percutánea de urgencia
D) Solicitar CPRE antes de cualquier cirugía
E) Indicar ácido ursodesoxicólico y dieta hipograsa

Respuesta A. Colecistitis aguda Grado I de Tokio, sin falla de órganos: el tratamiento de elección es hospitalizar, iniciar antibióticos endovenosos y realizar colecistectomía laparoscópica precoz, dentro de las primeras 72 horas. La colecistostomía se reserva para el Grado III o riesgo anestésico prohibitivo, y no hay ictericia que justifique una CPRE.

4.01.2.012 Colangitis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Colangitis aguda: infección de la vía biliar obstruida (coledocolitiasis la más frecuente; también estenosis, tumores, stent obstruido); E. coli, Klebsiella, Enterococcus, anaerobios.
- Tríada de Charcot: fiebre con calofríos, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Péntada de Reynolds (+ shock y compromiso de conciencia) indica colangitis grave.
- Diagnóstico específico (criterios de Tokio): inflamación sistémica + colestasia (bilirrubina, FA, GGT elevadas) + imagen con dilatación de vía biliar o causa (ecografía, colangio-RM). Hemocultivos.
- Tratamiento inicial: hidratación IV, antibióticos precoces (ceftriaxona + metronidazol; piperacilina-tazobactam si grave o nosocomial), corregir coagulación, manejo del shock.
- Seguimiento: derivar para drenaje biliar urgente (CPRE con papilotomía y extracción, <24 h en grave, 24-48 h en moderada); colecistectomía diferida si es litiásica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 70 años con colelitiasis conocida consulta por dolor en el hipocondrio derecho, fiebre de 39 °C con calofríos e ictericia. Se inician antibióticos endovenosos y fluidos. A las 6 horas está confusa, con PA 80/50 mmHg pese a la reposición de volumen. La ecografía muestra colédoco de 12 mm. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Drenaje urgente de la vía biliar, idealmente por CPRE
B) Colecistectomía laparoscópica de urgencia
C) Mantener antibióticos y observar 48 horas
D) Colangiorresonancia electiva
E) Cambiar el antibiótico y repetir la ecografía al día siguiente

Respuesta A. La pentada de Reynolds (tríada de Charcot más compromiso de conciencia e hipotensión) define una colangitis grave. Además del soporte y los antibióticos, requiere drenaje biliar urgente, de preferencia endoscópico por CPRE (o percutáneo si no está disponible). La colecistectomía no descomprime el colédoco y se difiere hasta resolver el cuadro.

4.01.2.013 Pancreatitis aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.2 Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: 2 de 3 criterios: dolor epigástrico típico irradiado en faja/al dorso, lipasa o amilasa ≥3 veces el límite superior, imagen compatible. Causas: biliar (la más frecuente en Chile) y alcohol; también hipertrigliceridemia (>1000 mg/dl), hipercalcemia, post CPRE, fármacos.
- Estudio etiológico: ecografía abdominal en todos (litiasis), pruebas hepáticas (ALT >150 sugiere biliar), triglicéridos y calcio. TAC con contraste no es necesario al ingreso; útil a las 72 h si mala evolución (necrosis).
- Gravedad: Atlanta revisada (leve, moderada con falla orgánica transitoria <48 h o complicaciones locales, grave con falla orgánica persistente); predictores: BUN elevado, hematocrito >44%, PCR >150 a las 48 h, SIRS

persistente, BISAP, Ranson, APACHE II.

- Tratamiento inicial: hidratación con Ringer lactato guiada por metas (evitar sobrecarga), analgesia (incluyendo opioides), nutrición enteral precoz cuando tolere; NO antibióticos profilácticos (solo si necrosis infectada).
- Seguimiento: derivar/hospitalizar; CPRE urgente si colangitis asociada; pancreatitis biliar leve requiere colecistectomía en la misma hospitalización. Complicaciones: colecciones, pseudoquiste, necrosis infectada.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años es hospitalizada por pancreatitis aguda leve de origen biliar. Evoluciona favorablemente: al tercer día no tiene dolor, tolera régimen oral y sus pruebas hepáticas se normalizan. La ecografía muestra colelitiasis múltiple sin dilatación de la vía biliar. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de la colelitiasis?**

A) Ácido ursodesoxicólico y control
B) Colecistectomía electiva en 6 meses
C) CPRE con papilotomía y alta
D) Colecistectomía laparoscópica durante la misma hospitalización
E) No operar, porque el cuadro ya se resolvió

Respuesta D. En la pancreatitis biliar leve, la colecistectomía debe realizarse durante la misma hospitalización, una vez resuelto el cuadro, porque diferirla aumenta significativamente el riesgo de recurrencia de pancreatitis y otras complicaciones biliares. En la pancreatitis grave con colecciones, en cambio, se difiere. La CPRE solo se indica ante colangitis o coledocolitiasis persistente.

4.01.2.014 Heridas de cara

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Heridas faciales: alta vascularización (sangran mucho pero cicatrizan bien y toleran cierre primario hasta 24 h o más). Clasificar en erosión, contusa, cortante, con pérdida de tejido o por mordedura.
- Evaluar lesiones asociadas: nervio facial (movilidad), conducto parotídeo (herida en mejilla con salida de saliva), vía lagrimal (canto interno), párpado con compromiso del borde libre, fracturas faciales, TEC.
- Manejo inicial: aseo prolijo con suero fisiológico, retirar cuerpos extraños (evitar tatuaje traumático), anestesia local (lidocaína con epinefrina segura en cara), desbridamiento económico.
- Sutura: monofilamento fino (nylon 5-0 o 6-0), afrontar primero bordes anatómicos (borde bermellón del labio, ceja: no rasurar); retirar puntos a los 5 días. Profilaxis antitetánica según esquema.
- Seguimiento: derivar a cirugía plástica/maxilofacial heridas complejas, con pérdida de tejido, compromiso de nervio facial, conducto de Stenon, vía lagrimal o borde palpebral; fotoprotección de la cicatriz.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años consulta 2 horas después de una caída en bicicleta con una herida cortante limpia de 2 cm en el labio superior, que cruza el borde bermellón. No hay compromiso dentario ni otras lesiones. **¿Cuál es el paso más importante en la reparación de esta herida?**

A) Dejar cicatrizar por segunda intención
B) Colocar el primer punto alineando exactamente el borde bermellón
C) Afrontar con cianoacrilato
D) Suturar solo la mucosa con material reabsorbible
E) Diferir la sutura 72 horas para disminuir el riesgo de infección

Respuesta B. En las heridas de cara que cruzan el borde bermellón, el primer punto debe alinear exactamente la unión cutáneo-mucosa, porque un desnivel de apenas 1 mm produce una deformidad visible. La cara tiene excelente irrigación, por lo que estas heridas pueden suturarse en forma primaria incluso hasta 24 horas o más.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 124 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 6 años sufre un accidente en el campo, golpeándose con un palo en la cabeza y resultando con una herida supraciliar derecha de 5 cm de longitud. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Afrontamiento con cianoacrilato
B) Afrontamiento con tela adhesiva
C) Sutura con punto separado
D) Sutura intradérmica
E) Dejar que cure por segunda intención

Respuesta D. Si bien también se puede afrontar con punto separado, en pediatría y también en adultos, se prefiere la sutura intradérmica para las heridas grandes de la cara, por su mejor resultado estético.

4.01.2.015 Trauma maxilofacial

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 15.15 Trauma Ocular: Sospecha de Globo Ocular Abierto, Hipema Traumático y Conducta

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma maxilofacial: frecuente en agresiones y accidentes de tránsito; siempre descartar primero vía aérea comprometida (sangrado, fracturas inestables, caída de la lengua en fractura mandibular bilateral) y lesión de columna cervical.
- Fracturas: nasales (las más frecuentes), mandibulares (maloclusión, dolor, trismus, anestesia del mentón), cigomático-malares (aplanamiento malar, hipoestesia infraorbitaria), Le Fort I-III (movilidad del maxilar).
- Fractura del piso orbitario (blow-out): diplopía en mirada vertical, enoftalmo, hipoestesia infraorbitaria y atrapamiento del recto inferior.
- Estudio: TAC de macizo facial (de elección). Hematoma septal nasal debe drenarse precozmente (riesgo de necrosis del cartílago y nariz en silla de montar). Rinorrea clara sugiere fístula de LCR.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea (cricotiroidotomía si no se puede intubar), control de hemorragia, analgesia, antibióticos en fracturas expuestas, profilaxis antitetánica. Seguimiento: derivar a cirugía maxilofacial/oftalmología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años recibe un puñetazo en el ojo izquierdo. Consulta por diplopía al mirar hacia arriba. Al examen presenta hematoma periorbitario, enoftalmos, limitación de la elevación del ojo izquierdo e hipoestesia de la mejilla y del labio superior ipsilaterales. Agudeza visual conservada. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Fractura del piso de la órbita (por estallido)
B) Fractura de huesos propios nasales
C) Fractura de mandíbula
D) Parálisis del VI par craneal
E) Desprendimiento de retina traumático

Respuesta A. Un golpe directo sobre el globo aumenta la presión intraorbitaria y fractura el piso orbitario (blow-out), con atrapamiento del recto inferior (diplopía en la mirada superior), enoftalmos e hipoestesia infraorbitaria por lesión del nervio infraorbitario. Se confirma con TAC de órbitas. La parálisis del VI par limita la abducción, no la elevación.

4.01.2.016 Traumatismo torácico grave

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante · Tema 6.4 Trauma Abdominal y Torácico

QUÉ HAY QUE SABER

- Lesiones que amenazan la vida en evaluación primaria: obstrucción de vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax volante y taponamiento cardíaco.
- Neumotórax a tensión: diagnóstico clínico (disnea, hipotensión, ingurgitación yugular, desviación traqueal, murmullo abolido, timpanismo): descompresión inmediata con aguja (4°-5° EIC línea axilar media en adultos o 2° EIC medioclavicular) y luego tubo pleural, sin esperar Rx.
- Hemotórax masivo: >1500 ml al instalar tubo o >200 ml/h por 2-4 h → toracotomía. Neumotórax abierto: apósito oclusivo fijado en 3 lados y tubo pleural.

- Taponamiento cardíaco: tríada de Beck (hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos apagados), FAST pericárdico; pericardiocentesis como puente y toracotomía/ventana pericárdica. Tórax volante: analgesia, oxígeno, ventilación si contusión pulmonar.
- Lesiones de evaluación secundaria: contusión pulmonar, rotura aórtica (mediastino ensanchado), lesión traqueobronquial, contusión miocárdica, rotura diafragmática y esofágica. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax/centro de trauma.

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 71

Paciente de 25 años, tras un accidente de tránsito, llega con timpanismo a la percusión del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular derecho, disnea severa y desviación traqueal hacia la izquierda. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata?**

A) Neumotórax a tensión: descompresión con aguja en el 2° espacio intercostal
B) Hemotórax masivo: drenaje pleural
C) Contusión pulmonar: oxígeno y observación
D) Fractura de costillas: analgesia
E) Taponamiento cardíaco: pericardiocentesis

Respuesta A. Timpanismo con ausencia del murmullo vesicular y desviación traqueal contralateral son el cuadro clínico del neumotórax a tensión. La emergencia se resuelve con descompresión inmediata con aguja, sin esperar radiografía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 32

Paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir radiografía de tórax
B) Pedir resonancia magnética de tórax
C) Instalar un tubo pleural de inmediato
D) Solicitar TAC de tórax
E) Realizar videotoracoscopía

Respuesta A. Hay un neumotórax traumático, pero sin los signos de tensión: el paciente está en buenas condiciones, sin hipotensión ni desviación traqueal. Sin esa urgencia, sí corresponde pedir primero la radiografía, para ver el grado del neumotórax y descartar un hemotórax asociado.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 102

Mujer de 56 años ingresa tras un accidente automovilístico de alta energía, con hemorragia masiva e inestabilidad hemodinámica. Las imágenes muestran un hematoma subdural con desplazamiento de 11 mm, múltiples fracturas costales con neumotórax izquierdo y desviación traqueal hacia la derecha, y una fractura de pelvis desplazada. **¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es la más urgente?**

A) Intubación orotraqueal
B) Laparotomía exploradora
C) Evacuación quirúrgica del hematoma subdural
D) Pleurostomía izquierda
E) Estabilización de la fractura de pelvis

Respuesta D. De todas las lesiones, la que mata primero es el neumotórax a tensión, evidenciado por la desviación traqueal. El hematoma subdural y la fractura de pelvis son graves, pero no matan en el mismo minuto: se tratan una vez resuelta la lesión torácica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 32

Un paciente de 28 años sufre una puñalada en el tórax, en el lado derecho. Al examen físico está en buenas condiciones, con dolor torácico, y presenta disminución del murmullo pulmonar, asociado a hipersonoridad a la percusión en el hemitórax derecho. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Pedir radiografía de tórax
B) Pedir resonancia magnética de tórax
C) Instalar un tubo pleural
D) Solicitar TAC de tórax
E) Realizar videotoracoscopía

Respuesta A. Trauma torácico penetrante con clínica de neumotórax (murmullo pulmonar disminuido e hipersonoridad), en un paciente estable, sin signos de neumotórax a tensión: el primer paso es la radiografía de tórax, para confirmar el diagnóstico y ver la magnitud antes de decidir el tubo pleural.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 123

Un paciente de 32 años sufre accidente de tránsito, golpeándose el pecho contra el piso. Algunos minutos después evoluciona con dificultad respiratoria, malestar general y compromiso del nivel de conciencia, siendo llevado al servicio de urgencias. Se constata frecuencia cardíaca: 140 por minuto, presión arterial: 86/50 mmHg, frecuencia respiratoria: 45 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno: 82% a aire ambiental. En el examen segmentario, se observa ingurgitación yugular con desviación de la tráquea y se ausculta disminución del murmullo pulmonar derecho y ruidos cardíacos apagados. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Contusión pulmonar
B) Taponamiento cardíaco
C) Disección aórtica
D) Neumotórax hipertensivo
E) Hemotórax masivo

Respuesta D. Shock + ingurgitación yugular + desviación traqueal + murmullo disminuido: neumotórax a tensión. El taponamiento también da taquicardia, hipotensión, yugulares ingurgitadas y ruidos apagados, pero no desvía la tráquea ni disminuye el murmullo. Se descomprime de inmediato.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 71

Paciente de 25 años tras accidente de tránsito llega con timpanismo a la percusión del hemitórax derecho, ausencia de murmullo vesicular derecho, disnea severa y desviación traqueal hacia la izquierda. **¿Cuál es el diagnóstico y conducta inmediata?**

A) Neumotórax a tensión: descompresión con aguja en 2° espacio intercostal
B) Hemotórax masivo: drenaje pleural
C) Contusión pulmonar: oxígeno y observación
D) Fractura de costillas: analgesia
E) Taponamiento cardíaco: pericardiocentesis

Respuesta A. Timpanismo + murmullo ausente + desviación traqueal contralateral = neumotórax a tensión. Emergencia: descompresión inmediata con aguja en el 2.º espacio intercostal, línea medioclavicular, sin esperar la radiografía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 102

Una paciente de 56 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir un accidente automovilístico de alta energía. Presenta múltiples lesiones, hemorragia masiva, taquicardia, hipotensión e inestabilidad hemodinámica. Se sospecha una fractura de pelvis en el examen físico. Se solicitan imágenes, entre las que se informan una TAC cerebral con un hematoma subdural izquierdo con desplazamiento de 11 mm desde la línea media de la masa encefálica; una TAC de tórax revela múltiples fracturas costales, neumotórax izquierdo con desplazamiento de la tráquea hacia la derecha; TAC de abdomen y pelvis con fractura de pelvis desplazada. **¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es la más urgente?**

A) Intubación orotraqueal
B) Laparotomía exploradora
C) Evacuación quirúrgica del hematoma subdural
D) Pleurostomía izquierda
E) Estabilización de la fractura de pelvis con un dispositivo de compresión neumática

Respuesta D. Entre múltiples lesiones graves, la más urgente es el neumotórax a tensión (desviación traqueal contralateral + hipotensión). Entre las alternativas, la pleurostomía izquierda es la medida prioritaria; si hubiera estado disponible, la descompresión con aguja iría primero.

Pregunta de práctica

Paciente de 40 años con trauma torácico cerrado. La radiografía muestra una opacidad de la base derecha con borramiento del ángulo costofrénico. Se instala un tubo pleural que drena 1.800 mL de sangre en la primera hora. **¿Cuál es la conducta?**

A) Mantener el tubo pleural y observar
B) Toracotomía (exploración quirúrgica)
C) Transfundir glóbulos rojos y reevaluar en 6 horas
D) Retirar el tubo e instalar uno de mayor calibre
E) TAC de tórax con contraste antes de decidir

Respuesta B. Hemotórax con salida inicial mayor de 1.500 mL por el tubo pleural (o débito sostenido de más de 200 mL/h por 2–4 horas): hemorragia activa importante, indicación de toracotomía. Mantener solo el drenaje o transfundir sin controlar la fuente lleva al shock; el TAC no debe retrasar la cirugía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 33 · texto original del banco, sin revisar

Hombre politrauma se hace TAC hematoma epidural + neumotórax con desviación de tráquea + derrame pericardico extenso, que vuelve del TAC con deterioro hemodinamico. Conducta inicial: a. Pleurostomía

B) Reanimación
C) Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía
C) Laparotomía exploratoria
D) Cirugía laparoscópica
E) Manejo conservador

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Pericardiocentesis yo puse pericardiocentesis, porque si es un NT a tensión necesita la punción con aguja antes q una pleurostomía (opción C). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

4.01.2.017 Supuración pulmonar

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa · Tema 2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

QUÉ HAY QUE SABER

- Absceso pulmonar: necrosis del parénquima con cavidad, generalmente por aspiración de flora oral anaerobia (alcohólicos, trastornos de conciencia, mala higiene dental, disfagia); segmentos posteriores de lóbulos superiores y apicales de inferiores.
- Clínica subaguda: fiebre, tos con expectoración purulenta y fétida (vómica), baja de peso; Rx: cavidad con nivel hidroaéreo de pared gruesa.
- Empiema: pus en espacio pleural, habitualmente complicación de neumonía; sospechar con fiebre persistente pese a antibióticos y derrame pleural. Diagnóstico con toracocentesis (pus, pH <7,2, glucosa <60).
- Tratamiento inicial: antibióticos prolongados (clindamicina 600 mg c/8 h IV o amoxicilina-ácido clavulánico; ampicilina-sulbactam IV) por 4-6 semanas en absceso; drenaje pleural con tubo en empiema.
- Seguimiento: derivar a broncopulmonar/cirugía de tórax; descartar cáncer (fibrobroncoscopía) y TBC si no responde o en fumador mayor. Bronquiectasias infectadas también son supuración pulmonar.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años con etilismo crónico severo, que sufrió una pérdida de conciencia tras una ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38,8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. Rx de tórax: condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. **¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?**

A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
D) Amikacina intramuscular diaria
E) Amoxicilina 1 g cada 8 horas oral

Respuesta B. Neumonía aspirativa: pérdida de conciencia por alcohol, esputo fétido (anaerobios) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (declive en decúbito supino). El esquema debe cubrir anaerobios y flora oral: ampicilina/sulbactam EV (o amoxicilina/clavulánico).

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años, alcohólico, en tratamiento por absceso pulmonar periférico del lóbulo inferior derecho. Al día 6 presenta bruscamente dolor torácico derecho intenso, disnea y fiebre de 39 °C. FR 30/min, SatO2 89 %. Radiografía: nivel hidroaéreo amplio en el espacio pleural derecho, con colapso pulmonar parcial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Mantener antibióticos y repetir radiografía en 48 horas
B) Punción con aguja en el 2.º espacio intercostal y alta
C) Fibrobroncoscopía para drenar el absceso
D) Instalar tubo de drenaje pleural de urgencia
E) Lobectomía inferior derecha de urgencia como primera medida

Respuesta D. La ruptura de un absceso periférico a la pleura produce un pioneumotórax: aire y pus en el espacio pleural, con nivel hidroaéreo pleural. Es una supuración pleuropulmonar que exige drenaje pleural con tubo grueso de inmediato, además de antibióticos. La cirugía queda para fracaso del drenaje.

4.01.2.018 Hemoptisis masiva

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemoptisis masiva: >200-600 ml en 24 h o cualquier volumen que compromete la vía aérea o la hemodinamia; la muerte es por asfixia, no por exanguinación. Origen habitual en arterias bronquiales.
- Causas: bronquiectasias, TBC (activa o secuelas, incluido aspergiloma), cáncer pulmonar, absceso, coagulopatía. Diferenciar de hematemesis y sangrado nasofaríngeo.
- Manejo inicial: asegurar vía aérea, oxígeno, decúbito lateral sobre el lado sangrante (pulmón sano arriba), 2 vías venosas, hemograma, coagulación, grupo y Rh; corregir coagulopatía; ácido tranexámico puede ayudar.
- Intubación con tubo grueso (permite fibrobroncoscopía) o selectiva del pulmón sano si sangrado incontrolable.
- Seguimiento: derivar a UCI/broncopulmonar: angioTAC, fibrobroncoscopía para localizar, embolización de arterias bronquiales (de elección) o cirugía de resección.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 50 años con bronquiectasias en el lóbulo inferior izquierdo presenta hemoptisis de aproximadamente 400 mL en 6 horas. Está consciente, con SatO2 de 91% y PA 120/75 mmHg. **¿Cuál es la medida inicial más adecuada mientras se gestiona el estudio y tratamiento definitivo?**

A) Posición de Trendelenburg
B) Posición en decúbito lateral derecho
C) Posición en decúbito lateral izquierdo, sobre el lado que sangra
D) Nebulización con broncodilatadores
E) Kinesioterapia respiratoria con percusión

Respuesta C. En la hemoptisis masiva lo prioritario es proteger la vía aérea del pulmón sano: se ubica al paciente en decúbito lateral sobre el lado que sangra para evitar la aspiración de sangre al pulmón contralateral, con oxígeno y eventual intubación. Luego, broncoscopía y angioTAC permiten localizar la lesión para embolización de arterias bronquiales o cirugía.

4.01.2.019 Perforación esofágica - Mediastinitis

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Perforación esofágica: causa más frecuente iatrogénica (endoscopía, dilatación); síndrome de Boerhaave por vómitos intensos (perforación distal izquierda, típico tras comida abundante y alcohol); también cuerpos extraños, trauma.
- Clínica: dolor torácico intenso retroesternal posterior a vómitos o procedimiento, disnea, fiebre, enfisema subcutáneo cervical (tríada de Mackler: vómitos, dolor torácico, enfisema subcutáneo).
- Rx de tórax: neumomediastino, derrame pleural izquierdo, hidroneumotórax; confirmar con esofagograma con contraste hidrosoluble o TAC con contraste oral.

- Mediastinitis: complicación grave (también por infecciones odontogénicas descendentes o post esternotomía), con sepsis y alta mortalidad.
- Tratamiento inicial: régimen cero, hidratación, antibióticos IV de amplio espectro (incluir anaerobios ± antifúngico), IBP, soporte. Seguimiento: derivar a cirugía de tórax urgente (reparación, drenaje, stent).

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 154

Paciente de 43 años, con epigastralgia desde hace 3 semanas, a quien se le realiza endoscopía digestiva alta por sospecha de úlcera, que muestra gastritis erosiva con test de ureasa positivo, por lo que se indica tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Tres horas después del procedimiento, evoluciona con dolor torácico irradiado a hombro derecho y sensación febril. **¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico en este caso?**

A) Radiografía de tórax
B) Repetir la endoscopía
C) Tomografía axial computada de tórax
D) Radiografía baritada de esófago-estómago-duodeno
E) Electrocardiograma

Respuesta C. Dolor torácico y fiebre pocas horas después de una endoscopía es una perforación esofágica iatrogénica, la causa más frecuente de este cuadro, con sospecha de mediastinitis secundaria. El TAC de tórax es el examen que mejor confirma el neumomediastino y la extensión del daño; la radiografía simple puede no mostrarlo si el cuadro es muy reciente.

4.01.2.020 Traumatismo raquimedular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lesión raquimedular en todo politraumatizado, trauma de alta energía, caída de altura, TEC, intoxicado o con dolor cervical/dorsal, déficit neurológico o priapismo. Inmovilizar hasta descartar.
- Shock neurogénico (lesión sobre T6): hipotensión con bradicardia y piel caliente por pérdida del tono simpático; diferenciar de shock hipovolémico (taquicardia, piel fría) que es más frecuente en trauma.
- Shock medular: pérdida transitoria de reflejos y flacidez bajo la lesión. Lesiones incompletas: centromedular (más en extremidades superiores), anterior, Brown-Séquard.
- Imagen: reglas NEXUS o canadiense para indicar estudio; TAC de columna es el examen de elección en trauma; RM para lesión medular o ligamentosa.
- Manejo inicial: inmovilización con collar y tabla, movilización en bloque, ABC con vía aérea con control cervical, evitar hipotensión (PAM >85 mmHg) e hipoxia, Foley; corticoides NO se recomiendan de rutina. Seguimiento: derivar a neurocirugía/traumatología. GES politraumatizado grave.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años sufre una caída de 5 metros. Ingresa con vía aérea permeable, sin lesiones torácicas ni abdominales evidentes y eco-FAST negativa. Presenta PA 80/45 mmHg, FC 52 lpm, piel tibia y seca, y paraplejia con arreflexia de las cuatro extremidades. **¿Cuál es el tipo de shock más probable?**

A) Shock hipovolémico hemorrágico
B) Shock séptico
C) Shock cardiogénico
D) Shock neurogénico
E) Shock obstructivo por neumotórax a tensión

Respuesta D. La lesión medular cervical o torácica alta interrumpe el tono simpático: hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca caracterizan al shock neurogénico, a diferencia del hemorrágico, que cursa con taquicardia y piel fría. Se maneja con volumen prudente y vasopresores, inmovilización espinal y búsqueda activa de hemorragia oculta antes de atribuir todo a la médula.

4.01.2.021 Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Isquemia arterial aguda: oclusión súbita por embolia (FA, IAM reciente; inicio brusco, sin historia de claudicación, pulsos contralaterales normales) o trombosis sobre placa (historia de claudicación, ausencia de pulsos contralaterales), o trauma.
- Las 6 P: dolor (pain), palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis y poiquilotermia (frialdad). Parestesias y parálisis indican amenaza de la viabilidad.
- Clasificación de Rutherford: I viable, IIa marginalmente amenazada, IIb amenaza inmediata (requiere revascularización urgente), III irreversible (amputación).
- Tratamiento inicial: heparina no fraccionada IV en bolo (5.000-10.000 UI o 80 UI/kg) y luego infusión, analgesia, extremidad en declive y protegida (no calor local, no elevar), hidratación.
- Seguimiento: derivar de inmediato a cirugía vascular (embolectomía con catéter de Fogarty, trombólisis o bypass); ventana de ~6 horas. Riesgo de síndrome de reperfusión (hiperkalemia, mioglobinuria) y compartimental.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 30 años sufre una fractura de antebrazo en un accidente. En el servicio de urgencia tiene una herida de la cual sale sangre en chorro, a ritmo del pulso. Está pálido y taquicárdico. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Ligadura inmediata de la arteria
B) Compresión directa de la herida
C) Instalar un torniquete de inmediato
D) Elevar el brazo y esperar
E) Solicitar una arteriografía antes de actuar

Respuesta B. La hemorragia pulsátil indica lesión arterial. La prioridad es la compresión directa, dentro del ABC del trauma. El torniquete se reserva para una hemorragia exanguinante que no cede, y la ligadura es un último recurso. La reparación definitiva es quirúrgica.

4.01.2.022 Aneurisma de aorta abdominal

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.4 Patología de la Aorta: Disección Aórtica Aguda & Aneurisma de Aorta Abdominal

QUÉ HAY QUE SABER

- Aneurisma de aorta abdominal (AAA): dilatación ≥3 cm, generalmente infrarrenal; factores: hombre >65 años, tabaco (principal), HTA, aterosclerosis, antecedente familiar.
- Mayoría asintomático: masa pulsátil expansiva periumbilical. Diagnóstico específico: ecografía abdominal (tamizaje y seguimiento); angioTAC para planificación.
- Rotura: tríada de dolor abdominal o lumbar súbito, hipotensión/shock y masa pulsátil; puede confundirse con cólico renal en adulto mayor. Emergencia: mortalidad >80%.
- Manejo inicial del AAA roto: hipotensión permisiva (PAS ~70-90 mmHg, evitar sobrehidratar), 2 vías venosas, transfusión, traslado inmediato a cirugía vascular. Si estable con dudas: angioTAC.
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular; reparación electiva (abierta o endovascular EVAR) si ≥5,5 cm en hombres (≥5 cm en mujeres), crecimiento >1 cm/año o sintomático; menores: control ecográfico, cese tabaco, estatina y control de PA.

PREGUNTAS (3)

Pregunta del libro · Tema 5.4

Hombre de 68 años fumador asintomático es derivado por hallazgo ecográfico de un Aneurisma de Aorta Abdominal infrarrenal de 5.8 cm de diámetro transversal máximo. ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Derivación a cirugía vascular para resolución quirúrgica o endovascular (EVAR)
B) Control ecográfico anual para vigilar crecimiento
C) Iniciar anticoagulación oral con Warfarina
D) Indicar reposo en cama permanente
E) Tratamiento con dosis altas de estatinas sin intervención

Respuesta A. El umbral de diámetro para indicar la reparación quirúrgica profiláctica o endovascular (EVAR) de un aneurisma de aorta abdominal en hombres es de ≥ 5.5 cm (o ≥ 5.0 cm en mujeres), dado que sobre este tamaño el riesgo anual de rotura fatal supera los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 65 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 77 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertesión ar- terial, consulta por dolor abdominal de tipo inespecífico, de 2 meses de evolución, sin otros síntomas. En su examen físico se palpa un tumor abdominal de 4 a 5 cm de diáme- tro, en la zona umbilical, pulsátil, sin signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trombosis mesentérica
B) Tumor de colon
C) Tumor de páncreas
D) Disección aórtica
E) Aneurisma aórtico abdominal

Respuesta E. Diagnóstico: Aneurisma aórtico abdominal (opción E). Un tumor pulsátil en esa zona, hace pensar en un AAA.. El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es una dilatación permanente de la aorta abdominal mayor a 3 cm o 1,5 veces el diámetro normal. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 86 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 41 años, con antecedente de riñón poliquís8co del adulto, acude al servicio de urgencia por dolor epigástrico intenso asociado a malestar general. Al examen Fsico presenta frecuencia cardíaca 105 por minuto, presión arterial 90/60 mmHg, temperatura 36,2 °C y examen abdominal con abdomen depresible, con presencia de signos peritoneales esbozados en abdomen superior. Se palpan masas en ambos flancos y en el epigastrio. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran amilasa 160 U/L (valor normal 60 - 140 U/L), glicemia 110 mg/dL, GOT 50 U/L, crea8nina: 2,5 mg/dL, BUN: 48 mg/dL y troponinas nega8vas. ¿Cuál es el examen imagenológico de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Ecogra:a abdominal
B) PieloTAC
C) UroTAC
D) Ecocardiogra:a transesofágica
E) Resonancia magné2ca nuclear de abdomen

Respuesta A. Es una pregunta difícil, pero el diagnóstico de sospecha es una aneurisma aórtico abdominal (AAA) roto. El examen inicial es la ecografía abdominal de urgencia. El AAA se asocia a RPQ. La masa epigástrica es el AAA y las masas en ambos flancos son los riñones aumentados de tamaño por la enfermedad poliquística. El RPQ también se asocia a disección aórtica (se estudiaría con ecocardiografía transeso

4.01.2.023 Traumatismos vasculares

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma vascular periférico por heridas penetrantes (arma blanca/fuego) o trauma cerrado (luxación de rodilla → arteria poplítea; fractura supracondílea de húmero → arteria braquial).
- Signos duros (cirugía inmediata): hemorragia pulsátil, hematoma expansivo, ausencia de pulsos distales, soplo o frémito, isquemia distal.
- Signos blandos (estudiar con índice de presión arterial <0,9, Doppler o angioTAC): hematoma estable, déficit neurológico adyacente, pulso disminuido, herida en trayecto vascular, hipotensión inexplicada.
- Manejo inicial: compresión directa de la hemorragia; torniquete si sangrado de extremidad no controlable (anotar hora de instalación); no pinzar a ciegas; reanimación y reducir/alinear fracturas y luxaciones.
- Seguimiento: derivar a cirugía vascular (reparación, injerto venoso, shunt temporal); fasciotomía si riesgo de síndrome compartimental tras reperfusión.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 22 años sufre una herida por arma blanca en la cara medial del muslo derecho. Ingresa con un hematoma pulsátil que aumenta de tamaño, frémito palpable y ausencia de pulsos poplíteo y pedio en esa extremidad. PA 110/70 mmHg tras la reanimación inicial. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Medir el índice tobillo-brazo y reevaluar en 6 horas
B) Exploración quirúrgica vascular inmediata
C) AngioTAC electiva al día siguiente
D) Vendaje compresivo y alta con control
E) Ecografía Doppler venosa

Respuesta B. Los signos duros de lesión vascular (hemorragia pulsátil, hematoma expansivo, frémito o soplo, ausencia de pulsos distales o isquemia) indican exploración quirúrgica inmediata, sin necesidad de imágenes previas. El índice tobillo-brazo o la angioTAC se usan ante signos blandos, como un hematoma estable o un déficit neurológico vecino.

4.01.2.024 Hemorragia aguda post operatoria.

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.16 Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemorragia postoperatoria precoz (primeras 24 h): generalmente falla técnica de hemostasia (ligadura deslizada); tardía: infección, coagulopatía o dehiscencia.
- Signos: taquicardia (signo precoz), hipotensión, oliguria, palidez, débito hemático abundante por drenajes, hematoma de herida o distensión abdominal; caída de hemoglobina (puede tardar en reflejarse).
- Diagnóstico específico: control de signos vitales, hemograma seriado, pruebas de coagulación (TP, TTPA, plaquetas), revisar uso de anticoagulantes/antiagregantes; ecografía/FAST o TAC si sangrado interno y estabilidad.
- Tratamiento inicial: 2 vías venosas, cristaloides y transfusión de glóbulos rojos, corregir coagulopatía (plasma, plaquetas, vitamina K, protamina si heparina), compresión local de hematoma superficial, ácido tranexámico.
- Seguimiento: avisar y derivar al cirujano tratante: reintervención si inestabilidad, sangrado persistente o hematoma que compromete (p. ej., cuello post tiroidectomía: abrir la herida de inmediato por compromiso de vía aérea).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 148

Paciente apendicectomizado hace 6 horas evoluciona con malestar general y dolor abdominal. Su pulso es regular, de 120 lpm, y su presión arterial es 90/50 mmHg. Al examen abdominal presenta dolor y signos peritoneales en el hemiabdomen inferior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemoperitoneo
B) Evisceración
C) Trombosis de la vena porta
D) Dehiscencia de la base apendicular
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta A. Taquicardia, hipotensión y signos peritoneales en las primeras horas tras una cirugía abdominal sugieren hemorragia postoperatoria (hemoperitoneo), habitualmente por falla en la ligadura del meso o la arteria apendicular, y requiere reoperación. La dehiscencia del muñón suele aparecer después de 3 a 5 días, con fiebre y peritonitis.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 87 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 42 años, con diagnós8co de hernia inguinal derecha, es some8do a hernioplas`a a las 8:00 horas del día de hoy. Evoluciona favorablemente en el postoperatorio inmediato y es dado de alta a las 15:00 horas. Reingresa a las 21:00 horas al servicio de urgencia por dolor intenso en la zona, EVA 7/10. Al examen Fsico, sus signos vitales muestran temperatura 37,1 °C, frecuencia cardíaca 100 por minuto y presión arterial 120/78 mmHg; se aprecia aumento de volumen inguinal doloroso a la palpación, con eritema de la piel. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?

A) Absceso inguinal
B) Hematoma inguinal
C) Hernia crural atascada
D) Cuerpo extraño
E) Recurrencia de la hernia inguinal

Respuesta D. El diagnóstico más probable es un hematoma inguinal postoperatorio, dado el inicio precoz del dolor y aumento de volumen pocas horas después de la hernioplasVa. La presencia de eritema local puede explicarse por inflamación secundaria a la colección hemática. Los abscesos y la reacción inflamatoria al cuerpo extraño suelen presentarse de forma más tardía.

4.01.2.025 Heridas y contusiones menores

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Clasificar: erosión/abrasión, herida cortante, contusa, punzante, con pérdida de sustancia, por mordedura; limpia (<6 h, sin contaminación) vs contaminada. Contusiones: equimosis y hematoma sin solución de continuidad.
- Evaluar compromiso de tendones, nervios (sensibilidad distal antes de anestesiar), vasos y articulaciones; Rx si sospecha de cuerpo extraño o fractura.
- Tratamiento completo: anestesia local (lidocaína 1-2%, máx 4,5 mg/kg; 7 mg/kg con epinefrina), aseo abundante con suero fisiológico, desbridamiento, cierre primario si <6-8 h (hasta 24 h en cara); mordeduras y heridas muy contaminadas: cierre diferido o por segunda intención (salvo cara).
- Retiro de puntos: cara 5 días, cuero cabelludo y tronco 7-10, extremidades 10-14, articulaciones 14. Antibiótico profiláctico en mordeduras (amoxicilina-ácido clavulánico 3-5 días) y heridas muy contaminadas.
- Prevención: profilaxis antitetánica según esquema y tipo de herida; evaluar antirrábica en mordeduras. Contusiones: frío local, reposo, AINE. Seguimiento: control de herida a las 48 h en APS.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años consulta por una herida cortante de 5 cm en la pierna, producida con un vidrio sucio hace 20 horas. Los bordes están levemente eritematosos, con restos de tierra, sin compromiso de estructuras profundas. Tiene esquema antitetánico completo con refuerzo hace 2 años. **¿Cuál es el manejo más adecuado de la herida?**

A) Sutura primaria inmediata tras un aseo breve
B) Antibiótico oral y sutura primaria
C) Cierre con adhesivo tisular
D) Aseo quirúrgico con debridamiento, no cerrar en forma primaria, curaciones y cierre diferido o por segunda intención
E) Vendaje compresivo sin aseo

Respuesta D. Una herida contaminada y de más de 12 a 24 horas de evolución, en zona no facial, tiene alto riesgo de infección si se cierra primariamente. Se realiza aseo profuso y debridamiento, se deja abierta con curaciones y se cierra en forma diferida o por segunda intención.

4.01.2.026 Quemaduras

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Profundidad (clasificación de Benaim/Converse): A o 1° (eritema, dolor), AB superficial o 2° superficial (flictenas, rosado, muy doloroso), AB profunda (blanco-rosado, menos doloroso), B o 3° (blanco nacarado o carbonizado, indoloro, acartonado).

- Extensión: regla de los 9 de Wallace en adultos (cabeza 9%, cada brazo 9%, tronco anterior 18%, posterior 18%, cada pierna 18%, periné 1%); palma del paciente ≈1% para quemaduras parcheadas; Lund-Browder en niños.
- Gran quemado (GES): índice de gravedad de Garcés >70 (mayor de 20 años), quemadura AB/B >20% SCQ, o de vía aérea, eléctrica de alta tensión o en zonas especiales (cara, manos, pies, genitales, pliegues).
- Manejo inicial: ABCDE; sospecha de quemadura de vía aérea (incendio en espacio cerrado, hollín, vibrisas quemadas, disfonía) → intubación precoz; oxígeno al 100% por CO; detener el proceso (retirar ropa, irrigar con agua tibia).
- Reposición: Parkland 4 ml × kg × %SCQ de Ringer lactato en 24 h (mitad en primeras 8 h), ajustado a diuresis 0,5 ml/kg/h (1 ml/kg/h en niños y eléctricas); analgesia con opioides, profilaxis antitetánica, cubrir con apósitos limpios. Seguimiento: derivar a unidad de quemados.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 77

Niño con quemadura en palmas y dedos, con eritema importante y ampollas, que llega a urgencias inquieto e irritable. **¿Cuál es la conducta inicial?**

A) Aplicar apósitos de plata y hospitalizar
B) Enfriar con agua fría y cubrir con gasa estéril
C) Indicar analgesia endovenosa
D) Hospitalizar para manejo de quemaduras
E) Debridación bajo anestesia general inmediata

Respuesta C. Antes de cualquier cálculo, examen o curación, el paciente quemado necesita analgesia endovenosa: el dolor de las quemaduras es intenso y tratarlo primero facilita todo lo que viene después, incluyendo la evaluación de la extensión y la profundidad.

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años sufre quemaduras por líquido caliente hace 3 horas. Presenta flictenas húmedas y rosadas, muy dolorosas, en todo el tronco anterior y en toda una extremidad inferior. No tiene compromiso facial ni de la vía aérea. Pesa 60 kg. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manejo ambulatorio con analgesia oral y curaciones
B) Calcular Parkland con 36 % de superficie quemada y derivar como gran quemada
C) Calcular Parkland con 18 % de superficie quemada y derivar como gran quemada
D) Indicar antibióticos profilácticos y control ambulatorio en 48 horas
E) Realizar escarotomía profiláctica antes de cualquier examen

Respuesta B. Tronco anterior (18 %) más una extremidad inferior completa (18 %) suman 36 % de superficie quemada de segundo grado, que supera el 20 % que define gran quemado en adultos. Se calcula Parkland con ese 36 % y se activa el traslado GES. La escarotomía no aplica: no hay escara circular de tercer grado.

4.01.2.027 Trauma

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Trauma es principal causa de muerte en <40 años; distribución trimodal (inmediata, primeras horas = «hora de oro», tardía por sepsis/falla multiorgánica). Manejo con protocolo ATLS.
- Evaluación primaria ABCDE: vía aérea con control de columna cervical, ventilación, circulación con control de hemorragia, déficit neurológico (Glasgow, pupilas), exposición con control de hipotermia.
- Shock en trauma es hemorrágico hasta demostrar lo contrario; buscar sangrado en tórax, abdomen, pelvis, huesos largos y externo. Clasificación de hemorragia ATLS I-IV.
- Adjuntos: monitoreo, Foley y SNG (si no hay contraindicación), Rx de tórax y pelvis, FAST. Luego evaluación secundaria (cabeza a pies, AMPLE).
- Manejo inicial: oxígeno, 2 vías venosas gruesas, cristaloides tibios limitados, transfusión precoz, ácido tranexámico, inmovilización. Seguimiento: derivar a centro de trauma; politraumatizado grave es GES.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 34 años, motociclista, sufre una colisión de alta energía. Tras una hora de cirugía por una laceración hepática, el anestesista informa temperatura de 34,2 grados, pH arterial de 7,15 y sangrado difuso en napa desde toda la herida operatoria, sin que ningún vaso puntual esté sangrando. **¿Cuál es la conducta quirúrgica más adecuada en este momento?**

A) Continuar la reconstrucción hepática definitiva hasta terminarla
B) Empaquetar la cavidad con compresas, cerrar en forma temporal y trasladar a la unidad de paciente crítico
C) Administrar bicarbonato de sodio y seguir operando sin cambios
D) Realizar un bypass vascular y cerrar la pared por planos
E) Esperar en pabellón a que la temperatura se normalice sola

Respuesta B. Hipotermia, acidosis y sangrado difuso en napa son la tríada letal instalada. Continuar la cirugía definitiva es lo que más se pregunta como error: la conducta correcta es la cirugía de control de daños, con packing, cierre temporal y traslado a la unidad de paciente crítico.

4.01.2.028 Intoxicación por anestésicos locales

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Toxicidad sistémica por anestésicos locales: por inyección intravascular inadvertida o sobredosis; dosis máximas: lidocaína 4,5 mg/kg (máx 300 mg) sin epinefrina y 7 mg/kg (máx 500 mg) con epinefrina; bupivacaína 2-2,5 mg/kg (más cardiotóxica).
- Síntomas neurológicos precoces: parestesias peribucales, sabor metálico, tinnitus, mareo, agitación, disartria, temblor, luego convulsiones y coma.
- Toxicidad cardiovascular: hipertensión y taquicardia iniciales, luego bradicardia, hipotensión, arritmias ventriculares y paro (especialmente con bupivacaína).
- Tratamiento inicial: detener la inyección, pedir ayuda, oxígeno y vía aérea, benzodiazepinas para convulsiones (midazolam), emulsión lipídica al 20% (bolo 1,5 ml/kg y luego infusión 0,25 ml/kg/min); RCP prolongada si paro (dosis menores de epinefrina, evitar lidocaína como antiarrítmico).
- Prevención: calcular dosis máxima por peso, aspirar antes de inyectar, inyectar lento y fraccionado, monitorizar. Seguimiento: derivar/trasladar a unidad con monitorización (UCI) tras estabilización.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Durante un bloqueo de nervio periférico con lidocaína para una cirugía de mano, el paciente refiere de pronto adormecimiento alrededor de los labios y un sabor metálico intenso en la boca. Segundos después presenta fasciculaciones faciales. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Continuar el bloqueo, ya que la dosis calculada era segura
B) Suspender la inyección de inmediato y prepararse para tratar la toxicidad sistémica
C) Administrar un antihistamínico, pensando en una reacción alérgica
D) Completar la dosis y observar en las próximas 2 horas
E) Solicitar una tomografía computarizada de cerebro de urgencia

Respuesta B. Sabor metálico, parestesias periorales y fasciculaciones son los pródromos clásicos de la toxicidad sistémica por anestésicos locales. Suspender la inyección de inmediato evita que progrese a convulsiones y colapso cardiovascular; esperar a completar la dosis es la conducta que más la agrava.

Pregunta de práctica

Durante un bloqueo peridural con bupivacaína para una cirugía ginecológica, la paciente refiere sabor metálico, mareos y tinnitus, y de inmediato presenta una convulsión tónico clónica generalizada, con colapso hemodinámico, bradicardia extrema y ensanchamiento del QRS. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico específico que debe iniciarse de urgencia?**

A) Infusión inmediata de emulsión lipídica al 20 %
B) Bolo de 1 mg de adrenalina endovenosa directa
C) Sulfato de magnesio en infusión rápida
D) Flumazenil endovenoso en bolos seriados
E) Amiodarona en bolo endovenoso

Respuesta A. El cuadro es una toxicidad sistémica grave por bupivacaína, probablemente por inyección intravascular inadvertida. El tratamiento específico es la emulsión lipídica al 20 %, en bolo de 1,5 mL por kilo en un minuto, seguida de infusión continua, que secuestra el anestésico libre en el plasma.

4.01.2.029 Septicemia

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sepsis: disfunción orgánica potencialmente mortal por respuesta desregulada a infección (aumento de SOFA ≥2). qSOFA (≥2: FR ≥22, PAS ≤100, alteración de conciencia) identifica riesgo fuera de UCI.
- Shock séptico: necesidad de vasopresores para PAM ≥65 mmHg y lactato >2 mmol/l pese a reposición adecuada de volumen.
- Buscar foco: neumonía, urinario, abdominal, piel y partes blandas, catéteres; hemocultivos (2 sets) y cultivos del foco antes de antibióticos, sin retrasarlos.
- Tratamiento inicial (primera hora): antibiótico de amplio espectro IV, cristaloides 30 ml/kg en hipotensión o lactato ≥4, medir lactato, vasopresor noradrenalina si PAM <65 pese a volumen; oxígeno, control del foco (drenaje).
- Seguimiento: derivar a UCI; reevaluar perfusión (llene capilar, diuresis, lactato) y ajustar antibióticos según cultivos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 72 años con pielonefritis aguda ingresa con T° 39 °C, FC 118 lpm, PA 78/40 mmHg y lactato de 4,5 mmol/L. Se toman hemocultivos, se inicia ceftriaxona y se administran 30 mL/kg de cristaloides en la primera hora. Persiste con presión arterial media de 55 mmHg. **¿Cuál es la siguiente medida más adecuada?**

A) Nuevo bolo de 30 mL/kg de cristaloides
B) Transfundir glóbulos rojos
C) Iniciar dobutamina
D) Administrar bicarbonato de sodio
E) Iniciar noradrenalina para lograr presión arterial media de al menos 65 mmHg

Respuesta E. Hipotensión que persiste tras la reanimación con volumen y lactato elevado definen un shock séptico. El vasopresor de elección es la noradrenalina, titulada para mantener una presión arterial media de al menos 65 mmHg, idealmente por vía central (puede iniciarse por vía periférica). Insistir con grandes volúmenes aumenta el riesgo de sobrecarga.

4.01.2.030 Paro cardiorespiratorio

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: paciente que no responde, sin respiración normal (o solo jadeo/gasping) y sin pulso palpable en 10 segundos. Activar sistema de emergencia y pedir DEA.
- RCP de alta calidad: compresiones 100-120/min, profundidad 5-6 cm, permitir reexpansión, minimizar interrupciones; relación 30:2 sin vía aérea avanzada; con vía aérea avanzada, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s.

- Ritmos desfibrilables (FV/TV sin pulso): descarga precoz (bifásico 120-200 J), RCP 2 min; adrenalina 1 mg IV/IO tras la 3ª descarga y luego cada 3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3ª descarga y 150 mg tras la 5ª (o lidocaína).
- Ritmos no desfibrilables (asistolia, AESP): RCP + adrenalina 1 mg lo antes posible y cada 3-5 min; buscar causas reversibles 5H y 5T (hipovolemia, hipoxia, H+, hipo/hiperkalemia, hipotermia; neumotórax a tensión, taponamiento, tóxicos, trombosis pulmonar y coronaria).
- Post paro (retorno a circulación espontánea): ABC, SatO2 92-98%, PAM ≥65, ECG de 12 derivaciones (coronariografía si SDST), control de temperatura, glicemia. Seguimiento: derivar a UCI.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 65 años presenta un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Se inicia reanimación con compresiones de alta calidad y ventilación. Al conectar el monitor desfibrilador, el ritmo es una asistolia, confirmada en más de una derivación. **Además de mantener las compresiones, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Desfibrilar con 200 J bifásicos
> **B)** Administrar adrenalina 1 mg endovenosa lo antes posible y repetir cada 3 a 5 minutos
> **C)** Administrar amiodarona 300 mg endovenosa
> **D)** Cardioversión sincronizada
> **E)** Administrar atropina 1 mg endovenosa
> Respuesta B. La asistolia es un ritmo no desfibrilable: el manejo es RCP de alta calidad, adrenalina 1 mg endovenosa o intraósea lo antes posible y cada 3 a 5 minutos, y búsqueda de causas reversibles (las 5H y 5T). La desfibrilación y la amiodarona son para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso; la atropina ya no se recomienda.

4.01.2.031 Shock

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Shock: hipoperfusión tisular con disfunción celular; signos: hipotensión (PAS <90 o PAM <65), taquicardia, oliguria (<0,5 ml/kg/h), compromiso de conciencia, piel fría y llene capilar >2 s, lactato >2 mmol/l.
- Tipos: hipovolémico/hemorrágico (el más frecuente en trauma), distributivo (séptico, anafiláctico, neurogénico: piel caliente), cardiogénico (congestión, crepitaciones, ingurgitación yugular) y obstructivo (neumotórax a tensión, taponamiento, TEP).
- Diagnóstico específico: clínica + lactato, gases arteriales, hemograma, ECG, ecografía a pie de cama (RUSH/FAST) para diferenciar tipos.
- Tratamiento inicial: oxígeno, 2 vías venosas gruesas, cristaloides (1-2 L o 20-30 ml/kg) excepto en cardiogénico; hemorragia: control del sangrado y transfusión 1:1:1; séptico: antibióticos precoces + noradrenalina; anafiláctico: adrenalina 0,5 mg IM; obstructivo: descompresión/pericardiocentesis.
- Monitorizar con Foley (diuresis), PA y lactato seriado. Seguimiento: derivar a UCI o cirugía según la causa.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 35 años, de 70 kg, ingresa tras un accidente de tránsito con fractura expuesta de fémur. Presenta FC 135 lpm, PA 80/50 mmHg, FR 32 por minuto, llene capilar enlentecido y está ansioso y confuso. Diuresis escasa por sonda. **Según la clasificación ATLS del shock hemorrágico, ¿qué clase presenta y cuál es su manejo?**
> **A)** Clase I; solo observación
> **B)** Clase II; cristaloides exclusivamente
> **C)** Clase III; reposición de volumen y transfusión de hemoderivados
> **D)** Clase I; vasopresores
> **E)** Clase II; noradrenalina
> Respuesta C. Taquicardia sobre 120, hipotensión, taquipnea, confusión y oliguria corresponden a un shock hemorrágico clase III (pérdida de 30 a 40% de la volemia, aproximadamente 1.500 a 2.000 mL). Requiere control de la hemorragia, cristaloides tibios limitados y transfusión precoz de glóbulos rojos y hemoderivados. Los vasopresores no tienen rol en el shock hemorrágico inicial.

Conocimientos generales 18 códigos

4.01.3.001 Alimentación en enfermedades digestivas

Dónde se enseña: Tema 4.2 Pancreatitis Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Preferir siempre la vía enteral (oral o por sonda) sobre la parenteral: mantiene el trofismo intestinal, reduce infecciones y es más barata. Parenteral solo si el intestino no es funcional o no cubre requerimientos >7 días.
- Pancreatitis aguda: realimentación oral precoz cuando tolere (leve) y nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoyeyunal en grave; evitar ayuno prolongado.
- Pancreatitis crónica: dieta fraccionada, normograsa con enzimas pancreáticas en cada comida, suspender alcohol, suplementar vitaminas A, D, E, K.
- Cirrosis: no restringir proteínas (1,2-1,5 g/kg/día) incluso en encefalopatía; colación nocturna; restringir sodio (<2 g/día) si ascitis.
- Otras: enfermedad celíaca (dieta sin gluten de por vida: trigo, avena, cebada, centeno), diverticulosis y constipación (fibra 25-35 g/día), postoperatorio digestivo con realimentación precoz (protocolos ERAS).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 50 años cursa con una pancreatitis aguda grave de origen alcohólico. Al tercer día persiste con dolor, íleo leve e intolerancia a la vía oral; está hemodinámicamente estable. **¿Cuál es la forma de soporte nutricional más adecuada?**
>
> **A)** Nutrición enteral por sonda nasogástrica o nasoyeyunal
> **B)** Nutrición parenteral total como primera opción
> **C)** Ayuno prolongado hasta que normalice la amilasa
> **D)** Régimen oral completo hipergrasos
> **E)** Solo suero glucosado por 2 semanas
>
> Respuesta A. En la pancreatitis aguda grave, la nutrición enteral precoz (por sonda nasogástrica o nasoyeyunal) es preferible a la parenteral: mantiene la barrera intestinal, reduce la translocación bacteriana, las infecciones y la mortalidad. La nutrición parenteral se reserva para cuando la vía enteral no es posible o es insuficiente; el ayuno prolongado no está indicado.

4.01.3.002 Antimicrobianos. Conceptos profilaxis y esquemas terapéuticos

Dónde se enseña: Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Profilaxis antibiótica quirúrgica: indicada en cirugía limpia-contaminada, contaminada y limpia con prótesis o alto riesgo; en sucia/infectada el antibiótico es tratamiento, no profilaxis.
- Fármaco habitual: cefazolina 2 g IV (3 g si >120 kg) dentro de los 60 minutos previos a la incisión; agregar metronidazol 500 mg en cirugía colorrectal/apendicular; clindamicina o vancomicina si alergia a betalactámicos.
- Redosificar si la cirugía dura más de 2 vidas medias (cefazolina cada 4 h) o sangrado >1.500 ml; no prolongar la profilaxis más de 24 h.
- Esquemas terapéuticos: infección intraabdominal comunitaria → ceftriaxona + metronidazol; grave o nosocomial → piperacilina-tazobactam o carbapenémico; piel y partes blandas → cefazolina/cloxacilina; pie diabético → amoxicilina-ácido clavulánico.
- Principios: tomar cultivos antes de iniciar, ajustar según resultado (desescalar), duración acotada (infección intraabdominal con foco controlado: ~4 días) y uso racional para evitar resistencia y C. difficile.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 11

Mujer de 35 años con dolor epigástrico recurrente. La ecografía muestra múltiples cálculos en la vesícula biliar. Se decide colecistectomía laparoscópica electiva. **¿Cuál esquema antibiótico es de elección como profilaxis de la herida operatoria?**

A) Amoxicilina más ácido clavulánico
B) Ceftriaxona
C) Clindamicina
D) Cloxacilina
E) Cefazolina

Respuesta E. La cefazolina es el fármaco de elección para profilaxis quirúrgica en la colecistectomía electiva: cubre bien cocáceas grampositivas de piel y las enterobacterias que puede haber en la bilis, con un espectro más acotado y menor costo que otras opciones.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 11

Mujer de 35 años consulta por dolor abdominal epigástrico recurrente. La ecografía abdominal muestra múltiples cálculos en la vesícula biliar, y se decide realizar una colecistectomía laparoscópica electiva. **¿Cuál esquema antibiótico es de elección como profilaxis de infección de la herida operatoria?**

A) Amoxicilina con ácido clavulánico
B) Ceftriaxona
C) Clindamicina
D) Cloxacilina
E) Cefazolina

Respuesta E. Toda cirugía limpia contaminada, como la colecistectomía electiva, requiere profilaxis antibiótica dirigida a cubrir cocáceas grampositivas y flora entérica. La cefazolina es el fármaco de elección en la mayoría de las cirugías abdominales, incluida esta.

4.01.3.003 Asepsia y antisepsia

Dónde se enseña: Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Asepsia: conjunto de medidas que impiden la llegada de microorganismos a un área (material estéril, técnica estéril, campo quirúrgico). Antisepsia: eliminación de microorganismos de piel y mucosas con antisépticos.
- Esterilización (elimina todas las formas incluidas esporas: autoclave a vapor, óxido de etileno, plasma de peróxido) vs desinfección de alto nivel (glutaraldehído, para endoscopios) vs limpieza.
- Antisépticos: clorhexidina alcohólica 2% (de elección para piel, efecto residual), povidona yodada, alcohol 70%. Clorhexidina acuosa en mucosas.
- Lavado quirúrgico de manos 3-5 minutos o fricción con solución alcohólica; higiene de manos en los 5 momentos de la OMS es la medida más eficaz contra IAAS.
- Preparación del paciente: ducha previa, no rasurar (si es necesario, cortar vello con máquina justo antes de la cirugía), pintar desde la incisión hacia la periferia; vestimenta estéril y circulación restringida en pabellón.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años será sometido a una hernioplastía inguinal electiva. Presenta abundante vello en la zona operatoria. **¿Cuál es la medida de preparación de la piel más adecuada para prevenir la infección de sitio quirúrgico?**

A) Rasurado con navaja la noche anterior
B) Rasurado con navaja en el pabellón
C) No retirar el vello y pintar con povidona acuosa
D) Si es necesario, cortar el vello con máquina eléctrica (clipper) inmediatamente antes de la cirugía y aplicar clorhexidina alcohólica
E) Aplicar alcohol al 70% como único antiséptico, 24 horas antes

Respuesta D. El vello solo se retira si interfiere con la cirugía, y con máquina cortadora inmediatamente antes, porque el rasurado con navaja produce microlesiones que se colonizan y aumentan la infección de sitio quirúrgico, más aún si se hace la noche anterior. La antisepsia de elección es la clorhexidina en solución alcohólica.

4.01.3.004 Colostomías

Dónde se enseña: Tema 11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

QUÉ HAY QUE SABER

- Colostomía: abocamiento del colon a la piel; puede ser terminal (Hartmann: tras resección con cierre del muñón rectal; o definitiva en amputación abdominoperineal) o en asa (derivación temporal).
- Indicaciones: perforación/peritonitis de colon (diverticulitis Hinchey III-IV), obstrucción por cáncer, trauma colónico, protección de anastomosis baja, cáncer de recto bajo.
- Características: deposiciones formadas en colostomía descendente/sigmoidea (menor riesgo de dermatitis); estoma normal rosado, húmedo y levemente protruido.
- Complicaciones: necrosis (estoma oscuro/negro), retracción, estenosis, prolapso, hernia paraestomal, dermatitis periestomal y obstrucción.
- Cuidados: bolsa de ostomía de tamaño adecuado, protección de la piel, educación al paciente y apoyo de enfermería especializada; reconstitución del tránsito (cierre) habitualmente a los 3-6 meses si fue temporal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con diverticulitis aguda Hinchey IV (peritonitis fecaloídea) es sometido a una cirugía de urgencia. Se realiza una sigmoidectomía, cierre del muñón rectal y abocamiento del colon descendente a la piel. **¿Cómo se denomina esta cirugía y qué tipo de ostomía se dejó?**

A) Operación de Miles con colostomía definitiva
B) Colostomía en asa sin resección
C) Hemicolectomía derecha con ileostomía en asa
D) Resección anterior baja con anastomosis primaria
E) Operación de Hartmann con colostomía terminal

Respuesta E. La operación de Hartmann consiste en resecar el segmento enfermo, cerrar el muñón rectal y abocar el cabo proximal como colostomía terminal; es la técnica clásica en la peritonitis diverticular fecaloídea o en pacientes inestables. Se puede reconstruir el tránsito en un segundo tiempo. La operación de Miles reseca el recto y el ano, con colostomía definitiva.

4.01.3.005 Complicaciones postoperatorias frecuentes

Dónde se enseña: Tema 11.16 Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) · Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Fiebre postoperatoria por tiempos («5W»): 24-48 h atelectasia/respuesta inflamatoria; día 3-5 infección urinaria o neumonía, flebitis; día 5-7 infección de herida, filtración anastomótica o absceso; >7 días TVP/TEP, absceso, reacción a fármacos.
- Infección de herida operatoria: eritema, dolor, secreción purulenta (habitualmente día 5-7); tratamiento: abrir la herida, drenar y curar; antibióticos si celulitis o compromiso sistémico.
- Dehiscencia/evisceración: salida de líquido serohemático por la herida precede a la evisceración (día 5-8); cubrir con compresas húmedas estériles y pabellón.
- Íleo postoperatorio (habitual hasta 3-5 días): prolongado si alteraciones electrolíticas (hipokalemia), opioides, sepsis intraabdominal. Retención urinaria: Foley/cateterismo. Delirio en adulto mayor.
- Prevención: deambulación precoz, kinesioterapia respiratoria, tromboprofilaxis (HBPM o métodos mecánicos), profilaxis antibiótica adecuada, control glicémico, retiro precoz de sondas y catéteres.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 123

Paciente de 17 años, apendicectomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Pulso regular de 120 por minuto, presión arterial de 90/50 mmHg y temperatura de 37,7 °C. Al examen abdominal hay dolor a la palpación profunda y superficial, con signos peritoneales difusos, mayores en el hemiabdomen inferior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemoperitoneo
B) Evisceración
C) Trombosis de la vena porta
D) Dehiscencia de la base apendicular
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta D. La dehiscencia de la base apendicular produce una peritonitis franca: dolor y signos peritoneales que empiezan localizados y se vuelven difusos, con fiebre y progresión a shock hipovolémico y séptico. Es mucho más frecuente que el hemoperitoneo, que se presenta primero con compromiso hemodinámico y palidez, y el dolor abdominal aparece después.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 173

Paciente de 46 años sometido a colecistectomía abierta. A las 48 horas presenta fiebre de 37,8 °C, eupneico, con frecuencia respiratoria de 14 por minuto y saturación de 98 por ciento. La herida está sin eritema ni secreción, y las vías venosas están permeables y sin signos inflamatorios. El examen pulmonar muestra crepitaciones localizadas en la base derecha. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neumonía
B) Dehiscencia de la anastomosis
C) Atelectasia
D) Infección de la herida operatoria
E) Tromboembolismo pulmonar

Respuesta C. La atelectasia es la causa más frecuente de fiebre en las primeras 48 horas, y las crepitaciones localizadas la confirman. La neumonía necesitaría tos y expectoración mucopurulenta; el tromboembolismo suele tener taquicardia o inicio súbito; y la dehiscencia de la anastomosis da signos de peritonitis, no crepitaciones aisladas.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 123

Un paciente de 17 años, apendicectomizado hace 6 horas, evoluciona con malestar general y dolor abdominal intenso. Su pulso es regular a 120 latidos por minuto, su presión arterial es 90/50 mmHg y su temperatura es 37,7 grados. En el examen abdominal presenta dolor a la palpación profunda y superficial, con signos peritoneales difusos, mayores en el hemiabdomen inferior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hemoperitoneo
B) Evisceración
C) Trombosis de la vena porta
D) Dehiscencia de la base apendicular
E) Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta D. Peritonitis difusa con taquicardia e hipotensión pocas horas después de una apendicectomía apunta a dehiscencia del muñón apendicular, complicación más frecuente que el hemoperitoneo. El hemoperitoneo da primero palidez y shock, con signos peritoneales tardíos. Requiere reanimación y reoperación.

Pregunta de práctica

Hombre de 54 años, fumador, operado hace 20 horas de hemicolectomía izquierda por cáncer de colon. Presenta temperatura de 38,3 °C y frecuencia respiratoria de 22 por minuto. La herida está limpia, sin eritema ni secreción. Al examen pulmonar hay murmullo vesicular disminuido y crepitaciones finas en ambas bases. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar ceftriaxona endovenosa por sospecha de neumonía
B) Indicar analgesia adecuada, espirometría incentivada y deambulación precoz
C) Abrir la herida operatoria para descartar infección oculta
D) Solicitar tomografía de tórax de urgencia
E) Instalar catéter venoso central para monitorización

Respuesta B. Fiebre en las primeras 24 horas, herida limpia y crepitaciones bibasales: es el cuadro clásico de atelectasia pulmonar, favorecido por el tabaquismo. Se trata con analgesia, kinesiterapia respiratoria y movilización precoz, sin antibióticos ni estudio invasivo de la herida.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 11 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 48 años, se somete a una gastrectomía total. Al segundo día postoperatoria presenta fiebre y taquicardia, con FC: 100x' y PA: 140/90. Al examen físico presenta herida operatoria sin alteraciones, con abdomen sensible a la palpación. El examen pulmonar muestra hipoventilación basal. ¿Cuál es la causa más probable de la fiebre?

A) Infección urinaria
B) Filtración de la anastomosis
C) Reacción adversa a medicamentos
D) Tromboembolismo pulmonar
E) Atelectasia infectada

Respuesta E. La causa más frecuente de fiebre en las primeras 48 horas del posoperatorio es la atelectasia, y la hipoventilación basal en este cuadro la sugiere. La infección urinaria exige sonda y más días de evolución, y la filtración de anastomosis suele aparecer más tarde; el TEP y los fármacos son menos probables sin otros datos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente se realiza una cirugía abdominal. Usted lo evalúa a las 24 horas y obser- va que la herida operatoria presenta abundante secreción serohemática, con depresión de la zona central. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hernia umbilical
B) Eventración
C) Seroma
D) Evisceración
E) Infección de la herida operatoria

Respuesta C. Diagnóstico: Seroma (opción C). La descripción era muy pobre, pero seroma era lo más aceptable (aunque llevaba poco tiempo).. La fiebre postquirúrgica es una complicación frecuente y potencialmente grave que requiere identificar su causa para tratarla adecuadamente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 40 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente es sometido a una ccolecistectomía y a las 24 horas presenta fiebre hasta 38,3 grados celsius. Su examen físico muestra un paciente ferbil, con crepitaciones en la base pulmonar derecha, asociado a roncus. Tiene vías venosas in situ, sin eritema y su herida quirúrgica está cerrada, sin exudado ni eritema. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tromboembolismo pulmonar
B) Neumonía
C) Atelectasia
D) Infección de la herida operatoria
E) Infección asociada a catéter

Respuesta C. Atelectasias son la primera causa de fiebre postoperatoria en las primeras 24 horas y la clínica es absolutamente concordante (crepitaciones localizadas, etc).

4.01.3.006 Concepto de paciente quirúrgico ambulatorio

Dónde se enseña: Tema 11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Cirugía mayor ambulatoria: procedimiento con alta el mismo día (o estadía <24 h) en pacientes seleccionados; reduce costos, IAAS y listas de espera.
- Criterios del paciente: ASA I-II (o III estable), con acompañante adulto responsable las primeras 24 h, domicilio cercano y accesible, comprensión de instrucciones.
- Criterios del procedimiento: duración limitada (idealmente <2 h), bajo riesgo de sangrado, dolor controlable con analgesia oral, sin necesidad de cuidados especiales (hernioplastía, colecistectomía laparoscópica, várices, cirugía anal, lesiones superficiales).
- Contraindicaciones: obesidad mórbida con apnea del sueño no tratada, ASA III-IV inestable, DM descompensada, falta de acompañante o red de apoyo.
- Criterios de alta (p. ej., escala de Aldrete modificada/PADSS): signos vitales estables, orientado, deambula, tolera vía oral, dolor y náuseas controlados, sin sangrado; instrucciones escritas y teléfono de contacto.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Se evalúan pacientes para colecistectomía laparoscópica en un programa de cirugía mayor ambulatoria. **¿Cuál de los siguientes pacientes NO es candidato a cirugía ambulatoria?**

A) Mujer de 40 años, ASA I, que vive a 20 minutos del hospital con su pareja
B) Hombre de 55 años, ASA II, hipertenso controlado, acompañado por su hijo
C) Mujer de 70 años, ASA IV, con insuficiencia cardíaca descompensada, que vive sola
D) Hombre de 35 años, ASA I, con índice de masa corporal de 28
E) Mujer de 60 años, ASA II, con diabetes tipo 2 bien controlada, con cuidador en casa

Respuesta C. La cirugía mayor ambulatoria requiere un procedimiento de bajo riesgo, pacientes ASA I a II (o III estables), un adulto responsable que lo acompañe las primeras 24 horas y acceso rápido a un centro de salud. Un paciente ASA IV con enfermedad descompensada, que además vive solo, no cumple criterios.

4.01.3.007 Conceptos básicos de anestesia general, local y regional

Dónde se enseña: Tema 11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Anestesia general: hipnosis, analgesia, relajación muscular y protección neurovegetativa; inducción IV (propofol, opioide como fentanilo, relajante como rocuronio o succinilcolina) y mantención con halogenados (sevoflurano) o TIVA.
- Riesgos de anestesia general: aspiración (ayuno de 6 h sólidos y 2 h líquidos claros), hipertermia maligna (halogenados y succinilcolina; tratamiento dantroleno), vía aérea difícil, náuseas y vómitos postoperatorios.
- Anestesia regional neuroaxial: espinal (subaracnoidea, dosis pequeña, efecto rápido) y epidural (catéter, analgesia de parto y postoperatoria). Complicaciones: hipotensión, cefalea post punción (postural), hematoma epidural; contraindicada en coagulopatía, infección del sitio, hipovolemia no corregida.
- Anestesia local y bloqueos periféricos: lidocaína (inicio rápido, duración intermedia), bupivacaína (inicio lento, larga duración, más cardiotóxica); la epinefrina prolonga el efecto y reduce sangrado.
- Evaluación preanestésica: clasificación ASA (I sano a VI donante muerte cerebral; E urgencia), predictores de vía aérea difícil (Mallampati), medicamentos (anticoagulantes, antiagregantes) y alergias.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una mujer de 28 años fue sometida a una cesárea bajo anestesia raquídea, sin incidentes, hace 48 horas. Al levantarse de la cama presenta cefalea holocraneana severa y dolor cervical, que empeora drásticamente al ponerse de pie y desaparece por completo en decúbito supino. El examen neurológico es normal. **¿Cuál es el diagnóstico y su mecanismo?**

A) Meningitis bacteriana por inoculación intratecal
B) Cefalea postpunción dural, por fuga persistente de líquido cefalorraquídeo
C) Trombosis de senos durales por estado protrombótico puerperal
D) Hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma
E) Cefalea tensional por contractura cervical

Respuesta B. El carácter estrictamente postural, con alivio completo en decúbito, es patognomónico de la cefalea postpunción dural: la fuga de líquido cefalorraquídeo por el orificio de la aguja espinal reduce la presión y produce tracción de estructuras sensibles al dolor.

4.01.3.008 Conceptos de manejo en situación de catástrofe (triage, extricación, inmovilización y transporte)

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Catástrofe o incidente con múltiples víctimas: la demanda supera la capacidad de respuesta; objetivo es hacer el mayor bien al mayor número de personas. Primero seguridad de la escena y del equipo.
- Triage START (adultos): camina → verde (diferido); no respira tras abrir vía aérea → negro (fallecido/expectante); FR >30, llene capilar >2 s o no obedece órdenes → rojo (inmediato); el resto → amarillo (urgente).
- Durante el triage solo se hacen maniobras salvadoras: abrir vía aérea y controlar hemorragia externa (compresión, torniquete). JumpSTART para niños.

- Extricación: rescate del paciente atrapado manteniendo alineación cervical (collar, chaleco de extricación tipo KED), por personal entrenado.
- Inmovilización y transporte: collar cervical, tabla espinal, movilización en bloque; trasladar al centro adecuado según gravedad (no al más cercano), con comunicación previa y registro.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> En un accidente de bus con múltiples víctimas, usted aplica el triage START. Un paciente no puede caminar, respira espontáneamente con una frecuencia de 34 por minuto y tiene pulso radial palpable. **¿Qué categoría de triage le corresponde?**
>
> **A)** Verde (diferido, puede esperar)
> **B)** Amarillo (urgente, no inmediato)
> **C)** Negro (fallecido o expectante)
> **D)** Rojo (inmediato)
> **E)** Blanco (sin lesiones)
>
> Respuesta D. En el triage START, quien camina es verde. En quien no camina se evalúa la respiración: si no respira tras abrir la vía aérea es negro; si respira con frecuencia mayor de 30 por minuto es rojo. Luego se evalúan la perfusión (llene capilar mayor de 2 segundos o sin pulso radial: rojo) y la obediencia a órdenes simples.

4.01.3.009 Conceptos generales de hipertensión portal

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipertensión portal: gradiente de presión venosa hepática >5 mmHg (clínicamente significativa ≥10 mmHg; riesgo de sangrado variceal ≥12). Causa principal en Chile: cirrosis (alcohol, NASH, virus).
- Clasificación: prehepática (trombosis portal), intrahepática (presinusoidal: esquistosomiasis; sinusoidal: cirrosis; postsinusoidal) y posthepática (Budd-Chiari, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva).
- Manifestaciones: várices esofagogástricas, ascitis, esplenomegalia con trombocitopenia (hiperesplenismo), circulación colateral (cabeza de medusa), encefalopatía hepática.
- Prevención de sangrado: endoscopía de tamizaje en cirróticos; várices grandes → betabloqueador no selectivo (propranolol, carvedilol) o ligadura endoscópica.
- Hemorragia variceal: octreótido o terlipresina, ligadura endoscópica, ceftriaxona profiláctica; TIPS en refractarios. Ascitis: restricción de sodio, espironolactona ± furosemida, paracentesis evacuadora con albúmina.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 58 años con ascitis de reciente aparición. Se realiza una paracentesis diagnóstica: albúmina en líquido ascítico 1,0 g/dL, con albúmina plasmática de 3,2 g/dL. Proteínas totales del líquido 1,5 g/dL y 100 células/mm3. **¿Qué indica el gradiente de albúmina sérica-ascítica de este paciente?**
>
> **A)** Ascitis por carcinomatosis peritoneal
> **B)** Ascitis por hipertensión portal
> **C)** Ascitis por tuberculosis peritoneal
> **D)** Ascitis pancreática
> **E)** Peritonitis bacteriana secundaria
>
> Respuesta B. El gradiente de albúmina sérica-ascítica es 3,2 menos 1,0, es decir 2,2 g/dL. Un gradiente de 1,1 g/dL o más indica hipertensión portal (cirrosis, insuficiencia cardíaca, síndrome de Budd-Chiari); uno menor de 1,1 sugiere causas peritoneales como carcinomatosis, tuberculosis o pancreatitis. Las proteínas bajas orientan a cirrosis más que a causa cardíaca.

4.01.3.010 Conceptos generales del pre y post operatorio

Dónde se enseña: Tema 11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Preoperatorio: anamnesis y examen físico dirigidos (comorbilidades, fármacos, alergias, antecedentes anestésicos), clasificación ASA, riesgo cardiovascular (índice de Lee) y capacidad funcional (≥4 METs).
- Exámenes según edad, comorbilidad y tipo de cirugía (no rutinarios): hemograma, creatinina, electrolitos, glicemia, coagulación si anticoagulantes o hepatopatía, ECG en >45-50 años o cardiópatas, β-hCG en mujeres

en edad fértil.

- Manejo de fármacos: suspender anticoagulantes (warfarina ~5 días con INR <1,5; ACOD 24-72 h según función renal y riesgo), clopidogrel 5-7 días si es posible; mantener betabloqueadores y estatinas; suspender metformina el día de la cirugía; ajustar insulina.
- Ayuno: 6 h sólidos, 2 h líquidos claros (protocolos ERAS permiten carga de carbohidratos). Profilaxis antibiótica y tromboprofilaxis según riesgo (Caprini).
- Postoperatorio: control de signos vitales, dolor (analgesia multimodal), balance hídrico y diuresis, deambulación y realimentación precoz, kinesioterapia respiratoria, vigilancia de herida y complicaciones.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años, con antecedente de infarto al miocardio hace 4 años y un stent coronario, hipertenso en tratamiento con enalapril y bisoprolol, será operado de una colecistectomía laparoscópica electiva. Camina 40 minutos diarios en subida sin angina ni disnea. Toma ácido acetilsalicílico 100 mg al día. **¿Cuál es la indicación más adecuada para el día de la cirugía?**

A) Suspender el ácido acetilsalicílico y el bisoprolol por el riesgo de sangrado
B) Mantener el bisoprolol y el ácido acetilsalicílico, y omitir el enalapril de esa mañana
C) Suspender los tres fármacos 24 horas antes de la cirugía
D) Solicitar evaluación cardiológica antes de definir cualquier fármaco
E) Mantener los tres fármacos exactamente igual que todos los días

Respuesta B. Buena capacidad funcional: no necesita evaluación cardiológica adicional. El betabloqueador nunca se suspende. El ácido acetilsalicílico en prevención secundaria por stent se mantiene en cirugía general. El enalapril se suspende omitiendo solo la dosis de la mañana, para evitar hipotensión refractaria en la inducción.

4.01.3.011 Conceptos generales sobre injertos y colgajos

Dónde se enseña: Tema 11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Injerto: tejido trasladado sin su irrigación, depende de la imbibición e inosculación del lecho receptor; requiere lecho bien vascularizado (no prende sobre hueso sin periostio, tendón sin paratenon ni cartílago sin pericondrio).
- Injerto de piel parcial (epidermis + parte de dermis): prende más fácil, mayor contracción secundaria; útil en grandes superficies (quemados), puede mallarse. Total: mejor resultado estético y menos contracción; cara, manos.
- Causas de pérdida del injerto: hematoma o seroma bajo el injerto (la más frecuente), infección, movilización (cizallamiento), lecho mal vascularizado.
- Colgajo: tejido trasladado con su propia irrigación (pediculado o libre microquirúrgico); indicado en lechos pobres, exposición de estructuras nobles, defectos profundos. Locales (rotación, avance, transposición, Z-plastia) o a distancia.
- Escalera reconstructiva: cierre primario → cierre por segunda intención → injertos → colgajos locales → colgajos a distancia → colgajos libres; elegir la opción más simple que resuelva el defecto.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años sufre un accidente con una máquina que le produce una pérdida de piel en el dorso del pie, con exposición del tendón extensor sin paratendón y de hueso sin periostio. El lecho está limpio tras el aseo quirúrgico. **¿Cuál es la opción de cobertura más adecuada?**

A) Injerto de piel parcial
B) Injerto de piel total
C) Sustituto dérmico sin cobertura posterior
D) Cierre por segunda intención con curaciones
E) Colgajo

Respuesta E. Un injerto carece de irrigación propia y depende del lecho receptor para nutrirse, por lo que no prende sobre hueso sin periostio, tendón sin paratendón, cartílago sin pericondrio ni material de osteosíntesis expuesto. En esos casos se requiere un colgajo, que lleva su propio pedículo vascular. Los injertos son ideales sobre lechos bien vascularizados, como el tejido de granulación.

4.01.3.012 Diagnóstico precoz del cáncer mamario

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Cáncer de mama: más frecuente en mujeres chilenas; la detección precoz busca diagnosticar lesiones no palpables con mejor pronóstico.
- Mamografía de tamizaje: estrategia con evidencia de reducción de mortalidad; en Chile, examen de medicina preventiva (EMP) con mamografía en mujeres de 50 a 59 años cada 3 años (en la práctica también se usa 50-69 años cada 2 años).
- Examen físico de mamas por profesional en controles de salud; el autoexamen no ha demostrado reducir mortalidad pero promueve el conocimiento del propio cuerpo.
- Alto riesgo (BRCA, antecedente familiar fuerte, radioterapia torácica antes de los 30): tamizaje más precoz e intensivo (mamografía y RM anual desde ~30 años o 10 años antes del caso índice), consejería genética.
- BI-RADS: 0 incompleto (completar con eco/proyecciones), 1-2 benigno (control habitual), 3 probablemente benigno (control a 6 meses), 4-5 sospechoso/altamente sospechoso (biopsia), 6 cáncer confirmado; sospecha activa el GES.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 134**
>
> Mujer de 55 años se realiza una mamografía que es informada como BI-RADS 4, con microcalcificaciones agrupadas.
> **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Ecotomografía mamaria
> **B)** Biopsia estereotáxica
> **C)** Resonancia magnética
> **D)** Control mamográfico en 6 meses
> **E)** Mastectomía parcial
>
> Respuesta B. BI-RADS 4 implica sospecha de malignidad y exige biopsia. Las microcalcificaciones agrupadas no palpables y habitualmente no visibles en ecografía se biopsian con guía estereotáxica (mamográfica), que permite el diagnóstico precoz de un carcinoma in situ o invasor. El control en 6 meses es la conducta del BI-RADS 3.

4.01.3.013 Epidemiología del cáncer.

Dónde se enseña: Tema 1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile el cáncer es la primera causa de muerte en varias regiones, superando a las enfermedades cardiovasculares; su incidencia aumenta con el envejecimiento poblacional.
- Principales causas de muerte por cáncer: en hombres estómago, próstata y pulmón; en mujeres mama, vesícula, pulmón y colorrectal (colorrectal en aumento en ambos sexos).
- Particularidades chilenas: altas tasas de cáncer gástrico (H. pylori) y de vesícula (colelitiasis, mujeres del sur), cáncer pulmonar y de vejiga por arsénico en el norte.
- Factores modificables: tabaco (el principal), alcohol, obesidad, sedentarismo, dieta (sal, carnes procesadas, baja en fibra), infecciones (VPH, VHB, VHC, H. pylori), radiación solar.
- Prevención: primaria (vacuna VPH y VHB, cese tabáquico, estilo de vida saludable) y secundaria (PAP, mamografía, sangre oculta en deposiciones, endoscopía en grupos de riesgo); múltiples cánceres con garantías GES y Ley Nacional del Cáncer.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una charla sobre epidemiología del cáncer en Chile, se analiza la mortalidad por tumores malignos en hombres. **¿Cuál es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile?**

A) Cáncer gástrico
B) Cáncer de próstata
C) Cáncer de pulmón
D) Cáncer colorrectal
E) Cáncer de vesícula biliar

Respuesta A. En Chile, los tumores malignos son una de las principales causas de muerte, y en hombres el cáncer gástrico ocupa históricamente el primer lugar de mortalidad oncológica, seguido por próstata y pulmón. Por eso existe la garantía GES de endoscopía en mayores de 40 años con epigastralgia persistente, para diagnosticarlo precozmente.

4.01.3.014 Evaluación nutricional

Dónde se enseña: Tema 11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Desnutrición hospitalaria es frecuente y aumenta complicaciones (infección, dehiscencia, estadía); tamizar a todo paciente quirúrgico.
- Herramientas: IMC (<18,5 desnutrición), pérdida de peso involuntaria (>10% en 6 meses o >5% en 1 mes es significativa), Valoración Global Subjetiva, NRS-2002 y criterios GLIM.
- Laboratorio: albúmina (vida media ~20 días, refleja estado crónico y también inflamación; <3 g/dl mayor riesgo), prealbúmina (vida media 2 días, estado reciente), recuento de linfocitos, transferrina.
- Antropometría: pliegue tricipital (reserva grasa), circunferencia braquial y muscular del brazo (reserva proteica), dinamometría (fuerza).
- Requerimientos habituales: 25-30 kcal/kg/día y proteínas 1,2-1,5 g/kg/día (más en catabolismo, quemados); en desnutridos severos realimentar lento por riesgo de síndrome de realimentación (hipofosfemia, hipokalemia, hipomagnesemia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 64 años con cáncer gástrico resecable, programado para gastrectomía. Ha bajado 12% de su peso en los últimos 6 meses, tiene un índice de masa corporal de 18 kg/m2 y albúmina plasmática de 2,8 g/dL. **¿Cuál es la conducta más adecuada desde el punto de vista nutricional?**

A) Soporte nutricional preoperatorio, de preferencia enteral, por 7 a 14 días
B) Operar de inmediato, porque el estado nutricional no influye en la evolución
C) Postergar la cirugía 6 meses hasta normalizar la albúmina
D) Solo suplementar vitaminas por vía oral
E) Nutrición parenteral exclusiva por 3 meses

Respuesta A. Una baja de peso mayor de 10% en 6 meses, IMC menor de 18,5 y albúmina menor de 3 g/dL indican desnutrición grave, que aumenta las complicaciones postoperatorias (dehiscencias, infecciones). Está indicado un soporte nutricional preoperatorio de 7 a 14 días, preferentemente por vía enteral, sin retrasar en exceso una cirugía oncológica.

4.01.3.015 Ileostomías

Dónde se enseña: Tema 2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

QUÉ HAY QUE SABER

- Ileostomía: abocamiento del íleon a la piel; terminal (tras colectomía total o proctocolectomía: colitis ulcerosa, poliposis) o en asa (protección temporal de anastomosis colorrectal baja o ileoanal).
- Débito líquido y rico en enzimas: alto riesgo de deshidratación, hiponatremia, hipokalemia e hipomagnesemia, y de dermatitis periestomal. Débito alto: >1,5-2 L/día.
- Estoma debe protruir ~2-3 cm (espiga de Brooke) para evitar contacto del efluente con la piel.
- Manejo del alto débito: soluciones de rehidratación oral (evitar líquidos hipotónicos en exceso), loperamida, dieta astringente, reponer electrolitos; mayor riesgo de litiasis renal (oxalato, úrica) y biliar.
- Complicaciones: necrosis, retracción, prolapso, hernia paraestomal, obstrucción (bolo alimentario). Cuidados por enfermería de ostomías y educación; cierre de ileostomía temporal en 2-3 meses tras verificar la anastomosis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 32 años con colitis ulcerosa grave refractaria es sometida a colectomía total con ileostomía terminal. Al cuarto día postoperatorio, la ileostomía drena 2.000 mL al día. Presenta sed, mareos, sequedad de mucosas y creatinina que sube de 0,7 a 1,6 mg/dL. **¿Cuál es la complicación más probable?**

A) Obstrucción intestinal por hernia paraestomal
B) Deshidratación con insuficiencia renal aguda prerrenal por ileostomía de alto débito
C) Necrosis del estoma
D) Síndrome de intestino corto
E) Infección de sitio quirúrgico

Respuesta B. Las ileostomías pierden agua y sodio, y un débito mayor de 1,5 a 2 L al día produce deshidratación, hiponatremia, hipokalemia e insuficiencia renal aguda prerrenal, la complicación metabólica precoz más frecuente. Se maneja con reposición hidroelectrolítica, soluciones de rehidratación oral, restricción de líquidos hipotónicos y antidiarreicos como loperamida.

4.01.3.016 Infección quirúrgica e intrahospitalaria

Dónde se enseña: Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS): ITU asociada a catéter urinario, neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia asociada a CVC, infección de herida operatoria y diarrea por C. difficile; vigilancia obligatoria en Chile (Programa Nacional de IAAS).
- Clasificación de heridas: limpia (I, ~2% infección: hernia), limpia-contaminada (II: apertura controlada de tubo digestivo/vía biliar), contaminada (III: herida traumática reciente, derrame de contenido), sucia (IV: pus, perforación, >6 h).
- Infección del sitio quirúrgico: incisional superficial, profunda o de órgano/espacio, dentro de 30 días (90 si hay prótesis). Factores: obesidad, DM, tabaco, desnutrición, cirugía prolongada, hipotermia.
- Prevención: higiene de manos, profilaxis antibiótica en el momento correcto, no rasurar, clorhexidina en piel, normotermia, control glicémico, técnica quirúrgica, retiro precoz de dispositivos invasivos, paquetes de medidas (bundles).
- Tratamiento de infección de herida: abrir y drenar, curaciones, cultivo; antibióticos si celulitis o compromiso sistémico. Aislamiento de contacto para gérmenes multirresistentes (SAMR, EPC, VRE).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 55 años, operada hace 5 días de una colectomía por laparotomía. Presenta fiebre de 38 grados y la herida operatoria muestra eritema, calor, induración y salida de pus entre los puntos, sin dehiscencia aponeurótica. Abdomen sin signos peritoneales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Abrir la herida retirando puntos, drenar, tomar cultivo y realizar curaciones
B) Antibiótico oral y mantener los puntos
C) Reoperar de urgencia por sospecha de filtración
D) Aplicar compresas frías y observar
E) Cerrar nuevamente la herida con puntos de refuerzo

Respuesta A. Es una infección superficial del sitio quirúrgico, típica entre el quinto y séptimo día. El tratamiento principal es abrir la herida, drenar, cultivar y curar, dejándola cerrar por segunda intención. Los antibióticos se agregan solo si hay celulitis extensa o compromiso sistémico significativo.

4.01.3.017 Manejo del dolor

Dónde se enseña: Tema 11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluar el dolor con escalas (EVA o numérica 0-10; faciales en niños) y reevaluar periódicamente; distinguir nociceptivo somático, visceral y neuropático.
- Escalera analgésica OMS: leve → paracetamol (1 g c/6-8 h, máx 4 g/día) y/o AINE (ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno); moderado → agregar opioide débil (tramadol 50-100 mg c/6-8 h, codeína); severo → opioide fuerte (morfina, fentanilo, metadona).

- Analgesia multimodal postoperatoria: combinar paracetamol, AINE, opioides y técnicas regionales (epidural, bloqueos, infiltración de la herida) para reducir dosis de opioides.
- Precauciones: AINE (úlcera, sangrado, falla renal, HTA, cardiopatía; preferir con IBP y evitar en ERC); opioides (constipación → laxante siempre; náuseas, sedación, depresión respiratoria → naloxona).
- Dolor neuropático: gabapentina, pregabalina, amitriptilina. Cuidados paliativos y alivio del dolor por cáncer avanzado es GES.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 55 años, en su primer día postoperatorio de una laparotomía por histerectomía, refiere dolor EVA 8/10 pese a paracetamol y ketorolaco endovenosos en horario. No tiene contraindicaciones ni alergias. **¿Cuál es la conducta analgésica más adecuada?**
>
> **A)** Mantener el mismo esquema y esperar que el dolor ceda
> **B)** Suspender todo y usar solo dipirona
> **C)** Agregar un segundo AINE
> **D)** Agregar un opioide, como morfina endovenosa titulada, manteniendo la analgesia multimodal
> **E)** Indicar diazepam para disminuir la ansiedad
>
> Respuesta D. El dolor postoperatorio severo que no cede con analgesia no opioide requiere agregar un opioide (por ejemplo, morfina endovenosa titulada o en bomba de analgesia controlada por el paciente), manteniendo paracetamol y AINE como base multimodal para reducir la dosis de opioide. Combinar dos AINE no mejora la analgesia y aumenta la toxicidad.

4.01.3.018 Tratamiento antitetánico y antirrábico

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Tétanos (C. tetani): heridas profundas, contaminadas con tierra, deposiciones o saliva, con tejido desvitalizado. Todas las heridas requieren aseo y desbridamiento.
- Esquema: herida limpia menor → toxoide (dT) solo si vacunación incompleta/desconocida o última dosis hace >10 años. Herida tetanígena → dT si última dosis >5 años, y agregar inmunoglobulina antitetánica 250-500 UI IM si vacunación incompleta o desconocida (en sitio distinto).
- Vacunación antitetánica: PNI con hexavalente (2, 4, 6 y 18 meses), refuerzos escolares (1° y 8° básico dTpa) y embarazadas (dTpa); adultos dT de refuerzo cada 10 años.
- Rabia: en Chile el reservorio principal es el murciélago; toda mordedura de mamífero exige aseo inmediato con agua y jabón abundante (15 min), evaluar el animal (observar perro/gato 10 días) y notificar.
- Profilaxis antirrábica post exposición: vacuna en días 0, 3, 7 y 14 (o según esquema MINSAL vigente) si contacto con murciélago, animal silvestre, animal no observable o que enferma; inmunoglobulina antirrábica en exposiciones graves (cabeza, cuello, manos, múltiples o murciélago).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 58 años sufre una herida cortante de 4 centímetros en la pierna izquierda con una lata oxidada, visiblemente sucia con tierra. Refiere esquema de vacunación al día, con la última dosis de refuerzo hace 7 años. **¿Cuál es la indicación correcta respecto a la profilaxis antitetánica?**
>
> **A)** No requiere ninguna intervención porque la última dosis fue hace menos de 10 años
> **B)** Administrar únicamente una dosis de refuerzo de vacuna antitetánica
> **C)** Administrar únicamente inmunoglobulina antitetánica
> **D)** Administrar vacuna e inmunoglobulina antitetánica simultáneamente
> **E)** Indicar penicilina benzatina en lugar de profilaxis antitetánica
>
> Respuesta B. Con esquema completo previo y herida sucia, el corte para el refuerzo es de 5 años, no de 10. Como pasaron 7 años, corresponde una dosis de refuerzo de vacuna. No requiere inmunoglobulina, porque conserva memoria inmunológica que responde con el toxoide.

Exámenes e imagenología 15 códigos

4.01.4.001 Radiografía de tórax

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.5 Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

QUÉ HAY QUE SABER

- Técnica: idealmente PA y lateral de pie en inspiración profunda; AP en decúbito en pacientes graves (agranda la silueta cardíaca). Verificar identificación, rotación (clavículas equidistantes de apófisis espinosas), inspiración (≥9-10 arcos costales posteriores) y penetración.
- Lectura sistemática: partes blandas y huesos (fracturas costales), mediastino (ensanchamiento >8 cm en trauma sugiere lesión aórtica), tráquea, silueta cardíaca (índice cardiotorácico >0,5 = cardiomegalia en PA), hilios, parénquima, pleura y diafragma.
- Neumoperitoneo: aire subdiafragmático en Rx de tórax de pie (perforación de víscera hueca); el examen más útil en abdomen agudo perforativo.
- Hallazgos clave: neumotórax (línea pleural sin trama vascular; a tensión con desviación mediastínica, pero se trata sin esperar Rx), derrame (borramiento del seno costofrénico, menisco), condensación con broncograma aéreo, atelectasia (pérdida de volumen), nódulo, cavidad con nivel.
- Verificar posición de dispositivos: tubo endotraqueal 3-5 cm sobre la carina, CVC en vena cava superior, SNG bajo el diafragma, tubo pleural.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 44 años, usuario crónico de diclofenaco por lumbago, consulta por dolor epigástrico de inicio súbito hace 3 horas, tipo puñalada, que se generalizó a todo el abdomen. Está pálido, sudoroso, con presión arterial de 100/60 y frecuencia cardíaca de 110. El abdomen no tiene movimiento respiratorio, está rígido en los cuatro cuadrantes, y a la percusión desaparece la matidez hepática. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**
>
> **A)** Solicitar endoscopía digestiva alta de urgencia
> **B)** Solicitar radiografía de tórax de pie
> **C)** Indicar amilasa y lipasa seriadas
> **D)** Iniciar cefotaxima endovenosa y observar
> **E)** Solicitar colonoscopía de urgencia
>
> Respuesta B. Dolor en puñalada, abdomen en tabla y signo de Jobert son el cuadro típico de una úlcera perforada. El examen inicial, por rapidez, es la radiografía de tórax de pie, buscando neumoperitoneo. La endoscopía está contraindicada, y la cefotaxima sola es el manejo de la peritonitis primaria, no de esta.

4.01.4.002 Radiografía simple de abdomen

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- Proyecciones: decúbito (AP) y de pie (o decúbito lateral con rayo horizontal si no puede pararse) + Rx de tórax de pie para neumoperitoneo.
- Obstrucción de intestino delgado: asas centrales dilatadas (>3 cm) con válvulas conniventes que cruzan todo el diámetro («pila de monedas»), niveles hidroaéreos escalonados, poco gas en colon.
- Obstrucción de colon: asas periféricas dilatadas (>6 cm; ciego >9-12 cm riesgo de perforación) con haustras que no cruzan todo el lumen. Vólvulo de sigmoides: «grano de café» u «omega invertida»; vólvulo de ciego: asa dilatada en epigastrio/hipocondrio izquierdo.
- Otros hallazgos: neumoperitoneo, neumobilia (íleo biliar, tríada de Rigler: neumobilia, obstrucción, cálculo ectópico), calcificaciones (litiasis renal ~90% radioopaca, vesicular ~10-15%, pancreáticas en pancreatitis crónica), fecaloma, cuerpos extraños, borramiento del psoas.
- Limitaciones: baja sensibilidad en apendicitis, colecistitis, pancreatitis e isquemia; ante sospecha específica preferir ecografía o TAC.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 78 años, postrado y con constipación crónica, consulta por 2 días de distensión abdominal marcada, dolor cólico y ausencia de eliminación de gases. Está hemodinámicamente estable, sin signos peritoneales. La radiografía simple de abdomen muestra un asa colónica muy dilatada en forma de U invertida, que nace de la pelvis y se proyecta hacia el hipocondrio derecho, con aspecto de grano de café. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Vólvulo de sigmoides
B) Obstrucción de intestino delgado por bridas
C) Íleo biliar
D) Megacolon tóxico
E) Íleo paralítico

Respuesta A. El signo del grano de café, un asa sigmoidea gigante en U invertida que nace de la pelvis, es el hallazgo radiológico clásico del vólvulo de sigmoides, típico del adulto mayor postrado y constipado. Sin necrosis ni peritonitis se intenta primero la desvolvulación endoscópica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 39 · texto original del banco, sin revisar

Se muestra la siguiente radiografía: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cáncer pulmonar
B) Neumoperitoneo
C) Signo de Chilaiditi
D) Absceso pulmonar
E) Quiste hidatídico

Respuesta B. foto clásica. El signo de Chilaiditi tiene el colon sobre el hígado, pero se ve con haustras y en la foto no se veían.

4.01.4.003 Radiografía de cráneo

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Uso actual limitado: en TEC la TAC de cerebro sin contraste es el examen de elección (detecta hematomas, contusiones y fracturas); la Rx de cráneo no descarta lesión intracraneana.
- Proyecciones: AP, lateral y Towne (occipital); útil para fracturas lineales o deprimidas de bóveda cuando no hay TAC disponible, cuerpos extraños radioopacos y en sospecha de maltrato infantil (serie ósea).
- Informe: fractura lineal (riesgo de hematoma epidural si cruza surco de arteria meníngea media), fractura deprimida, neumoencéfalo, desplazamiento de glándula pineal calcificada.
- Lesiones líticas en «sacabocado» (mieloma múltiple), imagen en «sal y pimienta» (hiperparatiroidismo), silla turca agrandada (adenoma hipofisario).
- Ante TEC con Glasgow <15, pérdida de conciencia, amnesia, vómitos, focalidad, signos de fractura de base (ojos de mapache, Battle, oto/rinorraquia) o anticoagulación: solicitar TAC, no Rx.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años sufre un golpe en la cabeza en una caída de escalera. Ingresa con Glasgow 13, cefalea intensa y 2 vómitos. No tiene déficit focal. **¿Cuál es el examen de imagen de elección?**

A) Radiografía de cráneo AP y lateral
B) Resonancia magnética de cerebro con gadolinio
C) TAC de cerebro sin contraste
D) Ecografía transfontanelar
E) Observación sin imágenes

Respuesta C. En el traumatismo encéfalo-craneano con Glasgow menor de 15, vómitos repetidos o cefalea intensa, el examen de elección es la TAC de cerebro sin contraste, que detecta hematomas, contusiones y fracturas. La radiografía de cráneo tiene un rol muy limitado: una fractura no descarta ni confirma lesión intracraneana. La resonancia es más lenta y menos práctica en urgencia.

4.01.4.004 Radiografía de columna cervical

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación según reglas NEXUS o canadiense: no requiere imagen si está alerta, sin intoxicación, sin dolor en línea media, sin déficit neurológico ni lesión distractora (y rota el cuello 45° en canadiense).
- En trauma moderado-severo la TAC de columna cervical es el examen de elección; la Rx (lateral, AP y transoral para odontoides) se usa si no hay TAC o en bajo riesgo.
- La Rx lateral debe mostrar de C1 hasta la unión C7-T1 (tracción de hombros o proyección del nadador); una Rx incompleta no descarta lesión.
- Informe/lectura: alineación de las 4 líneas (vertebral anterior, posterior, espinolaminar, apófisis espinosas), altura de cuerpos vertebrales, espacio prevertebral aumentado (>7 mm en C2 o >21 mm en C6), espacio atlanto-odontoideo (>3 mm adulto), fracturas de Jefferson (C1), odontoides, ahorcado (C2).
- Mantener inmovilización cervical hasta descartar lesión clínica y radiológicamente; RM si déficit neurológico o sospecha de lesión ligamentosa con imagen normal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años, motociclista, ingresa con dolor cervical posterior tras un choque. Está inmovilizado con collar cervical. La radiografía lateral de columna cervical solo permite visualizar hasta el borde inferior de C6, sin lesiones evidentes.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Retirar el collar, porque la radiografía es normal
B) Solicitar electromiografía
C) Solicitar radiografía con proyecciones en flexión y extensión
D) Mantener el collar y repetir la radiografía en 1 semana
E) Solicitar TAC de columna cervical

Respuesta E. Una radiografía lateral cervical es adecuada solo si se visualizan las 7 vértebras cervicales y la unión C7-T1, sitio frecuente de lesiones. Si no se visualiza, se debe completar el estudio: actualmente la TAC de columna cervical es el examen de elección en el trauma. Las radiografías dinámicas están contraindicadas en el paciente agudo con dolor.

4.01.4.005 Radiografía de columna dorsal y lumbar

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones en trauma: dolor en línea media dorsal/lumbar, mecanismo de alta energía, caída de altura, déficit neurológico, fractura en otro nivel de columna. TAC de elección en politraumatizado.
- Lumbalgia mecánica sin banderas rojas no requiere imagen en las primeras 4-6 semanas.
- Banderas rojas que justifican estudio: >50 años o <20, antecedente de cáncer, baja de peso, fiebre, dolor nocturno, trauma significativo, osteoporosis/corticoides, déficit neurológico progresivo, síndrome de cauda equina (este último: RM urgente).
- Informe: fracturas por compresión/acuñamiento (osteoporosis: pérdida de altura anterior), estallido (compromiso de muro posterior, inestable), Chance (flexión-distracción por cinturón de seguridad, asociada a lesión de víscera hueca), espondilolistesis, lesiones líticas o blásticas (metástasis), escoliosis.
- La RM es el examen de elección para hernia discal con radiculopatía, compresión medular, infección (espondilodiscitis) o tumor.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años, oficinista, consulta por dolor lumbar de 5 días tras levantar una caja. El dolor es mecánico, sin irradiación bajo la rodilla. No tiene fiebre, baja de peso, antecedentes de cáncer, trauma mayor ni alteraciones esfinterianas. El examen neurológico es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Radiografía de columna lumbar AP y lateral
B) Resonancia magnética lumbar
C) No solicitar imágenes; analgesia, mantener la actividad y control
D) TAC de columna lumbar
E) Reposo absoluto en cama por 2 semanas

Respuesta C. El lumbago agudo mecánico sin signos de alarma (edad mayor de 50 o menor de 20 años, cáncer, fiebre, baja de peso, trauma mayor, déficit neurológico o síntomas esfinterianos) no requiere imágenes, porque no cambian el manejo y suelen mostrar hallazgos inespecíficos. Se trata con analgesia y manteniendo la actividad; el reposo prolongado empeora la evolución.

4.01.4.006 Radiografía de pelvis y cadera

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Rx AP de pelvis es adjunto de la evaluación primaria en politraumatizado inestable: fractura de pelvis puede causar hemorragia masiva (retroperitoneal).
- Fracturas de pelvis: estables (rama única) vs inestables (anillo roto en ≥2 sitios, libro abierto, cizallamiento vertical). Manejo inicial en inestable: faja o sábana pelviana a nivel de trocánteres; no repetir maniobras de compresión.
- Fractura de cadera en adulto mayor (caída de baja energía): extremidad acortada y en rotación externa; Rx AP de pelvis y axial de cadera. Cuello (intracapsular, riesgo de necrosis avascular) vs intertrocantérica (extracapsular).
- Fractura de cadera en ≥65 años es GES (cirugía precoz idealmente en <48 h). Si Rx normal y alta sospecha: TAC o RM (fractura oculta).
- Otros hallazgos: luxación de cadera (posterior la más frecuente, reducir urgente por riesgo de necrosis), coxartrosis (disminución del espacio, osteofitos, esclerosis), displasia de cadera, Perthes y epifisiólisis en niños.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 82 años sufre una caída a nivel. Presenta dolor inguinal derecho e imposibilidad de caminar. La radiografía de pelvis AP y la axial de cadera derecha no muestran fractura, pero el dolor persiste al día siguiente e impide la marcha. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A) Repetir la radiografía en 3 semanas
B) Ecografía de cadera
C) Densitometría ósea
D) Resonancia magnética de cadera
E) Cintigrafía ósea en 1 mes

Respuesta D. Ante sospecha clínica de fractura de cadera con radiografías iniciales normales, el examen de elección es la resonancia magnética, que detecta fracturas ocultas del cuello femoral en las primeras horas (la TAC es alternativa si no hay acceso). Esperar semanas expone a desplazamiento de la fractura y necrosis avascular. La densitometría evalúa osteoporosis, no fracturas agudas.

4.01.4.007 Radiografía de extremidades

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Solicitar siempre al menos 2 proyecciones ortogonales (AP y lateral) e incluir las articulaciones proximal y distal al hueso lesionado.
- Reglas de Ottawa para tobillo y rodilla evitan radiografías innecesarias (p. ej., tobillo: dolor en maléolo posterior o incapacidad de apoyar 4 pasos).

- Informe de fractura: hueso y segmento, trazo (transverso, oblicuo, espiroideo, conminuto), desplazamiento, angulación, compromiso articular, expuesta o cerrada. En niños: fisis (Salter-Harris), fracturas en tallo verde y en rodete.
- Escafoides: dolor en tabaquera anatómica con Rx normal → inmovilizar y repetir Rx en 10-14 días o RM (riesgo de necrosis avascular).
- Otros hallazgos: luxaciones, cuerpos extraños radioopacos, gas en partes blandas (gangrena gaseosa), lesiones óseas líticas, osteomielitis (tardía). Fractura expuesta: antibióticos IV y profilaxis antitetánica urgentes, derivar a traumatología.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años sufre un esguince por inversión del tobillo derecho jugando básquetbol. Presenta dolor y edema en la zona lateral. No puede dar 4 pasos al llegar a urgencia y tiene dolor a la palpación del borde posterior del maléolo lateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar resonancia magnética de tobillo
B) Solicitar radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja
C) Inmovilizar sin estudio radiológico
D) Solicitar TAC de tobillo
E) Solicitar radiografía de pie exclusivamente

Respuesta B. Según las reglas de Ottawa, se solicita radiografía de tobillo si hay dolor en la zona maleolar con dolor a la palpación del borde posterior o la punta de cualquiera de los maléolos, o incapacidad de dar 4 pasos. Esta paciente cumple ambos criterios. La radiografía de extremidades debe incluir al menos 2 proyecciones ortogonales.

4.01.4.008 Radiografías contrastadas (EED, trànsito intestinal, enema baritada y pielografía).

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

QUÉ HAY QUE SABER

- Esofagograma (EED/esófago-estómago-duodeno): disfagia, acalasia («pico de pájaro»), divertículo de Zenker, anillos y membranas, estenosis, cáncer (imagen en «manzana mordida»), hernia hiatal.
- Sospecha de perforación o fístula: usar contraste hidrosoluble (bario produce mediastinitis/peritonitis química); en riesgo de aspiración, el contraste hidrosoluble hiperosmolar puede causar edema pulmonar.
- Tránsito intestinal: estenosis, Crohn (signo de la cuerda), tumores de intestino delgado; en gran medida reemplazado por enteroTAC/enteroRM.
- Enema baritado: Hirschsprung (zona de transición), diverticulosis, cáncer de colon («corazón de manzana»), vólvulo de sigmoides (pico de pájaro); reemplazado en su mayoría por colonoscopía y TAC. Contraindicado si sospecha de perforación o megacolon tóxico.
- Pielografía de eliminación (urografía excretora): reemplazada por uroTAC; contraindicada en alergia al medio de contraste yodado y falla renal (riesgo de nefropatía por contraste).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años presenta dolor retroesternal intenso, fiebre y enfisema subcutáneo cervical pocas horas después de vómitos violentos tras una comida copiosa con alcohol. Se sospecha una perforación esofágica. **Si se decide realizar un estudio contrastado del esófago, ¿qué medio de contraste debe utilizarse inicialmente?**

A) Bario, por su mejor definición de la mucosa
B) No se usa contraste: basta una radiografía simple
C) Aire, mediante endoscopía con insuflación
D) Gadolinio
E) Contraste hidrosoluble (yodado)

Respuesta E. Ante sospecha de perforación del tubo digestivo, el estudio contrastado debe hacerse con contraste hidrosoluble, porque el bario que escapa al mediastino o peritoneo produce una mediastinitis o peritonitis granulomatosa grave. Hoy la TAC con contraste oral hidrosoluble es el examen de elección en el síndrome de Boerhaave.

4.01.4.009 Mamografía

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 20.14 Cáncer de Mama GES, Tamizaje Mamográfico (BI-RADS) y Patología Mamaria Benigna

QUÉ HAY QUE SABER

- Tamizaje en mujeres asintomáticas (EMP 50-59 años cada 3 años en Chile) y diagnóstica ante nódulo, retracción, telorrea sanguinolenta o hallazgos al examen; en <35-40 años preferir ecografía (mama densa).
- Proyecciones estándar: cráneo-caudal y medio-lateral oblicua bilateral; complementarias con compresión focal o magnificación; ecografía complementa mamas densas y diferencia quiste de sólido.
- Hallazgos sospechosos: masa de bordes espiculados o irregulares, microcalcificaciones agrupadas, pleomórficas o lineales ramificadas, distorsión de la arquitectura, asimetría en desarrollo, retracción de piel o pezón.
- Informe BI-RADS: 0 incompleto, 1 negativo, 2 benigno, 3 probablemente benigno (control en 6 meses), 4 sospechoso (biopsia), 5 altamente sugerente de malignidad (biopsia), 6 malignidad comprobada.
- Conducta: BI-RADS 4-5 → derivar a patología mamaria para biopsia core/estereotáxica (activa garantías GES); una mamografía normal no descarta cáncer ante nódulo palpable sospechoso.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 179**
>
> Paciente con una lesión mamográfica clasificada como BI-RADS 3. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Biopsia core guiada por imagen
> **B)** Ecografía mamaria dirigida
> **C)** Resonancia magnética mamaria bilateral
> **D)** Mamografía de control en 6 meses
> **E)** Control en 1 año sin exámenes
>
> Respuesta D. BI-RADS 3 significa hallazgo probablemente benigno, con riesgo de malignidad menor de 2%. Se maneja con seguimiento a corto plazo: mamografía de control a los 6 meses y luego periódicamente hasta completar 2 años de estabilidad. La biopsia se reserva para BI-RADS 4 y 5, o si la lesión cambia en el seguimiento.

4.01.4.010 TAC de tórax

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: nódulo pulmonar o masa en Rx, etapificación de cáncer, sospecha de TEP (angioTAC), trauma torácico grave (lesión aórtica, contusión pulmonar, neumotórax oculto), enfermedad intersticial (TAC de alta resolución), bronquiectasias, derrame complicado.
- AngioTAC: defecto de llenado en arterias pulmonares (TEP); requiere contraste yodado (cuidado con función renal y alergia).
- TAC de alta resolución: patrón en panal de abejas (fibrosis pulmonar idiopática), vidrio esmerilado, bronquiectasias (bronquio más ancho que su arteria, «anillo de sello»).
- Informe de nódulo: tamaño, densidad (sólido, subsólido, vidrio esmerilado), bordes, calcificación y crecimiento; seguimiento según guía Fleischner.
- Otros hallazgos: adenopatías mediastínicas, masas mediastínicas por compartimento, enfisema, cavidades, empiema loculado, neumomediastino (perforación esofágica).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años, en su décimo día postoperatorio de una artroplastía de cadera, presenta disnea súbita y dolor pleurítico. FC 110 lpm, PA 125/80 mmHg, SatO2 89% ambiental. Tiene edema de la pantorrilla izquierda. Su score de Wells indica alta probabilidad clínica. **¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico?**

A) AngioTAC de tórax (angiografía pulmonar por TAC)
B) Dímero D
C) Radiografía de tórax
D) TAC de tórax sin contraste
E) Espirometría

Respuesta A. Con alta probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar en un paciente estable, se solicita directamente una angioTAC de tórax, examen de elección para confirmar el diagnóstico. El dímero D solo es útil para descartar en pacientes de probabilidad baja o intermedia. La TAC sin contraste no visualiza los trombos dentro de las arterias pulmonares.

4.01.4.011 Ecografía: distinguir vesícula y líquido intraabdominal

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 11.2 Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap · Tema 11.11 Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Ecografía abdominal: primera elección para patología biliar; sin radiación, disponible y repetible; limitada por gas intestinal y obesidad.
- Vesícula normal: estructura anecoica de pared fina (<3-4 mm). Colelitiasis: imagen hiperecogénica móvil con sombra acústica posterior; barro biliar sin sombra; pólipo: no móvil, sin sombra.
- Colecistitis aguda: pared engrosada >4 mm con doble halo, líquido perivesicular, vesícula distendida, Murphy ecográfico. Vía biliar dilatada (colédoco >6-7 mm; mayor en colecistectomizados y adultos mayores) sugiere obstrucción.
- Líquido libre intraabdominal: imagen anecoica en zonas declives (Morison, espacio esplenorrenal, fondo de saco de Douglas); en trauma (FAST) en paciente inestable indica hemoperitoneo y laparotomía.
- FAST evalúa 4 ventanas (pericardio, hepatorrenal, esplenorrenal, pelvis); eFAST agrega pleuras para neumotórax y hemotórax. Una FAST negativa no descarta lesión de víscera hueca ni retroperitoneal.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años, cirrótico con ascitis, consulta por dolor en el hipocondrio derecho. En la ecografía se observan dos imágenes anecogénicas en esa región: una bajo el borde hepático y otra rodeando el hígado. **¿Qué hallazgo permite identificar cuál de ellas corresponde a la vesícula biliar y no a líquido libre?**

A) Ser completamente anecogénica
B) Ubicarse en el espacio hepatorrenal de Morrison
C) Tener bordes angulados que se amoldan entre los órganos
D) Desplazarse hacia las zonas declives al cambiar de posición al paciente
E) Tener forma ovalada con pared propia bien definida, ubicada en el lecho vesicular y que puede contener cálculos o barro

Respuesta E. Ambos son anecogénicos. La vesícula es una estructura ovalada con pared propia, en su lecho bajo el hígado, y puede tener cálculos o barro. El líquido libre no tiene pared, forma ángulos agudos entre los órganos, se ubica en zonas declives como Morrison o la pelvis y se redistribuye con los cambios de posición.

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años sufre un trauma abdominal cerrado por accidente de tránsito. Presión arterial 92/60, frecuencia cardíaca 118. En el Eco-FAST, en la ventana del hipocondrio derecho, se observa una banda anecogénica de bordes angulados entre el hígado y el riñón derecho; aparte, bajo el borde hepático, se ve una estructura ovalada anecogénica de pared fina y bien definida. **¿Cuál es la interpretación correcta?**

A) La banda entre hígado y riñón es líquido libre en el espacio de Morrison, y la estructura ovalada es la vesícula
B) Ambas imágenes corresponden a la vesícula biliar normal
C) La banda corresponde a un quiste renal simple
D) La estructura ovalada corresponde a hemoperitoneo
E) Ambas imágenes son artefactos sin significado clínico

Respuesta A. El líquido libre no tiene pared propia, forma ángulos que se amoldan entre los órganos y se acumula en zonas declives como el espacio de Morrison. La vesícula es ovalada, con pared propia y está en su lecho bajo el hígado. En un paciente inestable, un FAST positivo indica laparotomía.

4.01.4.012 Hemograma, perfil bioquímico, pefil hepático.

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

QUÉ HAY QUE SABER

- Hemograma: anemia (VCM bajo ferropénica, alto por B12/folato o alcohol), leucocitosis con desviación izquierda (infección bacteriana), leucopenia, plaquetas (trombocitopenia en hiperesplenismo/cirrosis, CID). Hemoglobina inicial puede ser normal en hemorragia aguda.
- Perfil bioquímico: glicemia, función renal (creatinina, BUN; BUN/creatinina >20 sugiere HDA o deshidratación), electrolitos, calcio, ácido úrico, proteínas totales y albúmina (estado nutricional y síntesis hepática).
- Patrón hepatocelular: transaminasas muy elevadas (>10 veces en hepatitis viral, tóxica, isquémica; AST/ALT >2 sugiere alcohol). Patrón colestásico: FA y GGT elevadas con bilirrubina directa (obstrucción biliar).
- Función de síntesis hepática: albúmina baja y TP prolongado (no corrige con vitamina K en daño hepático; sí corrige en colestasia por malabsorción de vitamina K).
- Bilirrubina indirecta aislada elevada: hemólisis (con LDH alta, haptoglobina baja, reticulocitos altos) o síndrome de Gilbert (aumenta con ayuno o estrés). Lipasa/amilasa >3 veces: pancreatitis.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 52 años consulta por ictericia y prurito. Exámenes: bilirrubina total 6,2 mg/dL (directa 5,0), fosfatasa alcalina 680 U/L (VN hasta 120), GGT 520 U/L, GOT 85 U/L y GPT 95 U/L. Hemograma normal. **¿Cuál es el patrón de laboratorio y el siguiente examen más adecuado?**

A) Patrón hepatocelular; serología de hepatitis viral
B) Hemólisis; test de Coombs directo
C) Patrón colestásico; ecografía abdominal
D) Síndrome de Gilbert; ningún examen adicional
E) Patrón hepatocelular; biopsia hepática

Respuesta C. Predominio de bilirrubina directa con fosfatasa alcalina y GGT muy elevadas, y transaminasas solo levemente aumentadas, configura un patrón colestásico. El primer examen es la ecografía abdominal, que distingue colestasia extrahepática (vía biliar dilatada) de intrahepática. En la hemólisis y el síndrome de Gilbert predomina la bilirrubina indirecta.

4.01.4.013 Pruebas de coagulación

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 8.11 Fisiología de la Hemostasia y Evaluación de Laboratorio: Recuento Plaquetario, TP/INR, TTPK y Fibrinógeno

QUÉ HAY QUE SABER

- Tiempo de protrombina (TP/INR): vía extrínseca (factor VII) y común; prolongado en uso de warfarina (meta INR 2-3), déficit de vitamina K, daño hepático y CID.
- TTPA: vía intrínseca (VIII, IX, XI, XII) y común; prolongado con heparina no fraccionada (monitoreo), hemofilias A y B, anticoagulante lúpico (no corrige con mezcla), Von Willebrand severa.

- Recuento de plaquetas (<50.000 riesgo de sangrado quirúrgico, <10-20.000 sangrado espontáneo) y fibrinógeno (bajo en CID, transfusión masiva). Tiempo de sangría casi en desuso; disfunción plaquetaria por AAS/clopidogrel no altera TP ni TTPA.
- CID: TP y TTPA prolongados, plaquetas y fibrinógeno bajos, dímero D muy elevado, esquistocitos. HBPM y ACOD no se monitorizan con TTPA (anti-Xa si se requiere).
- Antes de cirugía: estudiar coagulación si historia de sangrado, hepatopatía, anticoagulación o desnutrición; procedimientos invasivos suelen requerir INR <1,5 y plaquetas >50.000. Reversión: vitamina K, plasma o complejo protrombínico (warfarina), protamina (heparina).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años hospitalizado por una trombosis venosa profunda inicia tratamiento con heparina no fraccionada en infusión endovenosa continua. **¿Qué examen de laboratorio se utiliza para monitorizar la dosis de este fármaco?**

A) Tiempo de protrombina expresado como INR
B) Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA)
C) Recuento de plaquetas exclusivamente
D) Tiempo de sangría
E) Dímero D

Respuesta B. La heparina no fraccionada potencia la antitrombina e inhibe principalmente la vía intrínseca y común; su efecto se monitoriza con el TTPA, buscando 1,5 a 2,5 veces el valor control (o niveles anti-Xa). El INR controla los antagonistas de vitamina K. El recuento de plaquetas se vigila por riesgo de trombocitopenia inducida por heparina.

4.01.4.014 Gases arteriales y electrolitos plasmáticos

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Acidosis Metabólica: Anion Gap, Brecha Osmolar y Bicarbonatoterapia

QUÉ HAY QUE SABER

- Valores normales: pH 7,35-7,45, PaCO2 35-45 mmHg, HCO3 22-26 mEq/l, PaO2 80-100 mmHg (respirando aire); PaO2/FiO2 <300 indica falla respiratoria (SDRA según grado).
- Análisis sistemático: pH (acidemia/alcalemia) → trastorno primario (PaCO2 respiratorio, HCO3 metabólico) → compensación esperada (acidosis metabólica: PaCO2 esperada = 1,5 × HCO3 + 8 ± 2, fórmula de Winter).
- Acidosis metabólica: calcular anión gap = Na − (Cl + HCO3) (normal 8-12). AG aumentado: cetoacidosis, láctica (shock, isquemia), insuficiencia renal, tóxicos (metanol, etilenglicol, salicilatos); AG normal: diarrea, fístulas pancreáticas/ileostomía, acidosis tubular renal.
- Alcalosis metabólica: vómitos o SNG con pérdida de HCl (hipoclorémica e hipokalémica), diuréticos; se corrige con suero fisiológico y potasio. Acidosis respiratoria: hipoventilación (EPOC, sedación); alcalosis respiratoria: ansiedad, TEP, sepsis precoz.
- Electrolitos: hiponatremia (corregir no más de 8-10 mEq/l en 24 h: mielinolisis), hiperkalemia (ECG con T picudas → gluconato de calcio, insulina + glucosa, salbutamol), hipokalemia (íleo, arritmias; reponer KCl), hipercalcemia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años con diabetes tipo 1 ingresa con vómitos y respiración profunda. Gases arteriales: pH 7,20; pCO2 26 mmHg; HCO3 10 mEq/L. Electrolitos: Na 138 mEq/L, Cl 100 mEq/L, K 5,2 mEq/L. **¿Cuál es la interpretación correcta?**

A) Acidosis metabólica con anión gap normal
B) Acidosis metabólica con acidosis respiratoria agregada
C) Acidosis respiratoria aguda
D) Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria
E) Acidosis metabólica con anión gap aumentado y compensación respiratoria adecuada

Respuesta E. pH bajo con bicarbonato bajo indica acidosis metabólica. El anión gap es 138 menos (100 más 10), es decir 28, aumentado (normal alrededor de 12), compatible con cetoacidosis. La pCO2 esperada según Winter es 1,5 por 10 más 8, es decir 23 más o menos 2; 26 está en el límite, por lo que la compensación respiratoria se considera adecuada.

4.01.4.015 TAC de abdomen y pelvis

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 11.3 Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx · Tema 11.4 Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

QUÉ HAY QUE SABER

- TAC de abdomen y pelvis con contraste IV: examen de mayor rendimiento en abdomen agudo del adulto (apendicitis, diverticulitis complicada, obstrucción, perforación, isquemia, pancreatitis grave), trauma abdominal en paciente estable y etapificación oncológica.
- Antes del contraste yodado: evaluar función renal (riesgo de nefropatía por contraste; hidratar), alergia previa (premedicación), metformina (suspender en falla renal), embarazo (preferir ecografía o RM).
- Hallazgos a reconocer en el informe: apéndice >6 mm con alteración de grasa, absceso, aire libre, zona de transición en obstrucción, neumatosis intestinal/gas portal (isquemia), necrosis pancreática, colecciones.
- Trauma: laceraciones de hígado/bazo con grado de lesión, hemoperitoneo, sangrado activo (blush de contraste), lesión renal; paciente inestable no va a TAC.
- AngioTAC para isquemia mesentérica y aneurisma aórtico; uroTAC sin contraste para litiasis urinaria (el más sensible); TAC trifásico para tumores hepáticos y pancreáticos.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 68 años consulta por 3 días de dolor progresivo en la fosa ilíaca izquierda, con fiebre de 38 grados y constipación. Al examen: resistencia muscular localizada en esa zona, sin masa palpable. Leucocitos 14.800. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A) Colonoscopía para visualizar directamente el colon
B) TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso
C) Enema baritado para evaluar los divertículos
D) Radiografía simple de abdomen de pie
E) Ecografía transvaginal para descartar causa ginecológica

Respuesta B. Cuadro clásico de diverticulitis aguda: dolor progresivo en FII con fiebre y leucocitosis en una adulta mayor. El TAC de abdomen y pelvis con contraste es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y etapificar según Hinchey. La colonoscopía y el enema baritado están contraindicados en la fase aguda por riesgo de perforación.

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años, sin cirugías abdominales previas, consulta por 24 horas de dolor cólico, vómitos y detención del tránsito de gases. Está estable, afebril, sin hernias palpables. La radiografía simple de abdomen muestra asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos. **¿Cuál es el examen más útil para definir la causa de la obstrucción y buscar signos de sufrimiento intestinal?**

A) Tránsito intestinal con bario
B) Colonoscopía
C) TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso
D) Ecografía abdominal
E) Repetir la radiografía simple en 24 horas

Respuesta C. Sin cirugía previa las bridas son poco probables, por lo que hay que buscar otra causa. La TAC con contraste muestra el punto de transición, la causa, como tumor, hernia interna o íleo biliar, y signos de isquemia o perforación. El bario está contraindicado ante sospecha de perforación.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 32 códigos

4.01.5.001 Anestesia local por infiltración

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: sutura de heridas, drenaje de abscesos, extirpación de lesiones superficiales. Lidocaína 1-2% (inicio 2-5 min, duración 1-2 h; con epinefrina 2-4 h).
- Dosis máxima de lidocaína: 4,5 mg/kg (máx 300 mg) sin epinefrina y 7 mg/kg (máx 500 mg) con epinefrina; 1% = 10 mg/ml (en 70 kg sin epinefrina ≈ 30 ml de lidocaína al 1%).
- Técnica: asepsia, aguja fina (25-27 G), inyectar lento a través de los bordes de la herida (menos doloroso), aspirar antes de inyectar para evitar vía intravascular; esperar el efecto antes de manipular.

- Epinefrina reduce sangrado y prolonga el efecto; históricamente evitada en dedos, pene, nariz y orejas (actualmente se considera segura en dedos con circulación normal, pero precaución en vasculopatía).
- Reconocer toxicidad (parestesias peribucales, sabor metálico, tinnitus, convulsiones, arritmias): suspender, oxígeno, benzodiazepinas y emulsión lipídica 20%. Bicarbonato en la solución reduce el dolor de la infiltración.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 60 kg con una herida cortante de 6 cm en el antebrazo, que requiere sutura. Se usará lidocaína al 1% sin epinefrina para anestesia local por infiltración. Recuerde que la solución al 1% contiene 10 mg por mL. **¿Cuál es el volumen máximo aproximado que se puede infiltrar?**
>
> **A)** 5 mL
> **B)** 10 mL
> **C)** 100 mL
> **D)** 60 mL
> **E)** 27 mL
>
> Respuesta E. La dosis máxima de lidocaína sin epinefrina es de 4,5 mg/kg, con techo de 300 mg. En 60 kg son 270 mg, que al 1% equivalen a 27 mL. Al infiltrar se aspira antes de inyectar para evitar inyección intravascular, y se vigilan pródromos de toxicidad como sabor metálico o parestesias peribucales.

4.01.5.002 Anestesia troncular de dedos y ortejos

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 11.15 Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

QUÉ HAY QUE SABER

- Bloqueo digital (troncular) de dedos y ortejos: bloquea los 4 nervios digitales (2 dorsales y 2 palmares/plantares) en la base del dedo; indicado en onicectomía, heridas y drenaje de panadizos.
- Técnica clásica: inyectar lidocaína 1-2% sin epinefrina (2-3 ml por lado) en ambas caras laterales de la base del dedo, desde dorsal hacia palmar/plantar; volumen total máximo ~6-8 ml para no comprimir los vasos.
- Evitar anestésico con epinefrina en pacientes con vasculopatía periférica, Raynaud o diabetes con mala perfusión; no usar torniquete prolongado.
- Complicaciones: isquemia digital por volumen excesivo o compresión, lesión neurovascular, inyección intravascular, infección.
- Nivel del perfil: conocer la técnica y sus indicaciones; derivar a especialista cuando el procedimiento no puede realizarse con seguridad o hay compromiso vascular previo.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 30 años requiere sutura de una herida en el pulpejo del dedo índice. Se decide realizar una anestesia troncular digital con lidocaína. **¿Cuál es la técnica correcta?**
>
> **A)** Infiltrar directamente en el pulpejo, alrededor de la herida
> **B)** Infiltrar solo en la cara dorsal de la falange distal
> **C)** Infiltrar en la muñeca a nivel del nervio radial exclusivamente
> **D)** Infiltrar en la base del dedo, en ambas caras laterales (dorsolateral y palmar-lateral), donde transcurren los nervios digitales
> **E)** Infiltrar en forma circular completa con gran volumen, como un anillo apretado
>
> Respuesta D. La anestesia troncular digital bloquea los 4 nervios colaterales (2 dorsales y 2 palmares), que corren por las caras laterales del dedo: se infiltra en la base del dedo, a ambos lados. Se usan volúmenes pequeños, porque los anillos de gran volumen comprimen las arterias digitales; tradicionalmente se recomienda lidocaína sin vasoconstrictor.

4.01.5.003 Anoscopía

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.7 Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: rectorragia, dolor anal, prolapso, prurito, sospecha de hemorroides internas, fisura, condilomas intraanales, abscesos y fístulas (orificio interno), lesiones sospechosas de cáncer anal.

- Preparación: explicar el procedimiento, posición de Sims (decúbito lateral izquierdo con rodillas flectadas) o genupectoral; enema evacuante opcional; buena iluminación.
- Técnica: inspección anal separando glúteos, tacto rectal previo, introducir anoscopio lubricado con obturador hacia el ombligo, retirar obturador y evaluar mucosa al retirar lentamente en los distintos cuadrantes.
- Hallazgos: hemorroides internas (sobre línea pectínea, grado según prolapso), papilas hipertróficas, fisura, orificios fistulosos, condilomas, pólipos y tumores (biopsiar o derivar).
- Contraindicaciones relativas: fisura anal aguda muy dolorosa (diferir o anestesia tópica), absceso perianal agudo doloroso, estenosis anal. En >50 años con rectorragia complementar con colonoscopía.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 32 años consulta por rectorragia de sangre roja fresca, que gotea al final de la defecación, indolora, de 2 semanas de evolución. Sin baja de peso ni antecedentes familiares de cáncer de colon. El tacto rectal es normal. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**
> **A)** Anoscopía
> **B)** Colonoscopía total urgente
> **C)** TAC de abdomen y pelvis
> **D)** Enema baritado
> **E)** Cintigrafía con glóbulos rojos marcados
> Respuesta A. En un adulto joven con rectorragia indolora de sangre roja que gotea al final de la deposición, la causa más probable son las hemorroides internas, que no se palpan en el tacto rectal. La anoscopía es el examen inicial que permite visualizarlas. Si no se encuentra la causa o hay signos de alarma, se complementa con colonoscopía.

4.01.5.004 Ayudantía quirúrgica (nociones básicas)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.17 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

QUÉ HAY QUE SABER

- Nociones básicas: lavado quirúrgico de manos, vestimenta estéril (bata y guantes con técnica cerrada), respetar el campo estéril y la zona estéril (adelante, entre cintura y hombros).
- Funciones del ayudante: exposición del campo con separadores, aspiración y secado, tracción y contratracción, corte de suturas, hemostasia con pinzas y ligaduras, anticipar los tiempos quirúrgicos.
- Instrumental básico: bisturí (hojas 10, 11, 15), tijeras Metzenbaum (tejidos) y Mayo (suturas), pinzas con y sin dientes, Kelly y Kocher, porta agujas, separadores (Farabeuf, Richardson).
- Suturas: absorbibles (catgut, poliglactina/Vicryl, PDS) para planos profundos y no absorbibles (nylon, seda, polipropileno) para piel y vasos; nudos cuadrados seguros.
- Seguridad: pausa de seguridad (lista de verificación quirúrgica OMS), recuento de compresas e instrumental, manejo seguro de cortopunzantes (no reencapuchar).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un interno se prepara para participar como ayudante en una laparotomía. Ya realizó el lavado quirúrgico de manos y se colocó delantal y guantes estériles. **¿Cuál de las siguientes zonas de su delantal se considera estéril durante la cirugía?**
> **A)** La parte anterior desde el tórax hasta la cintura y las mangas hasta 5 cm sobre el codo
> **B)** La espalda completa
> **C)** Todo el delantal, incluyendo bajo la cintura
> **D)** Solo los hombros y el cuello
> **E)** Ninguna zona, solo los guantes
> Respuesta A. Por convención, en el delantal quirúrgico solo se considera estéril la cara anterior desde el tórax hasta el nivel de la mesa (cintura) y las mangas desde los puños hasta unos 5 cm sobre el codo. La espalda, los hombros, el cuello y lo bajo la cintura no son estériles; por eso las manos se mantienen frente al tórax.

4.01.5.005 Instalación y cuidado de sonda Foley

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 13.2 Uropatía Obstructiva Aguda y Retención Urinaria: Sonda Foley vs Cistostomía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: retención urinaria aguda, monitoreo de diuresis en paciente grave/shock/quemado, cirugía prolongada, incontinencia con lesiones sacras, irrigación vesical por hematuria con coágulos.
- Contraindicación absoluta: sospecha de lesión uretral (sangre en meato, hematoma perineal o escrotal, próstata alta o no palpable en trauma pélvico) → uretrografía y eventual cistostomía.
- Técnica estéril: aseo genital, lubricante con lidocaína, sonda 14-16 Fr en adulto; en hombre traccionar el pene hacia arriba (90°); avanzar hasta salida de orina y luego insertar unos centímetros más antes de inflar el balón (10 ml de agua destilada) para no dañar la uretra.
- En retención urinaria con gran volumen el vaciamiento puede ser completo (la descompresión rápida es segura; vigilar hematuria ex vacuo y diuresis postobstructiva). Reposicionar el prepucio para evitar parafimosis.
- Cuidados: sistema cerrado, bolsa bajo el nivel de la vejiga, fijación al muslo, aseo genital diario, retiro lo antes posible (principal factor de ITU asociada a catéter). No tratar bacteriuria asintomática.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años con retención urinaria aguda requiere la instalación de una sonda Foley. Se realiza técnica aséptica con lubricante con lidocaína. **¿En qué momento debe inflarse el balón de la sonda?**

A) Apenas la punta de la sonda pasa el meato
B) Al sentir resistencia en la uretra prostática, sin esperar salida de orina
C) Antes de introducir la sonda, para comprobar el balón dentro de la uretra
D) Después de observar salida de orina y avanzar la sonda hasta su bifurcación
E) Solo si el paciente refiere dolor

Respuesta D. El balón debe inflarse solo cuando se confirma que está en la vejiga: tras ver salir orina, se avanza la sonda hasta la bifurcación y luego se infla con agua destilada. Inflarlo en la uretra produce dolor, sangrado y lesión uretral (falsa vía). Ante resistencia que no cede o sangre en el meato, no se debe forzar.

4.01.5.006 Colonoscopía

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: tamizaje de cáncer colorrectal (≥50 años o FIT positivo; antecedente familiar desde 40), rectorragia, anemia ferropénica, cambio del hábito intestinal, vigilancia post polipectomía o cáncer, EII.
- Ventajas: diagnóstica y terapéutica (biopsia, polipectomía, hemostasia, dilatación, devolvulación de sigmoides, tatuaje de lesiones).
- Preparación intestinal (polietilenglicol) indispensable; dieta sin residuos previa; ajustar anticoagulantes/antiagregantes, hierro y hipoglicemiantes; sedación habitual.
- Contraindicaciones: perforación sospechada, peritonitis, diverticulitis aguda (esperar 6-8 semanas), megacolon tóxico, inestabilidad hemodinámica.
- Complicaciones: perforación (~1/1000; más con polipectomía), sangrado post polipectomía, complicaciones de la sedación. Nivel del perfil: indicar y derivar al especialista e interpretar el informe.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años, asintomático, se realiza un test inmunoquímico de sangre oculta en deposiciones como tamizaje de cáncer colorrectal, que resulta positivo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Repetir el test en 1 año
B) Colonoscopía completa
C) Rectosigmoidoscopía flexible exclusiva
D) TAC de abdomen y pelvis
E) Antígeno carcinoembrionario

Respuesta B. Un test de sangre oculta positivo en el tamizaje de cáncer colorrectal obliga a realizar una colonoscopía completa, que permite visualizar todo el colon, tomar biopsias y resecar pólipos en el mismo procedimiento. La rectosigmoidoscopía no evalúa el colon proximal, y el antígeno carcinoembrionario no sirve para diagnóstico ni tamizaje.

4.01.5.007 Cricoidostomía

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Cricotiroidotomía (cricoidostomía) quirúrgica de urgencia: vía aérea quirúrgica de elección en la situación «no puedo intubar, no puedo oxigenar» (trauma facial grave, edema de glotis, cuerpo extraño no extraíble).
- Reparos: membrana cricotiroidea, entre cartílago tiroides (arriba) y cricoides (abajo), en línea media; extender el cuello si no hay sospecha de lesión cervical (si la hay, mantener alineación).
- Técnica: estabilizar laringe con la mano no dominante, incisión vertical de piel (2-3 cm) e incisión transversa de la membrana, dilatar con mango del bisturí o pinza, introducir cánula/tubo nº 5-6 con balón, inflar, ventilar y confirmar con capnografía.
- Cricotiroidotomía por punción con aguja (14 G) y ventilación jet: de elección en niños <12 años (la quirúrgica está contraindicada por riesgo de estenosis subglótica); es transitoria (30-45 min).
- Complicaciones: sangrado, falsa vía, lesión laríngea o esofágica, enfisema subcutáneo, estenosis subglótica tardía. Convertir a traqueostomía formal en 24-72 h.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 7 años, víctima de un accidente de tránsito con trauma facial grave, presenta obstrucción de la vía aérea con desaturación progresiva. Fracasan la intubación orotraqueal y la ventilación con bolsa-mascarilla. **¿Cuál es el procedimiento de rescate de la vía aérea más adecuado?**

A) Cricotiroidotomía quirúrgica
B) Traqueostomía reglada en pabellón
C) Cricotiroidotomía por punción con aguja y ventilación en jet
D) Intubación nasotraqueal a ciegas
E) Esperar al anestesiólogo manteniendo oxígeno por mascarilla

Respuesta C. Ante un escenario de no intubable y no oxigenable, se requiere una vía aérea quirúrgica. En menores de 12 años la cricotiroidotomía quirúrgica está relativamente contraindicada por riesgo de estenosis subglótica, y se prefiere la punción cricotiroidea con aguja y ventilación en jet. La intubación nasal está contraindicada en trauma facial grave.

4.01.5.008 Curación básica de quemaduras

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.13 Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Quemaduras tributarias de manejo ambulatorio: superficiales (A o AB superficial) de poca extensión (<10% en adultos, <5% en niños) sin zonas especiales ni lesiones asociadas.
- Primera atención: retirar la fuente y la ropa, enfriar con agua corriente tibia/fría (no hielo) por 10-20 min, analgesia (paracetamol, AINE, opioide si es necesario) y profilaxis antitetánica.
- Curación: aseo con suero fisiológico o agua y jabón neutro, retirar tejido desvitalizado y flictenas rotas (las flictenas pequeñas e íntegras pueden dejarse), cubrir con apósito no adherente (gasa vaselinada, tull) ± sulfadiazina de plata 1% o apósitos bioactivos; vendaje.
- Frecuencia: curar cada 24-72 h según apósito y exudado; vigilar signos de infección (eritema perilesional, aumento de dolor, secreción, fiebre) y profundización.
- Derivar si no epiteliza en 10-14 días (sugiere quemadura profunda → injerto), quemadura en zona especial, circunferencial, eléctrica, química, en niños pequeños o adultos mayores, o sospecha de maltrato. Fotoprotección y lubricación de la piel nueva.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años se quema el antebrazo con agua hirviendo hace 2 horas. Presenta una quemadura de espesor parcial superficial, rosada, húmeda y dolorosa, con flictenas rotas, que compromete cerca del 3% de la superficie corporal. No tiene otras lesiones. **¿Cuál es el manejo local más adecuado?**

A) Aplicar hielo directo y dejar la herida descubierta
B) Lavar con suero fisiológico, retirar las flictenas rotas, cubrir con apósito no adherente y controlar en 48 a 72 horas
C) Aplicar pomada de corticoides y vendaje compresivo
D) Iniciar antibiótico oral profiláctico y dejar las flictenas intactas sin cubrir
E) Derivar de inmediato a un centro de grandes quemados

Respuesta B. La curación básica de una quemadura pequeña de espesor parcial consiste en enfriar con agua o suero a temperatura ambiente, lavar con suero, retirar el tejido desvitalizado y las flictenas rotas, y cubrir con apósito no adherente, con controles cada 48 a 72 horas. No se usan antibióticos profilácticos ni hielo.

4.01.5.009 Curación de heridas, sutura y aseo

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación previa: mecanismo y tiempo de evolución, contaminación, compromiso de tendones, nervios y vasos (examen neurovascular distal antes de anestesiar), cuerpos extraños; profilaxis antitetánica.
- Aseo: irrigación abundante con suero fisiológico a presión, desbridamiento del tejido desvitalizado, hemostasia; anestesia local con lidocaína (máx 4,5 mg/kg sin epinefrina).
- Sutura: cierre primario si <6-8 h (cara hasta 24 h) y herida limpia; mordeduras y heridas muy contaminadas en extremidades: cierre diferido o segunda intención. Puntos simples o colchonero; monofilamento no absorbible para piel (nylon 3-0/4-0 tronco y extremidades, 5-0/6-0 cara) y absorbible en planos profundos.
- Retiro de puntos: cara 5 días, cuero cabelludo 7-10, tronco y extremidades superiores 10, extremidades inferiores 10-14, sobre articulaciones 14.
- Cuidados: mantener seca 24-48 h, control a las 48 h, signos de infección (eritema, calor, secreción, fiebre) → retirar puntos y drenar. Antibiótico profiláctico solo en mordeduras, heridas muy contaminadas o inmunosuprimidos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 25 años con una herida cortante limpia de 2 cm en la mejilla, producida hace 2 horas, que se sutura con puntos simples de material no absorbible fino. **¿En cuántos días se deben retirar los puntos?**

A) Entre 5 y 7 días
B) Entre 10 y 12 días
C) Entre 14 y 21 días
D) A los 30 días
E) No se retiran porque se reabsorben

Respuesta A. En la cara, por su excelente irrigación, los puntos se retiran a los 5 a 7 días, lo que evita las marcas de los puntos. El cuero cabelludo se retira a los 7 a 10 días, el tronco y las extremidades entre 10 y 14, y sobre articulaciones hasta 14 días. El material no absorbible sí debe retirarse.

4.01.5.010 Denudación venosa

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Denudación venosa: acceso venoso quirúrgico (disección de una vena periférica para canularla bajo visión directa) cuando no es posible acceso percutáneo periférico, central o intraóseo.
- Sitios habituales: vena safena interna en el tobillo (anterior y superior al maléolo medial), vena basílica en el pliegue del codo.
- Hoy en gran parte reemplazada por la vía intraósea (rápida, segura, útil en adultos y niños en paro o shock) y por catéteres centrales guiados por ecografía.
- Complicaciones: infección, flebitis, hematoma, lesión del nervio safeno o de arteria acompañante, trombosis.

- Nivel del perfil: conocer indicaciones y alternativas, derivar al especialista; en emergencia con acceso periférico imposible, preferir vía intraósea.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 40 años en shock hemorrágico tras un politraumatismo. No ha sido posible canalizar dos vías venosas periféricas y no se dispone de dispositivo intraóseo. Se decide realizar una denudación venosa. **¿Cuál es el sitio clásico de elección para este procedimiento en el adulto?**
> **A)** Vena yugular externa
> **B)** Vena cefálica en el surco deltopectoral
> **C)** Vena femoral en el triángulo de Scarpa
> **D)** Vena subclavia
> **E)** Vena safena interna, anterior al maléolo medial
> Respuesta E. La denudación venosa es una técnica de acceso vascular de rescate cuando fracasan las vías periféricas y la vía intraósea. El sitio clásico es la vena safena interna en el tobillo, aproximadamente 2 cm anterior y superior al maléolo medial, por su ubicación constante y superficial. Hoy se prefiere la vía intraósea o central, más rápidas.

4.01.5.011 Drenaje de lesiones superficiales

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.8 Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: abscesos cutáneos y subcutáneos, forúnculos y ántrax fluctuantes, quiste epidérmico infectado, absceso pilonidal, paroniquia y panadizo, hematoma subungueal (trepanación).
- Técnica: asepsia, anestesia local (infiltración en anillo alrededor; menos eficaz en tejido inflamado), incisión siguiendo líneas de tensión de la piel sobre el punto de máxima fluctuación, suficientemente amplia.
- Evacuar pus, romper tabiques con pinza o dedo, irrigar con suero fisiológico, tomar cultivo si es recurrente o hay compromiso sistémico; dejar mecha o drenaje y no cerrar la herida.
- Antibióticos solo si celulitis extensa, compromiso sistémico, inmunosupresión, diabetes, zona facial (triángulo peligroso) o mano: cefadroxilo o flucloxacilina; clindamicina o cotrimoxazol si SAMR.
- Derivar a cirugía: abscesos profundos (perianal profundo, mano con compromiso de vainas, cuello, mama extensa), fascitis necrotizante, sepsis. Curaciones cada 24-48 h hasta cierre por segunda intención.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 30 años, sano, consulta por una lesión dolorosa en el glúteo de 5 días. Al examen presenta un nódulo de 3 cm, eritematoso, caliente y fluctuante, sin celulitis extensa. Está afebril y sin compromiso del estado general. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
> **A)** Antibióticos orales exclusivos por 10 días
> **B)** Incisión y drenaje, con aseo de la cavidad
> **C)** Compresas tibias y control en 1 semana
> **D)** Punción con aguja fina y alta
> **E)** Resección en bloque del nódulo
> Respuesta B. Un absceso cutáneo fluctuante se trata con incisión y drenaje amplio, rompiendo tabiques y aseando la cavidad. En abscesos simples, sin celulitis extensa, fiebre ni inmunosupresión, el drenaje suele ser suficiente; los antibióticos solos no penetran adecuadamente la colección. La punción simple tiene alta recurrencia.

4.01.5.012 Endoscopía digestiva alta

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: dispepsia con signos de alarma (baja de peso, disfagia, anemia, vómitos persistentes, hemorragia) o ≥40 años en Chile (GES cáncer gástrico), HDA (en <24 h), ingesta de cáusticos o cuerpo extraño, sospecha de várices, ERGE refractaria, Barrett, celíaca (biopsias duodenales).

- Terapéutica: hemostasia (inyección de adrenalina, clips, termocoagulación), ligadura de várices, extracción de cuerpos extraños, dilatación de estenosis, gastrostomía percutánea, resección de lesiones precoces.
- Permite biopsias y test de ureasa para H. pylori (suspender IBP 2 semanas y antibióticos 4 semanas antes para evitar falsos negativos).
- Preparación: ayuno de 6-8 h, ajustar anticoagulantes, sedación consciente; consentimiento informado. Contraindicaciones: perforación sospechada, inestabilidad no corregida, falta de cooperación.
- Complicaciones: perforación, sangrado, aspiración, eventos por sedación. Nivel del perfil: indicar oportunamente, derivar al especialista e interpretar el informe (clasificación de Forrest en úlceras, Los Ángeles en esofagitis).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 48 años consulta por epigastralgia de 1 mes de evolución, sin respuesta a medidas generales. No tiene baja de peso, anemia ni vómitos. No usa antiinflamatorios. **¿Cuál es la conducta más adecuada según la guía GES de cáncer gástrico?**
> **A)** Endoscopía digestiva alta con test de ureasa
> **B)** Tratamiento empírico con omeprazol por 3 meses sin estudio
> **C)** Ecografía abdominal
> **D)** Serología para Helicobacter pylori y tratamiento si es positiva
> **E)** Radiografía esófago-estómago-duodeno con bario
> Respuesta A. En Chile, por la alta incidencia de cáncer gástrico, la guía GES indica endoscopía digestiva alta en personas de 40 años o más con epigastralgia de más de 15 días, aun sin síntomas de alarma, con biopsias y test de ureasa. Probar y tratar Helicobacter pylori sin endoscopía se reserva para menores de 40 años sin signos de alarma.

4.01.5.013 Evaluación pre y post-operatoria

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 11.14 Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación preoperatoria: anamnesis (comorbilidades, fármacos, alergias, hábitos, antecedentes anestésicos y hemorrágicos), examen físico dirigido, clasificación ASA y capacidad funcional.
- Riesgo cardiovascular: índice de Lee (cirugía de alto riesgo, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, DM con insulina, creatinina >2 mg/dl); capacidad funcional <4 METs con alto riesgo → evaluación cardiológica.
- Exámenes dirigidos según edad, comorbilidad y cirugía; manejo de anticoagulantes, antiagregantes e hipoglicemiantes; optimizar HTA, DM, anemia y estado nutricional; dejar de fumar.
- Evaluación postoperatoria: signos vitales, dolor, diuresis, herida, drenajes, tolerancia oral, deambulación; detectar precozmente complicaciones (fiebre, sangrado, íleo, retención urinaria, delirio, TVP).
- Nivel del perfil: el médico general hace la evaluación básica y deriva al especialista (anestesiología, cardiología, cirugía) a pacientes de alto riesgo o con comorbilidad descompensada.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un paciente de 62 años, hipertenso en tratamiento crónico con enalapril y amlodipino, y con cardiopatía coronaria en tratamiento con bisoprolol y atorvastatina, será sometido a una hernioplastia inguinal electiva. **¿Cuál es la indicación más apropiada para el día de la intervención?**
> **A)** Suspender todos los antihipertensivos y coronarios 48 horas antes
> **B)** Suspender el enalapril 24 horas antes y mantener bisoprolol y atorvastatina la mañana de la cirugía
> **C)** Suspender el bisoprolol 24 horas antes y administrar el enalapril esa mañana
> **D)** Mantener todos los fármacos sin excepción, con un sorbo de agua
> **E)** Reemplazar todos los fármacos orales por infusión de nitroprusiato
> Respuesta B. El enalapril se suspende 24 horas antes, omitiendo la dosis de la mañana, para prevenir hipotensión refractaria. El bisoprolol y la atorvastatina nunca se suspenden bruscamente: se administran esa misma mañana, con un sorbo de agua.

4.01.5.014 Evaluación primaria en trauma

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluación primaria ATLS (XABCDE): identificar y tratar simultáneamente lesiones que amenazan la vida en los primeros minutos. X: control de hemorragia exanguinante externa (compresión, torniquete).
- A: vía aérea con restricción de movimiento de columna cervical (tracción mandibular, cánula, intubación o vía aérea quirúrgica si Glasgow ≤8 o vía aérea comprometida). B: ventilación (buscar y tratar neumotórax a tensión, abierto, hemotórax masivo, tórax volante).
- C: circulación con control de hemorragia (2 vías venosas gruesas, cristaloides tibios 1 L, transfusión precoz, ácido tranexámico, faja pelviana); identificar fuente: tórax, abdomen, pelvis, huesos largos, externa.
- D: déficit neurológico (Glasgow, pupilas, lateralización; glicemia). E: exposición completa con prevención de hipotermia (mantas, fluidos tibios).
- Adjuntos: monitoreo ECG, oximetría, capnografía, gases, Foley y SNG (si no hay contraindicación), Rx de tórax y pelvis, eFAST. Reevaluar ante cualquier deterioro; decidir traslado precoz si se requieren recursos mayores.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años, motociclista, llega tras una colisión de alta energía. Presenta ronquido y respiración ruidosa, Glasgow 8, presión arterial 90/60 y frecuencia cardíaca 120. Tiene deformidad del muslo derecho, sin sangrado externo activo.

¿Cuál es la primera acción que se debe realizar?

A) Instalar dos vías venosas gruesas e iniciar cristaloides
B) Permeabilizar y asegurar la vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical
C) Solicitar TAC de cerebro
D) Alinear e inmovilizar la fractura de fémur
E) Solicitar radiografía de pelvis

Respuesta B. La evaluación primaria sigue el orden ABCDE: primero vía aérea con protección cervical. El ronquido y el Glasgow 8 indican una vía aérea comprometida, que mata antes que la hipovolemia. Recién después se evalúa ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición.

4.01.5.015 Evaluación secundaria en trauma

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Se inicia solo cuando la evaluación primaria está completa, el paciente responde a la reanimación y sus signos vitales se normalizan.
- Historia AMPLE: alergias, medicamentos, patologías previas/embarazo (pregnancy), última comida (lunch), eventos/entorno del trauma (mecanismo).
- Examen físico de cabeza a pies: cráneo y cara, columna cervical, tórax, abdomen, periné/recto/vagina (sangre en meato, próstata alta), musculoesquelético (deformidades, pulsos, síndrome compartimental), examen neurológico completo y dorso (giro en bloque).
- Estudios complementarios dirigidos: TAC (cerebro, columna, tórax, abdomen), Rx de extremidades, eventual uretrografía, angiografía.
- Reevaluación continua: ante deterioro volver al ABCDE; documentar hallazgos y considerar la evaluación terciaria (lesiones inadvertidas en 24 h). Profilaxis antitetánica y analgesia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 40 años cae desde 4 metros. Se completa la evaluación primaria: vía aérea permeable, ventilación normal, presión arterial 120/80 tras 1 litro de cristaloides, Glasgow 15 y sin lesiones evidentes a la exposición. Se mantiene estable. **¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?**

A) Realizar la evaluación secundaria: anamnesis dirigida y examen físico completo de cabeza a pies, incluido el dorso
B) Dar de alta con analgesia y control en 48 horas
C) Realizar laparotomía exploradora
D) Repetir solo la evaluación primaria cada 5 minutos sin otro examen
E) Iniciar la evaluación secundaria antes de terminar la evaluación primaria

Respuesta A. La evaluación secundaria comienza solo cuando la primaria está completa y el paciente estabilizado. Incluye anamnesis dirigida, con alergias, medicamentos, antecedentes, última comida y mecanismo, y un examen de cabeza a pies, incluido el dorso con rotación en bloque, para pesquisar lesiones no evidentes.

4.01.5.016 Fibrobroncoscopía

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 18.8 Cuerpo Extraño en Vía Aérea: Maniobras de Desobstrucción según Edad & Broncoscopía

QUÉ HAY QUE SABER

- Fibrobroncoscopía: endoscopía de la vía aérea con broncoscopio flexible, diagnóstica y terapéutica.
- Indicaciones diagnósticas: sospecha de cáncer pulmonar (biopsia, cepillado, lavado), hemoptisis (localizar sangrado), atelectasia persistente, neumonía que no resuelve, TBC con baciloscopías negativas (lavado broncoalveolar), enfermedad intersticial, estridor.
- Terapéuticas: extracción de cuerpo extraño (en niños de elección la broncoscopía rígida), aspiración de secreciones o tapones mucosos, intubación difícil guiada, manejo de hemoptisis, stents.
- Contraindicaciones/riesgos: hipoxemia severa no corregida, inestabilidad hemodinámica, coagulopatía (para biopsias), IAM reciente; complicaciones: hipoxemia, broncoespasmo, sangrado, neumotórax (biopsia transbronquial).
- Nivel del perfil: indicar y derivar a broncopulmonar; interpretar el informe. Ante sospecha de cuerpo extraño en niño (tos súbita, sibilancias unilaterales, atrapamiento aéreo) derivar urgente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 64

Niño de 3 años presenta tos súbita, sibilancias unilaterales y disminución del murmullo pulmonar en el hemitórax derecho. Los padres refieren que estaba comiendo maní. La radiografía de tórax muestra hiperinsuflación derecha. **¿Cuál es el tratamiento definitivo?**

A) Broncoscopía virtual por TAC
B) Broncoscopía rígida con extracción del cuerpo extraño
C) Espirometría
D) TAC de tórax y observación
E) Antibióticos y kinesioterapia

Respuesta B. Tos súbita mientras comía maní, con sibilancias y murmullo disminuidos unilaterales e hiperinsuflación (efecto valvular), indica cuerpo extraño bronquial. El tratamiento definitivo es la broncoscopía rígida bajo anestesia general, que permite ventilar y extraer el objeto. La fibrobroncoscopía flexible es útil para diagnóstico; la broncoscopía virtual no es terapéutica.

4.01.5.017 Hemostasia con ligaduras y taponamiento de heridas sangrantes

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Primera medida en toda hemorragia externa: compresión directa firme y sostenida sobre la herida con gasas (no retirar las empapadas, agregar encima) y elevación de la extremidad.
- Taponamiento (packing) de heridas profundas o cavitarias (inguinal, axilar, cervical) con gasas, idealmente hemostáticas, seguido de compresión.
- Torniquete en hemorragia de extremidad que no cede con compresión: colocar 5-7 cm proximal a la herida (no sobre articulación), apretar hasta que cese el sangrado y desaparezca el pulso distal, anotar la hora; tolerancia

~2 h.

- Ligadura: pinzar solo vasos visualizados (no pinzar a ciegas por riesgo de dañar nervios), ligar con sutura absorbible; electrocoagulación en vasos pequeños. Agentes tópicos: adrenalina en anestésico local, hemostáticos de celulosa oxidada.
- Considerar coagulopatía (anticoagulantes, hepatopatía) y reanimación del paciente; derivar a cirugía sangrado arterial mayor, lesión vascular o persistente pese a medidas locales.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 30**
> Hombre de 28 años sufre un accidente con un vidrio y resulta con una herida cortante de 10 cm en el muslo izquierdo, que sangra profusamente. **¿Cuál es la mejor forma de manejar inicialmente la hemorragia?**
> **A)** Aplicación de torniquete
> **B)** Compresión directa de la herida
> **C)** Identificar y ligar el vaso sangrante
> **D)** Compresión de la arteria femoral
> **E)** Cubrir la herida con apósitos
> Respuesta B. La primera medida para controlar la hemorragia externa es la compresión directa y sostenida sobre la herida, que controla la gran mayoría de los sangrados. El torniquete se reserva para hemorragias de extremidades que no ceden con compresión directa o amenazan la vida. Pinzar o ligar vasos a ciegas en urgencia puede dañar nervios y estructuras vecinas.

4.01.5.018 Intubación traqueal

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: incapacidad de proteger la vía aérea (Glasgow ≤8), obstrucción o riesgo inminente (quemadura de vía aérea, trauma facial), falla respiratoria (hipoxemia o hipercapnia refractarias), paro cardiorrespiratorio, shock grave.
- Preparación (SOAP-ME): aspiración, oxígeno (preoxigenación al 100% por 3-5 min), vía aérea (laringoscopio, tubos 7-8 en mujer y 8-8,5 en hombre, guía, bougie), posición en olfateo, fármacos, monitoreo y equipo de rescate.
- Secuencia de intubación rápida: inducción (ketamina 1-2 mg/kg, etomidato 0,3 mg/kg o propofol) + relajante (succinilcolina 1-1,5 mg/kg o rocuronio 1,2 mg/kg); en trauma, estabilización cervical manual en línea.
- Confirmación: visualizar paso por cuerdas, capnografía (gold standard), auscultación bilateral y epigástrica, empañamiento; fijar a 21 cm (mujer) o 23 cm (hombre) en comisura labial; Rx: punta 3-5 cm sobre carina.
- Complicaciones: intubación esofágica, monobronquial derecha, hipoxemia, aspiración, trauma dental o laríngeo, hipotensión post inducción. Si falla tras intentos: dispositivo supraglótico y, si no se oxigena, cricotiroidotomía.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 90**
> Durante la reanimación de un paciente se realiza una intubación orotraqueal. **¿Cuál es el parámetro ideal para confirmar que el tubo quedó en la tráquea?**
> **A)** Pulsometría
> **B)** Auscultación pulmonar
> **C)** Capnografía
> **D)** Oximetría
> **E)** Expansión torácica
> Respuesta C. La capnografía con onda continua es el método más confiable para confirmar y monitorizar la posición del tubo en la tráquea, porque detecta CO2 espirado en cada ventilación. La auscultación y la expansión torácica pueden engañar (por ejemplo, en una intubación esofágica), y la oximetría cae tardíamente.

4.01.5.019 Intubación nasogástrica

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.12 Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: descompresión gástrica (obstrucción intestinal, íleo, pancreatitis grave, trauma), lavado gástrico seleccionado, administración de alimentación o fármacos, diagnóstico de HDA.
- Contraindicación: fractura de base de cráneo o trauma facial grave (riesgo de paso intracraneano: usar vía orogástrica), estenosis/cirugía esofágica reciente, ingesta de cáusticos; precaución en várices esofágicas y coagulopatía.
- Técnica: medir nariz-lóbulo de la oreja-apéndice xifoides (~50-60 cm adulto), lubricar, paciente sentado con cuello flectado, introducir por narina y pedir que trague (sorbos de agua).
- Confirmación: aspiración de contenido gástrico (pH <5), Rx de tórax/abdomen (de elección antes de alimentar; punta bajo el diafragma); auscultación de aire insuflado no es confiable. Tos, disnea o cianosis sugieren vía aérea: retirar.
- Cuidados: fijación, cuantificar y reponer pérdidas (alcalosis metabólica hipoclorémica e hipokalémica), permeabilidad, lesiones de ala nasal; complicaciones: sinusitis, epistaxis, aspiración, perforación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 35 años ingresa tras un accidente de tránsito con traumatismo encéfalo-craneano. Presenta equimosis periorbitaria bilateral (ojos de mapache), equimosis retroauricular y salida de líquido claro por la nariz. Se requiere descomprimir el estómago. **¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo?**

A) Sonda nasogástrica
B) Sonda nasoyeyunal
C) Sonda orogástrica
D) Gastrostomía percutánea de urgencia
E) No descomprimir el estómago

Respuesta C. Los signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, signo de Battle, rinorrea u otorraquia de líquido cefalorraquídeo) contraindican la instalación de sondas por vía nasal, por riesgo de que la sonda ingrese a la cavidad craneana a través de la lámina cribosa. En estos casos la descompresión gástrica se realiza por vía orogástrica.

4.01.5.020 Inyecciones subcutáneas, intramusculares e intravenosas

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- Subcutánea: tejido celular subcutáneo de abdomen periumbilical, brazo o muslo, ángulo de 45-90° con aguja corta (insulina, heparina de bajo peso molecular, vacunas como tresvírica); rotar sitios para evitar lipodistrofia.
- Intramuscular: deltoides (hasta 2-3 ml; vacunas en adultos), vasto lateral del muslo (sitio de elección en lactantes), ventroglúteo o cuadrante superoexterno del glúteo (evitar nervio ciático); ángulo de 90°.
- Intravenosa: bolo o infusión por vía venosa periférica permeable; verificar retorno venoso, velocidad adecuada, compatibilidad y dilución.
- Normas generales: los «5 correctos» (paciente, fármaco, dosis, vía, hora), higiene de manos, asepsia de la piel, registrar, preguntar por alergias, descartar cortopunzantes sin reencapuchar.
- Complicaciones: dolor, hematoma, absceso, lesión nerviosa (IM), extravasación y flebitis (IV), reacciones anafilácticas (tener adrenalina disponible: 0,01 mg/kg IM, máx 0,5 mg).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 2 meses acude al vacunatorio para recibir las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, incluida la hexavalente por vía intramuscular. **¿Cuál es el sitio de elección para la inyección intramuscular a esta edad?**

A) Región glútea, cuadrante superior externo
B) Músculo deltoides
C) Región ventroglútea
D) Cara anterolateral del muslo (vasto lateral)
E) Cara anterior del antebrazo

Respuesta D. En lactantes menores de 12 a 18 meses, el sitio de elección para inyecciones intramusculares es el vasto lateral, en la cara anterolateral del muslo, por su mayor masa muscular y ausencia de grandes vasos y nervios. El deltoides es pequeño a esta edad, y el glúteo se evita por riesgo de lesionar el nervio ciático.

4.01.5.021 Manejo de drenajes

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: cirugia-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Drenajes: pasivos (Penrose, por capilaridad y gravedad) o activos/aspirativos (Jackson-Pratt, Hemovac/Redon); abiertos o cerrados (menor infección). Tubo pleural es un drenaje con sello de agua.
- Objetivos: evacuar colecciones (sangre, bilis, pus, seroma), prevenir acumulación en espacio muerto y detectar precozmente complicaciones (sangrado, filtración anastomótica, fístula biliar o pancreática).
- Vigilancia diaria: cantidad (registrar débito cada turno), aspecto (hemático, serohemático, seroso, bilioso, purulento, intestinal/fecaloide), funcionamiento y permeabilidad, piel del sitio de salida.
- Signos de alarma: débito hemático abundante (>100-200 ml/h) o creciente, cambio a bilioso, fecaloide o purulento, fiebre → avisar al cirujano.
- Cuidados: fijar a piel, mantener el reservorio bajo el nivel de inserción y el vacío en los aspirativos, curaciones con técnica aséptica; retiro cuando el débito es mínimo (habitualmente <25-50 ml/día) y seroso, sin pinzar bruscamente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 6

Hombre de 76 años, con secuela de un accidente vascular encefálico, se alimenta mediante una gastrostomía realizada por vía endoscópica hace 2 meses. Accidentalmente se retiró la sonda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar radiografía simple de abdomen
B) Solicitar ecografía abdominal
C) Solicitar TAC de abdomen
D) Instalar una nueva sonda por el ostoma
E) Realizar una nueva gastrostomía

Respuesta D. Pasadas 4 a 6 semanas, el trayecto gastrocutáneo de una gastrostomía ya está maduro, por lo que ante un retiro accidental debe reinstalarse una sonda por el mismo ostoma lo antes posible, ya que el orificio puede cerrarse en pocas horas. Si el trayecto es reciente, el riesgo de falsa vía exige reinstalación bajo visión endoscópica o radiológica.

4.01.5.022 Manejo de vía aérea y columna cervical en trauma

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Asumir lesión de columna cervical en todo politraumatizado, especialmente con trauma por sobre las clavículas, TEC, alteración de conciencia o mecanismo de alta energía.
- Restricción de movimiento cervical: estabilización manual en línea por un ayudante durante cualquier maniobra; luego collar cervical rígido, inmovilizadores laterales y tabla espinal; movilizar en bloque.
- Apertura de vía aérea sin hiperextender: tracción mandibular (jaw thrust) o elevación del mentón; aspirar secreciones y sangre, retirar cuerpos extraños; cánula orofaríngea si inconsciente sin reflejo nauseoso (nasofaríngea contraindicada si sospecha de fractura de base de cráneo).
- Vía aérea definitiva si Glasgow ≤8, vía aérea en riesgo (quemadura, hematoma cervical expansivo, trauma facial grave), apnea o hipoxemia refractaria: intubación orotraqueal con secuencia rápida y estabilización en línea (retirar parte anterior del collar). Si fracasa: cricotiroidotomía.
- Oxígeno a alto flujo con mascarilla de no reinhalación (10-15 L/min). Retirar collar solo cuando se descarta lesión clínica (NEXUS/canadiense) o radiológicamente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 35 años, traída tras un volcamiento, está inconsciente y con ronquido. Se sospecha lesión de columna cervical. No tiene trauma facial ni sangre en la boca. **¿Cuál es la maniobra inicial más adecuada para permeabilizar la vía aérea?**

A) Hiperextensión del cuello con elevación del mentón
B) Intubación nasotraqueal a ciegas
C) Retirar el collar cervical para evaluar el cuello
D) Tracción mandibular manteniendo inmovilización manual alineada de la columna cervical
E) Colocar a la paciente en posición lateral de seguridad

Respuesta D. En trauma con sospecha de lesión cervical, la vía aérea se abre con tracción mandibular, o elevación del mentón sin extender el cuello, manteniendo la inmovilización manual alineada. La hiperextensión puede agravar una lesión medular. Si no se logra una vía aérea adecuada, se avanza a cánula y vía aérea definitiva.

4.01.5.023 Manejo ventilatorio básico

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Oxigenoterapia: meta SatO2 94-98% (88-92% en EPOC retenedor de CO2). Naricera 1-6 L/min (FiO2 ~24-44%), mascarilla simple 5-10 L/min, Venturi (FiO2 precisa 24-50%), mascarilla con reservorio 10-15 L/min (FiO2 ~60-90%); cánula nasal de alto flujo.
- Ventilación con bolsa-mascarilla (Ambú): sello en «C-E» con una o dos manos, cánula orofaríngea, 10 ventilaciones/min en adulto (1 cada 6 s), volumen que eleve visiblemente el tórax, evitar hiperventilar (distensión gástrica, aspiración).
- Ventilación no invasiva (CPAP/BiPAP): útil en EPOC exacerbado con acidosis respiratoria y edema pulmonar agudo; contraindicada si compromiso de conciencia, vómitos, inestabilidad o incapacidad de proteger la vía aérea.
- Ventilación mecánica invasiva básica: volumen corriente 6-8 ml/kg de peso ideal (protector), PEEP 5 cmH2O inicial, FiO2 para SatO2 objetivo, FR 12-20; controlar presión plateau <30 cmH2O y gases arteriales.
- Monitorizar con oximetría, capnografía, gases arteriales y clínica (trabajo respiratorio, conciencia).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 55 años es encontrado en apnea tras una intoxicación por opioides. Tiene pulso carotídeo palpable. Mientras se prepara la naloxona, usted inicia ventilación con bolsa-mascarilla y oxígeno. **¿Cuál es la técnica de ventilación más adecuada?**

A) Solo oxígeno por mascarilla de alto flujo, sin ventilar
B) 30 ventilaciones por minuto con el máximo volumen posible
C) 2 ventilaciones cada 30 compresiones torácicas
D) 1 ventilación por minuto para evitar hiperventilación
E) 1 ventilación cada 6 segundos (10 por minuto), con volumen suficiente para elevar visiblemente el tórax

Respuesta E. En un adulto en paro respiratorio con pulso, se ventila 1 vez cada 6 segundos, aproximadamente 10 por minuto, con volumen suficiente para elevar el tórax y durante 1 segundo cada una, sellando bien la mascarilla y abriendo la vía aérea con maniobra frente-mentón o tracción mandibular. La hiperventilación aumenta la presión intratorácica y la distensión gástrica.

4.01.5.024 Onicectomía

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: cirugia-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Onicectomía: extirpación parcial (borde lateral) o total de la uña; indicada en onicocriptosis estadio II-III o recurrente, onicogrifosis y trauma ungueal severo.
- Anestesia: bloqueo troncular digital con lidocaína 1-2% sin epinefrina; isquemia con banda elástica en la base del ortejo por tiempo breve (retirar siempre al terminar).

- Técnica de onicectomía parcial: despegar la lámina ungueal, cortar longitudinalmente el borde afectado (2-3 mm) hasta la matriz, extraer la espícula y destruir la matriz lateral (fenol 88% por 1-3 min o resección quirúrgica) para evitar recidiva; resecar tejido de granulación.
- Contraindicaciones relativas: insuficiencia arterial (evaluar pulsos/ITB), diabetes descompensada, coagulopatía; infección activa importante se trata primero (drenaje ± antibiótico).
- Postoperatorio: vendaje compresivo, elevación, analgesia, curaciones a las 24-48 h y luego según evolución; educación sobre corte recto de uñas y calzado amplio.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 30 años presenta su cuarto episodio en 1 año de onicocriptosis del borde lateral del ortejo mayor izquierdo, con dolor, secreción purulenta y tejido de granulación hipertrófico, pese a manejo conservador y cuidados adecuados. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
>
> **A)** Onicectomía parcial del borde afectado con matricectomía (quirúrgica o química con fenol)
> **B)** Antibiótico oral y repetir manejo conservador
> **C)** Onicectomía total sin tratar la matriz
> **D)** Amputación de la falange distal
> **E)** Antifúngico oral por 3 meses
>
> Respuesta A. La onicocriptosis recurrente o con granuloma se trata con onicectomía parcial del borde afectado, bajo anestesia troncular digital, asociada a destrucción de la matriz ungueal correspondiente (matricectomía quirúrgica o química con fenol) para evitar la recurrencia. La onicectomía total sin tratar la matriz tiene alta recidiva y peor resultado estético.

4.01.5.025 Paracentesis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en ascitis de reciente aparición, en todo cirrótico con ascitis que se hospitaliza o presenta fiebre, dolor abdominal, encefalopatía o deterioro (descartar PBE); terapéutica (evacuadora) en ascitis a tensión o refractaria.
- Técnica: vejiga vacía, sitio en fosa ilíaca izquierda (tercio externo entre ombligo y espina ilíaca anterosuperior), evitando cicatrices y vasos epigástricos; idealmente guiada por ecografía; asepsia, anestesia local, técnica en Z.
- Estudio del líquido: recuento celular (PMN ≥250/mm³ = PBE → cefotaxima/ceftriaxona + albúmina), proteínas, albúmina para GASA (≥1,1 g/dl hipertensión portal; <1,1 carcinomatosis, TBC, pancreática), cultivo en frascos de hemocultivo, citología, ADA, amilasa.
- Paracentesis evacuadora >5 L: reponer albúmina 6-8 g por cada litro extraído para prevenir disfunción circulatoria post paracentesis.
- Coagulopatía de la cirrosis no contraindica (salvo CID o fibrinólisis evidentes); contraindicaciones relativas: infección de pared, distensión intestinal masiva, embarazo. Complicaciones: filtración de líquido, hematoma, perforación intestinal.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 60 años con cirrosis y ascitis a tensión refractaria a diuréticos. Se realiza una paracentesis evacuadora, extrayendo 7 litros de líquido ascítico sin incidentes. **¿Qué medida es fundamental para prevenir la disfunción circulatoria postparacentesis?**
>
> **A)** Administrar furosemida endovenosa en dosis altas
> **B)** Administrar albúmina endovenosa, 6 a 8 g por litro extraído
> **C)** Administrar 3 litros de suero fisiológico
> **D)** Restringir completamente el sodio por 48 horas
> **E)** No se requiere ninguna medida adicional
>
> Respuesta B. En paracentesis de más de 5 litros se debe reponer albúmina endovenosa, 6 a 8 g por cada litro extraído, para prevenir la disfunción circulatoria postparacentesis, que se asocia a hiponatremia, insuficiencia renal (síndrome hepatorrenal) y mayor mortalidad. Los cristaloides son menos eficaces como expansores en este contexto.

4.01.5.026 Drenaje pleural

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 11.10 Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones del tubo pleural: neumotórax a tensión (tras descompresión con aguja), neumotórax traumático o grande/sintomático, hemotórax, empiema o derrame paraneumónico complicado, quilotórax, neumotórax en ventilación mecánica.
- Sitio: 4°-5° espacio intercostal entre línea axilar anterior y media («triángulo de seguridad»), sobre el borde superior de la costilla inferior para evitar el paquete vasculonervioso.
- Técnica: asepsia, anestesia local, incisión, disección roma, exploración digital del espacio pleural, introducción del tubo (28-32 Fr en hemotórax de trauma; menores en neumotórax), conexión a sello de agua y fijación; Rx de control.
- Vigilar: oscilación (permeabilidad), burbujeo (fuga aérea), débito; hemotórax >1500 ml inicial o >200 ml/h por 2-4 h indica toracotomía. Nunca pinzar un tubo que burbujea.
- Nivel del perfil: reconocer la indicación y derivar al especialista (cirujano); el médico general debe descomprimir con aguja un neumotórax a tensión.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años con herida por arma blanca en el hemitórax derecho, hemodinámicamente estable. La radiografía de tórax muestra un hemotórax moderado. Se decide instalar un tubo de drenaje pleural. **¿Cuál es el sitio y la técnica correctos de inserción?**

A) Segundo espacio intercostal, línea medioclavicular, por el borde inferior de la costilla superior
B) Cuarto espacio intercostal paraesternal, junto al esternón
C) Octavo espacio intercostal, línea escapular, por el borde inferior de la costilla
D) Quinto espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media, por el borde superior de la costilla inferior
E) Cualquier espacio intercostal donde se palpe mejor el derrame

Respuesta D. El tubo pleural se instala en el triángulo de seguridad: quinto espacio intercostal, entre las líneas axilares anterior y media, rasando el borde superior de la costilla inferior, porque el paquete vasculonervioso corre por el borde inferior de cada costilla. El segundo espacio medioclavicular es el sitio de punción descompresiva clásica.

4.01.5.027 Punción venosa

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: cirugia-21

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: toma de muestras sanguíneas, instalación de vía venosa periférica para fluidos, fármacos y transfusiones.
- Sitios: venas del pliegue del codo (cubital media, cefálica, basílica) para muestras; antebrazo y dorso de la mano para catéteres. Evitar extremidad con fístula AV, vaciamiento axilar, linfedema, flebitis o infección.
- Técnica: higiene de manos y guantes, ligadura 7-10 cm proximal, asepsia con alcohol 70% o clorhexidina, punción con bisel hacia arriba a 15-30°, confirmar reflujo, avanzar catéter retirando la aguja, soltar la ligadura, fijar y registrar.
- Calibre según necesidad: 14-16 G en trauma/shock (mayor flujo: catéter corto y grueso), 18-20 G uso general, 22-24 G en niños/venas finas.
- Complicaciones: hematoma, flebitis, extravasación, infección, punción arterial. Cambiar catéter periférico según protocolo o ante signos de flebitis; si no se logra acceso en emergencia, vía intraósea.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un interno realiza una punción venosa en el pliegue del codo para tomar exámenes de sangre a un paciente adulto. **¿Cuál de las siguientes prácticas es correcta?**

A) Mantener la ligadura más de 3 minutos para mejorar el llenado venoso
B) Reencapuchar la aguja con ambas manos después de la extracción
C) Puncionar sobre una zona con hematoma reciente
D) Pedir al paciente que abra y cierre el puño repetidamente durante toda la extracción
E) Introducir la aguja con el bisel hacia arriba, en ángulo de 15 a 30 grados, y soltar la ligadura antes de retirarla

Respuesta E. La punción venosa se realiza con el bisel hacia arriba, en un ángulo de 15 a 30 grados, y se suelta la ligadura antes de retirar la aguja para evitar hematomas. La ligadura no debe mantenerse más de 1 minuto, y el bombeo del puño produce falsa hiperkalemia. Nunca se reencapucha la aguja.

4.01.5.028 Resucitación cardiorrespiratoria

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Paro Cardiorrespiratorio & Algoritmos ACLS / MINSAL

QUÉ HAY QUE SABER

- Cadena de supervivencia: reconocer el paro (no responde, no respira o solo jadea, sin pulso en ≤10 s), activar el sistema de emergencia, RCP precoz, desfibrilación precoz, soporte avanzado y cuidados post paro.
- Compresiones de alta calidad: centro del tórax, 100-120/min, profundidad 5-6 cm en adulto (1/3 del diámetro AP en niños), permitir reexpansión completa, interrupciones <10 s, cambiar reanimador cada 2 min.
- Relación compresión:ventilación 30:2 en adulto (15:2 con 2 reanimadores en niños); con vía aérea avanzada, compresiones continuas y 1 ventilación cada 6 s. Lego no entrenado: solo compresiones.
- Desfibrilador: colocar en cuanto esté disponible; FV/TV sin pulso → descarga (bifásico 120-200 J; niños 2-4 J/kg) seguida inmediatamente de 2 min de RCP; adrenalina 1 mg IV/IO cada 3-5 min; amiodarona 300 mg tras la 3ª descarga.
- Asistolia/AESP: RCP + adrenalina precoz y tratar causas reversibles (5H y 5T). Terminar esfuerzos según criterio clínico tras RCP prolongada sin respuesta; registro de tiempos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 60 años colapsa en la calle. No responde y no respira normalmente. Usted pide ayuda, solicita un desfibrilador externo automático e inicia la reanimación cardiopulmonar. **¿Cuáles son las características correctas de las compresiones torácicas en el adulto?**

A) Frecuencia de 60 a 80 por minuto, profundidad de 2 a 3 cm
B) Frecuencia de 150 por minuto, profundidad de 8 cm
C) Frecuencia de 100 a 120 por minuto, profundidad de 5 a 6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax, con relación 30:2
D) Relación 15:2 con pausas largas para evaluar pulso cada minuto
E) Frecuencia de 100 por minuto sobre el tercio superior del esternón

Respuesta C. Las compresiones de alta calidad en el adulto se realizan en la mitad inferior del esternón, a 100 a 120 por minuto, con profundidad de 5 a 6 cm, permitiendo la reexpansión completa del tórax y minimizando interrupciones; sin vía aérea avanzada, la relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. La relación 15:2 corresponde a 2 reanimadores en niños.

4.01.5.029 Punción pleural

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

QUÉ HAY QUE SABER

- Toracocentesis diagnóstica: todo derrame pleural nuevo de causa no evidente (>1 cm en decúbito lateral o ecografía); evacuadora: derrame sintomático (disnea).
- Técnica: paciente sentado inclinado hacia adelante, punción en línea axilar posterior o escapular 1-2 espacios bajo el nivel de matidez (no bajo el 8°-9° espacio), sobre el borde superior de la costilla; idealmente guiada por ecografía; asepsia y anestesia local.

- Análisis: aspecto, proteínas y LDH (criterios de Light con valores séricos), glucosa, pH, recuento celular y diferencial, Gram y cultivo, ADA (TBC), citología; triglicéridos si aspecto lechoso.
- No extraer más de 1-1,5 L por sesión (riesgo de edema pulmonar por reexpansión); suspender si tos, dolor torácico o disnea.
- Complicaciones: neumotórax (Rx de control si síntomas o aspiración de aire), hemotórax, lesión hepática/esplénica, reacción vasovagal, infección. Contraindicaciones relativas: coagulopatía grave, infección de la pared.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 65 años con un derrame pleural derecho moderado requiere una toracocentesis diagnóstica. Se ubica sentada, inclinada hacia adelante, y se identifica el nivel del derrame por percusión y ecografía. **¿Dónde debe introducirse la aguja respecto de la costilla?**

A) Por el borde inferior de la costilla superior
B) En el segundo espacio intercostal, línea medioclavicular
C) Por el centro del cuerpo costal
D) Por el borde superior de la costilla inferior
E) Por cualquier borde, ya que no hay estructuras relevantes

Respuesta D. El paquete vasculonervioso intercostal (vena, arteria y nervio) transcurre por el surco del borde inferior de cada costilla. Por eso la punción pleural se realiza rozando el borde superior de la costilla inferior del espacio elegido, habitualmente en la línea axilar posterior, uno o dos espacios bajo el nivel del derrame, idealmente guiada por ecografía.

4.01.5.030 Traqueostomía y cricoidostomía

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Traqueostomía: vía aérea quirúrgica a través de los anillos traqueales (2°-4°), procedimiento electivo o semielectivo; indicada en ventilación mecánica prolongada (>7-14 días), obstrucción de vía aérea superior crónica (tumores, parálisis de cuerdas), manejo de secreciones y apnea obstructiva grave.
- Cricotiroidotomía: vía aérea quirúrgica de urgencia a través de la membrana cricotiroidea (más rápida, superficial y con menos sangrado); temporal, convertir a traqueostomía en 24-72 h.
- Traqueostomía percutánea (en UCI) o abierta (pabellón); complicaciones: sangrado, enfisema subcutáneo, neumotórax, falsa vía, decanulación accidental, infección, estenosis traqueal, fístula traqueoesofágica o traqueoinnominada (sangrado masivo).
- Cuidados de la traqueostomía: aspiración de secreciones con técnica estéril, humidificación, curación del estoma, control de presión del cuff (20-30 cmH2O), cánula de repuesto y obturador junto al paciente.
- Nivel del perfil: la traqueostomía la realiza el especialista; el médico general reconoce la indicación, maneja la cánula obstruida o desplazada y deriva.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con neumonía grave lleva 14 días en ventilación mecánica invasiva por tubo orotraqueal, con varios intentos fallidos de desconexión. Se estima que requerirá soporte ventilatorio prolongado. **¿Cuál es el procedimiento más adecuado para su vía aérea?**

A) Cricotiroidotomía quirúrgica
B) Mantener indefinidamente el tubo orotraqueal
C) Traqueostomía electiva
D) Punción cricotiroidea con aguja
E) Cambio a mascarilla laríngea

Respuesta C. En pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada, la traqueostomía electiva, quirúrgica o percutánea, facilita el destete, mejora el confort, la higiene oral y la aspiración de secreciones, y disminuye el daño laríngeo por intubación prolongada. La cricotiroidotomía es un procedimiento de urgencia para el escenario de no intubable y no oxigenable, y debe convertirse luego en traqueostomía.

4.01.5.031 Traslado del traumatizado

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Antes del traslado: estabilizar según ABCDE (vía aérea segura, ventilación, control de hemorragia, accesos venosos, inmovilización espinal y de fracturas), sin retrasar el traslado de un paciente que requiere cirugía.
- Inmovilización: collar cervical rígido, tabla espinal o colchón de vacío, inmovilizadores laterales y correas; movilizar en bloque (maniobra de rodado con 3-4 personas); férulas en fracturas de extremidades y faja pelviana si fractura de pelvis inestable.
- Elegir el destino según recursos necesarios (centro de trauma), no por cercanía; comunicación médico a médico previa, con resumen clínico y tratamiento realizado.
- Durante el traslado: monitoreo continuo (signos vitales, oximetría, Glasgow), oxígeno, fluidos tibios, prevención de hipotermia, personal capacitado y equipamiento para manejo de vía aérea.
- Documentación: registro de hora del trauma, mecanismo, hallazgos, intervenciones (incluida hora de torniquete), fármacos y evolución; embarazada en decúbito lateral izquierdo (inclinar la tabla).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 25 años, víctima de un volcamiento, se encuentra consciente, con dolor cervical y parestesias en ambas manos. El equipo prehospitalario debe extraerla y trasladarla al servicio de urgencia. **¿Cuál es la forma más adecuada de traslado?**

A) Sentada en el asiento del vehículo de emergencia
B) Inmovilización con collar cervical rígido y tabla espinal, movilizándola en bloque
C) Permitir que camine hasta la ambulancia si puede hacerlo
D) Trasladarla en decúbito lateral sin collar
E) Retirar el casco y el collar para facilitar la evaluación durante el traslado

Respuesta B. Ante sospecha de lesión de columna (mecanismo de alta energía, dolor cervical, síntomas neurológicos), la paciente debe trasladarse con restricción de movimiento espinal: collar cervical rígido, tabla espinal o camilla de cuchara, y movilización en bloque con varios rescatadores, manteniendo la alineación del eje cabeza-cuello-tronco hasta descartar la lesión en el hospital.

4.01.5.032 Vendajes e inmovilizaciones con férulas

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivos: inmovilizar fracturas, luxaciones reducidas y esguinces para aliviar dolor, evitar lesión neurovascular adicional y facilitar el traslado; incluir la articulación proximal y distal.
- Tipos: férulas de yeso o fibra (valvas), férulas prefabricadas, cabestrillo, vendaje elástico compresivo, vendaje funcional; yeso circular solo cuando ya no se espera edema (riesgo de síndrome compartimental).
- Evaluar y registrar estado neurovascular distal (pulso, llene capilar, sensibilidad, motilidad) antes y después de inmovilizar; inmovilizar en posición funcional.
- Signos de alarma: dolor desproporcionado (sobre todo a la extensión pasiva de los dedos), parestesias, palidez, frialdad → retirar o abrir vendaje/yeso de inmediato y evaluar síndrome compartimental.
- Nivel del perfil: inmovilización provisoria y derivación a traumatología para tratamiento definitivo; indicar elevación, frío local y analgesia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años sufre una fractura de radio distal no desplazada hace 3 horas. Presenta edema moderado de la muñeca y antebrazo. Se decide tratamiento ortopédico. **¿Cuál es la inmovilización inicial más adecuada?**

A) Yeso circular cerrado ajustado
B) Sin inmovilización, con analgesia
C) Vendaje elástico compresivo exclusivo
D) Férula (valva) de yeso antebraquiopalmar, no circular, con extremidad elevada
E) Yeso braquiopalmar circular cerrado

Respuesta D. En una fractura aguda con edema, la inmovilización inicial debe ser una férula o valva no circular, que inmoviliza las articulaciones vecinas y permite el aumento de volumen sin comprimir, previniendo un síndrome compartimental. Se indica elevar la extremidad, mover los dedos y vigilar dolor y perfusión; el yeso circular se coloca cuando cede el edema.